

Grilla oficial o respuesta confirmada

discutida en grupos (al final de las preguntas = dx, adentro de las preguntas comentarios importantes)

Killer

Fuente

EFUS 2019

OCTUBRE 2019

GRILLA OFICIAL

1 - Milo tiene **1 año y 3 meses** de vida, es sano, se alimenta con dieta general (comidas saludables y seguras) más pecho por la mañana y por la tarde, la madre **suspendió la administración de vitaminas ADC y de sulfato ferroso hace un mes.**

Actualmente Milo se encuentra en percentilo 10 de peso y talla, el control del año también tenía los mismos percentilos, habiendo aumentado 300 gramos los últimos 3 meses. La mamá mide 1,55 M y el papá 1,67 M. En el último tiempo no tuvo problemas de salud.

Presenta carnet **de vacunas completo hasta el año de vida.**

Pregunta: Le consulta a usted sobre los cuidados de Milo y las conductas a seguir. Ud. Sugiere y explica: (Marque hasta 4 opciones)

a) **Enriquecer las comidas con crema de leche, manteca y queso untable.** (No, porque no hay indicación)

b) **Solicitar hemograma, determinación de IgA e IgA antitransglutaminasa.** (No, porque no hay contexto)

c) **Indicar nuevamente vitaminas y hierro hasta los 18 meses.** (No, hasta 1 año)

d) **Interconsulta con nutrición infantil.**

e) **Explica que el crecimiento de Milo es normal para su edad.**

f) **Reducir la lactancia dado que probablemente interfiera con la correcta alimentación.**

g) **Refuerza pautas de alimentación saludable y mantiene pecho materno.**

h) **Indica vacuna anti-varicela y antimeningocócica.**

i) **Da pautas de prevención sobre lesiones no intencionales.**

j) Solicita radiografía de muñeca izquierda para evaluar edad ósea. (NO, tiene crecimiento adecuado para edad)

2 - Tomy, de **17 meses y medio**, concurre a control en salud en el mes de octubre. Es un RNT, 40 semanas de edad gestacional, hijo de **madre diabética**. No presenta otros antecedentes perinatológicos de importancia. **Peso y talla al nacer en percentilo 97.**

Ambos padres son sanos. El **padre fuma**, según referencia materna, “solamente fuera de casa”.

Tomy inició **jardín maternal a los 11 meses** de vida con buena adaptación.

Al examen físico el niño presenta **rinorrea anterior y posterior, fauces eritematosas, sin presencia de exudado, adenomegalias latero-cervicales móviles no dolorosas**. Se encuentra **afebril** y refiere la madre que “vive resfriado desde que empezó el jardín”. El resto del examen físico es normal. **No presenta nódulo de BCG.**

Según consta en la historia clínica, **se controló en este hospital una única vez a los 8 meses de vida**. Los controles **previos a los 8 meses los hizo en un centro de salud de su barrio.**

A los 8 meses completó el esquema de vacunación que tenía atrasado y luego de esa ocasión no volvió a ser evaluado por un pediatra y **no recibió nuevas vacunas**. Al interrogar a la madre por qué no concurreó a los controles, ella le explica que no contaba con los medios para pagar el viaje al hospital y que en la salita de su barrio “no están dando turnos”.

Pregunta: ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta? (Marque hasta 3 opciones)

a) BCG

b) Contraindica la vacunación hasta superar el cuadro respiratorio. KILLER

c) Interconsulta con inmunología. (No, no es necesario)

d) Sabin y Triple bacteriana acelular.

e) Triple viral, hepatitis A, antineumocócica conjugada.

f) Reiniciar el plan de vacunación dado el tiempo transcurrido. (No, no es necesario, solamente se continua el esquema)

g) Antivaricela y antimeningocócica conjugada.

h) Hepatitis B y antigripal.

i) Sabín y Cuádruple / Pentavalente. (Ojoooo Sabín no se da más y si la SALK)

j) Difiere la vacunación con Antivaricela y Triple viral por 4 semanas.

3 - Ud. atiende en su consultorio a Pablo un **neonato de 14 días** de vida que concurre para control. Es un nacido de **término**, de un **embarazo controlado y sin patologías del embarazo**. Pesó 2800 grs al nacer y fue **dado de alta al 3° día con 2600 grs.** Las **vacunas están completas**. Se alimenta con **lactancia materna exclusiva**. **Presenta deposiciones**

diarias color amarillo oro y la diuresis está conservada. Al examen físico se encuentra vigoroso, con **ictericia en cara**, no se auscultan soplos cardíacos, el abdomen es blando y sin visceromegalias. El **peso actual** es de **2780 grs.**

Pregunta: ¿Cuáles son las conductas más adecuadas? (Marque hasta 3 opciones) **Sospecha ictericia fisiológica por lactancia materna, porque el RN se encuentra bien, subió de peso, la ictericia sólo de cara, que puede darse por mala técnica de amamantamiento o por proteína beta glucoronidasa de la leche)**

- a) Suplementar con fórmula de inicio.
- b) Solicitar orina completa y urocultivo.
- c) Solicitar serologías. (embarazo controlado y sin patologías del embarazo.)
- d) Citar a control de peso.**
- e) Promover la lactancia materna exclusiva.**
- f) Suplementar con sulfato ferroso. (a partir de 4 meses porque es un RNT)
- g) Solicitar dosaje de bilirrubina.
- h) Evaluar técnica de amamantamiento.**
- i) Solicitar hepatograma, hemograma y Coombs.
- j) Indicar metoclopramida a la madre para aumentar la producción láctea.

4 - Jacinto es un paciente de **12 años y 10 meses**, que concurre al pediatra con su madre porque nota que en el último año sus compañeros lo han superado en altura. Refiere estar **muy preocupado por su talla** y se compara constantemente con sus compañeros, aunque no lo molestan ni le hacen bullying. A su vez la madre refiere que los hermanos mayores a su misma edad habían alcanzado mayor talla.

Antecedentes: parto cesárea, Apgar 9/10 **7-10**; PN 3200 grs, longitud: 50 cm. **Epilepsia tratada desde los 4 años con ácido valproico, sin crisis epilépticas en el último tiempo.** Desde pequeño **era selectivo con la comida y siempre fue delgado, aunque ahora come abundante y ha aumentado de peso.** El último peso y talla es de hace un año donde se encontraba en **Peso y Talla en Pc 10-25.**

El niño no consume drogas, ni alcohol. Su **padre es sano y mide 170 cm tuvo desarrollo puberal normal, la madre es sana y mide 165 cm, tuvo su menarca a los 14 años.** Los **2 hermanos mayores de 15 y 17 años**, ambos con talla normal (**Pc 50**) sin retraso puberal.

Pregunta: Además del examen físico completo, con los datos obtenidos cuáles son las conductas iniciales más adecuadas? (Marque hasta 3 opciones)

Observaciones: Variantes de la normalidad de crecimiento flor _co 158

- a) Calcular la Talla Objetivo Genética.**
- b) Indicar dieta suplementaria hiperproteica y deportes de alto impacto.

c) Valoración de talla y estadio de desarrollo puberal.

- d) Valorar la edad ósea. (No, no hay indicación- criterio)
- e) Solicitar estudios parasitológicos en materia fecal.
- f) Interconsulta con endocrinología.
- g) Solicitar determinación de IgA sérica e IgA antitransglutaminasa.
- h) Solicitar TSH y T4 libre.

i) Realizar curva de velocidad de crecimiento.

- j) Suspender el ácido valproico.

5 - Ud se encuentra otorgando el **alta de lán**, un recién nacido de **39 semanas** de edad gestacional, que pesó **2500 gr** al nacer, peso actual 2400 gr. La familia está formada por **madre, padre y dos hermanitos que concurren a la escuela**, uno de ellos está con fiebre y cursando una **virosis respiratoria**.

Pregunta: **Además de aconsejar y supervisar la técnica de lactancia**, cuáles son las **conductas adecuadas en este momento?** (Marque hasta 3 opciones)

a) Verificar que se haya realizado la pesquisa metabólica neonatal.

- b) Postergar la realización de la pesquisa neonatal en virtud del peso del bebé.

c) Verificar la aplicación de vacuna de hepatitis B y demorar la BCG hasta alcanzar los 3000 gramos de peso.

KILLER

d) Verificar la aplicación de vacuna de Hepatitis B en el momento del nacimiento y aplicar BCG antes del alta.

- e) Indicar a lán vacuna antigripal antes del alta. (a partir de los 6 meses)
- f) Indicar que incorporen **en los primeros días de vida** el chupete. (no, no están indicados en los primeros 15 días)
- g) Indicar colocarlo a dormir en posición supina.**

- h) Recomendar que duerma inicialmente en **otra** habitación.
- i) Instruir a la familia **cómo retirar** e higienizar el prepucio desde los primeros días de vida.
- j) Sugerir que el hermano enfermo permanezca en el domicilio de un familiar hasta el alta.

6 - Kiara de **14 años** de edad , refiere **dolor en hemiabdomen derecho de características cólicas**, de 16 horas de evolución, se encuentra inapetente, **presentó 2 deposiciones desligadas, escasas en el día de la consulta, refiere disuria y tuvo 3 vómitos en la última hora**. En el momento del examen físico, **refiere un dolor moderado**. La paciente se encuentra en regular estado general, temperatura **38,3°C**. La palpación abdominal muestra un abdomen levemente distendido, dolor generalizado a predominio en **fosa ilíaca derecha con compresión dolorosa**. Puño percusión lumbar bilateral negativa. El resto de la exploración física es normal. Antecedentes: **menarca a los 12 años**,

ciclos irregulares, FUM hace 2 semanas aproximadamente. inicio de relaciones sexuales hace 1 año, refiere cuidarse casi siempre con preservativo.

Pregunta: De acuerdo a su diagnóstico presuntivo ¿cuáles son las conductas iniciales más apropiadas? (Marque hasta 4 opciones) Sospecha DX de Apendicitis flor_co pagina78, embarazo ectopico, nefrolitiasis

a) Realizar prueba de tolerancia oral.

b) Ecografía abdominal y ginecológica.

c) Indicar metoclopramida.

d) Examen ginecológico.

e) Orina completa y urocultivo.

f) Hemograma, PCR, 2 hemocultivos, urea, creatinina.

g) Hemograma, PCR, coagulograma, BHCG. (Coagulograma si pienso que es apendicitis y necesita de cx).

h) Solicitar cultivo de flujo vaginal. (No, porque no hay contexto)

i) Coprocultivo y parasitológico en fresco y seriado de materia fecal. (No, porque no hay contexto)

j) Tomografía abdomino-pélvica. (No, porque el primero que se solicitaria seria una ECO)

7 - Emilio de 1 mes y 17 días de vida asiste a guardia junto a sus padres, Claudia y Marcos. Refieren que Emilio, único hijo, hace 12 horas está decaído y presentaba vómitos postprandiales desde hace 1 semana. Toma pecho con mayor avidez. En las últimas horas presentó 4 vómitos en chorro. Siempre afebril.

Como antecedentes, Emilio es un recién nacido de término de peso adecuado para la edad gestacional (3100 gr), nacido por parto vaginal en presentación cefálica. Estuvo 4 días internado en neonatología por hiperbilirrubinemia y requerimiento de luminoterapia. Luego fue dado de alta. Caída del cordón umbilical a los 10 días de vida. Pesquisa neonatal: no fue retirada. Se alimenta actualmente solo a pecho a libre demanda.

Peso al mes de vida: 3700 gr.

Al examen físico: se encuentra en regular estado general, presenta fontanela deprimida, leve en cara ictericia. Frecuencia cardíaca 180 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 45 respiraciones por minuto, Sat 98% aire ambiental, T° 36.9 C, mucosas secas, diuresis disminuida en las últimas horas, hemodinámicamente compensado. Buena entrada de aire bilateral, murmullo vesicular conservado, sin ruidos agregados. Abdomen blando, depresible, indoloro, ruidos hidroaéreos positivos. Resto del examen físico s/p.

Peso actual: 3750 gr.

Pregunta: De acuerdo a su hipótesis diagnóstica, ¿cuál es la conducta diagnóstica adecuada? (Marque hasta 3 opciones) DX : Estenosis Hipertrofica del piloro flor_co 77

a) Ecografía abdominal.

b) EAB, ionograma, glucemia, urea, creatinina.

c) Interconsulta por cirugía infantil.

d) Hemograma, PCR, procalcitonina.

e) 2 hemocultivos.

f) Orina completa y urocultivo.

g) Punción lumbar para citoquímico y cultivo. KILLER

h) pHmetría de 24 horas.

i) Ecografía renovesical.

j) Interconsulta con gastroenterología.

8 - Concorre a la guardia José de **12 años** de edad que consulta por **dolor exquisito y puntual** en una zona ubicada en el **1/ 3 inferior del muslo derecho e impotencia funcional y fiebre durante las últimas 48 horas**. Como antecedente refiere haber sufrido un **traumatismo hace 7 días jugando al fútbol**. En el examen físico se observa área de **tumefacción con una lesión en piel del 1/3 inferior del muslo derecho, cubierta actualmente por una costra hemática, evaluación de la articulación de la rodilla normal**. Laboratorio: Hemograma: **16800/mm3 leucocitos (80% NS 35-60, 3% NC 0-5%, 10% L, 7% M)**, hemoglobina 12,4 gr/dl, **plaquetas 550.000/mm3, eritrosedimentación 80 mm/h, PCR 60 mg/l**. Radiografía de ambos miembros inferiores comparativa sin lesiones óseas.

Pregunta: Además de indicar analgesia, de acuerdo a su diagnóstico presuntivo, cuáles son las conductas iniciales más adecuadas? (Marque hasta 3 opciones) **Artritis séptica Flo _ co 114**

a) Internación, 2 hemocultivos y tratamiento antibiótico endovenoso.

b) Control ambulatorio en 48hs y tratamiento con cefalexina vía oral. KILLER

c) Inmovilización, analgesia y control ambulatorio en 48 horas. KILLER

d) Solicitar resonancia magnética del miembro.

e) Solicitar ecografía de partes blandas.

f) Solicitar tomografía computada del miembro.

g) Toma de cultivo por piel sana de la costra. (No, porque el cultivo se hace del líquido articular)

h) Solicitar centellograma corporal total. (No, no es conducta inicial)

i) Exploración **quirúrgica de urgencia**.

j) Solicitar CPK y Aldolasa. (No, porque el pte tiene artritis séptica no estoy sospechando de afectación muscular)

9 - Bruno de **5 años** de edad, concorre con su mamá al Centro de atención primaria de su barrio porque según ella refiere, **no le entran los zapatos de uso habitual -edema**. Comenzó **8 días antes con falta de apetito, malestar**

general, deposiciones desligadas y estornudos, por lo cual le administró ibuprofeno, sin una periodicidad fija. Nos cuenta que tiene los ojos un poco hinchados desde ayer, dolor alrededor del ombligo y que orina poco. Al examen físico presenta un peso en Pc 25 y talla en Pc 10, TA 85/60 mm/Hg (Pc 95 = 105/65), frecuencia cardíaca 88 latidos/minuto 90-120, frecuencia respiratoria 32 respiraciones/minuto 15-25 y T° 36 °C, edema bipalpebral y pretibial con godet ++ y abdomen globuloso. Actualmente se alimenta a predominio de carbohidratos, con poca ingesta de proteínas. Las vacunas refiere que están completas. Antecedentes familiares: 2 hermanos menores en tratamiento para escabiosis. Exámenes complementarios iniciales: Hematocrito 28% (34 -44), hemoglobina 9,3 g/dl 11-13,5, Leucocitos 6500/mm3 7-13 (NS 42% E 3% B 0% L 55 %), Plaquetas 254.000/mm3, Urea: 75 mg/dl 10 -40, Creatinina: 0,5 mg/dL, Proteínas Totales: 4,2 g/dL, Albúmina 2,3 g/dL, Colesterol 360 mg/dL hasta 200, TGP. 48 UI/l 37, .TGO. 32 UI/l., Bilirrubina total: 0,5 mg/dl, Bilirrubina directa: 0,2 mg/dl.

La ecografía abdominal es informada como normal. ECG sin particularidades. Radiografía de tórax dentro de límites normales. En orina: Proteinuria ++++ (+ de 500 mg/dL), hemoglobina +. El sedimento urinario: 0-3 leucocitos/campo hasta 10 - 7-9 hematíes /campo . Hormonas tiroideas, cuyo resultado está pendiente. Pendientes también estudios para descartar enfermedad celíaca y síndrome de malabsorción.

Pregunta: Ante estos resultados, los razonamientos clínicos más adecuados son: (Marque hasta 4 opciones) pcte con anemia, dislipemia, edema, Disfx renal, hematuria sospecha dx de sme nefrotico Flor_co 92

- a) La hipoalbuminemia e hipercolesterolemia se deben a un déficit de síntesis hepática.
- b) La hipoalbuminemia se debe a un síndrome de malabsorción.
- c) El mixedema y urea elevada se deben a hipotiroidismo.
- d) La elevación de la urea se debe a un síndrome nefrítico secundaria a la escabiosis de ambos hermanos.
- e) La eosinofilia confirma edema de etiología alérgica secundaria al antitérmico suministrado.
- f) La proteinuria asociada a hipoalbuminemia explican los edemas.
- g) La ecografía abdominal normal aleja la posibilidad de peritonitis primaria como causa del dolor abdominal.
- h) El aumento de la urea se debe a contracción de volumen corporal total.
- i) La elevación de la urea se debe a disminución del volumen arterial efectivo circulante.
- j) El laboratorio confirma una anemia.

10 - Horacio y Ana traen a su consultorio por primera vez a su hijo Mario, de 3 años y medio de edad, para control. Mario es el primer hijo de un embarazo controlado. Nació a las 40 semanas de edad gestacional con 3500 gramos por parto vaginal con presentación cefálica. Lloró enseguida. Alta conjunta a las 48 horas con lactancia materna. Fue internado a la semana por mal progreso de peso y succión débil. Completó 10 días de tratamiento antibiótico parenteral con hemocultivos, urocultivo y cultivo de LCR negativos. Egresó a los 21 días de internación con alimentación enteral por sonda nasogástrica, que mantuvo durante tres meses.

Mario sostuvo la cabeza al 3° mes, se sentó a los 8 meses, no gateó y caminó a los 17 meses. No controla esfínteres.

Actualmente asiste a una sala de 3 años; los padres fueron citados porque **hace muchos berrinches y habla muy poco.**

Inmunizaciones: 1 dosis vacuna hepatitis B, 1 dosis vacuna BCG, 2 dosis vacuna inactivada para la polio, 2 dosis vacuna oral para la polio, 4 dosis vacuna DPT-HB-Hib, 3 dosis vacuna neumococo, 3 dosis vacuna meningococo, 1 dosis vacuna triple viral, 1 dosis hepatitis A y 1 dosis vacuna para la varicela.

Entre los antecedentes familiares: Horacio 41 años con **aorta bicúspide**, Ana 27 años con hipotiroidismo por tiroiditis de Hashimoto diagnosticada después del nacimiento de Mario.

Antropométricamente: Peso 20 kilos (**>pc 97**), talla 104 cm (pc 97), **IMC mayor a pc 97** **obesidad**, perímetro cefálico 51 cm (pc 50). Signos vitales: Frecuencia cardíaca 120 por minuto, TA 90/60 mm/Hg, **frecuencia respiratoria 16 por minuto**, oximetría 97 % a aire ambiental.

Al examen físico: Buen estado general, **pálido, muy poco colaborador**. Abundante tejido celular subcutáneo con distribución central, sin acantosis. **Boca con numerosas caries. Cifosis dorsal alta leve. No cicatriz de BCG. Cúbito valgo bilateral(se ve frec en turner), lesiones por rascado en dorso antebrazo izquierdo, manos y pies pequeños.** Pene 4 cm de longitud, **ambos testículos pequeños en bolsas**. Examen neurológico: pares craneales sin particularidades; trofismo, tono y fuerza muscular conservada en los cuatro miembros; reflejos osteo-tendinosos presentes; sin signos de foco ni meníngeos.

Pregunta:¿Cuáles son sus conductas iniciales con este paciente? (Marque hasta 3 opciones).

Sospecha de alteración genética turner o klinefelter flor_CO pág 162

a. Indicar la BCG. (No porque el pcte ya tiene vacuna BCG)

b. Indicar primer dosis de vacuna oral atenuada contra rotavirus. (No, porque despues de los 3 años es probable que ya tenga se contaminado)

c. Tranquilizar a los padres porque asume que el retraso madurativo está relacionado con la reciente mudanza e incorporación al jardín. (No, porque está asociado a algo patológico)

d. Solicitar glucemia, perfil lipídico. (peso >97 buscar alteracion metabolica)

e. Profundizar la anamnesis sobre el sueño de Mario. (busqueda por apnea de sueño por obesidad y FR baja)

f. Solicitar una resonancia magnética de encéfalo.

g. Solicitar interconsulta con servicio de Genética.

h. Interconsulta a dermatología.

i. Interconsulta con ortopedia.

j. Indicar 100 mg de metformina por vía oral cada 12 horas. KILLER(No, porque faltan datos para esa indicación)

11 - Beatriz, **de 13 años**, consulta en un hospital de tercer nivel de complejidad, derivada por su pediatra de cabecera, por **presentar baja talla y retraso puberal**.

Antecedentes personales: Edad gestacional 39 semanas, peso al nacer 2.900 gramos, talla 46 cm, sin antecedentes perinatales. Ha presentado **episodios de diarrea esporádica y constipación durante el último año**. Al interrogatorio la madre cuenta que se alimenta en forma adecuada y no presenta vómitos. Comentan que **no tiene buen desempeño escolar y repitió dos años de colegio**. Es la única hija de una pareja no consanguínea, sin patología familiar.

La madre mide 159,5 cm con menarca a los 15 años y el padre mide 177 cm.



Auxología: Peso 36,4 kilos (**Z -1.36**), talla 130 cm (**Z -3.08**).

Estadios de Tanner: **mamas 1 y vello púbico 2**.

Signos vitales: **frecuencia cardiaca 68 por minuto** 70-100, TA en miembro superior derecho 90/65 mmHg **90 - 140/69 - 95**, frecuencia respiratoria 14 por minuto **13-15**.

Examen físico: Niña de aspecto agradable. **Piel es seca, fría y áspera al tacto. Implantación baja de orejas, párpados caídos, micro y retrognatia, cuello corto y ancho, cúbito valgo, manos y pies cortos. Pecho ancho y plano, precordio calmo, 2 ruidos en 4 focos, sin soplos, pulsos femorales presentes y levemente disminuidos.**

Pregunta: De acuerdo a su hipótesis diagnóstica inicial, **cuáles son las conductas más adecuadas?** (Marque hasta 3 opciones). **DX alteración genética** flor _ co 162

a) Citar a control en 6 meses. KILLER (No, hay investigar y confirmar dx)

b) Solicitar radiografía de muñeca y mano para determinar edad ósea. (Si, por baja talla y clínica)

c) Solicitar Interconsulta con endocrinología. (No, porque no sería una conducta inicial)

d) Comentar a la madre que Beatriz ha comenzado su pubertad. (No, porque la tiene mamas en Tanner 1 o sea no ha presentado la telarca, además la pcte está con retraso puberal)

e) Solicitar determinación de hormona de crecimiento (No, porque la sospecha dx es una alteración genética)

f) Solicitar interconsulta con genética. (Por toda la clinica)

g) Solicitar espinograma. (No, porque es una radiografía que se usa para ver anomalías de columna, no sería una conducta inicial)

h) Solicitar interconsulta a cardiología. (Si, Por riesgo de coartación de aorta en dx de turner)

i) Solicitar radiografía de cráneo de perfil (No, porque no es una conducta inicial)

j) Solicitar resonancia magnética de cerebro y electroencefalograma.(No, porque no es una conducta inicial)

12 - Camila, de 6 años de edad, llega a la consulta del servicio de emergencias, por presentar **desde hace 5 días, lesiones en piel de miembros inferiores y dolor abdominal periumbilical de 48 horas de evolución.**

Ha manifestado asimismo, **dolor en las rodillas y los tobillos** durante los últimos tres días y desde esta **mañana tiene dificultades para caminar.**

Refiere buena actitud alimentaria y tolerancia oral.

La diuresis está conservada y las deposiciones son normales.

Examen físico: Frecuencia cardíaca de 80 latidos/minuto **90-120**, Frecuencia respiratoria de 16 respiraciones/minuto **15- 25**, Tensión arterial 100/50 mm Hg **80-120/50-80**. Se encuentra afebril.

Fauces discretamente congestivas.

Abdomen blando, depresible. **Discreto dolor difuso a la palpación.** No se palpan visceromegalias.

Se observa **tumefacción en ambos tobillos y exantema eritematoso que no desaparece a la vitropresión, palpable en las extremidades inferiores.**

No refiere otros antecedentes de importancia.

Presenta vacunas completas para la edad.

Vive con sus padres y un hermano en un departamento de CABA con todos los servicios.

Pregunta: Con la información disponible, los exámenes complementarios más apropiados para relizarle a Camila son: (Marque hasta 3 opciones) . **Dx Púrpura de schonlein henoch flor_co 105**

a) Hemograma con recuento de plaquetas y exudado de fauces.

b) Colagenograma.

c) Punción de médula ósea. **KILLER**

d) Coagulograma. (No, porque es normal)

e) Función renal y orina completa. (para descartar compromiso renal)

f) Ecografía articular y de partes blandas. (No, solo se sospecho de artritis, nuestra pcte tiene una purpura)

g) Punción articular. (No, no es conducta)

h) Ecografía abdominal. (util en dolor abd, para descartar compromiso enteral)

i) Radiografía frente y perfil de ambas rodillas y tobillos. (No, porque no estoy sospechando de artritis)

j) Interconsulta con Ortopedia y Traumatología. (La artralgia esta justificada por la enfermedad)

13 - Concorre a la consulta Sabrina de 9 años acompañada por su mamá, Elisa de 29 años.

Se trata de una niña previamente sana hasta los 6 años en el que registra su último control en salud. Refiere como motivo de consulta un dolor abdominal de varios meses de evolución.

Si bien no puede precisar con exactitud el comienzo de los dolores, lo sitúa aproximadamente a principios de año (4 meses atrás) coincidiendo con el inicio de las clases. Elisa los atribuyó a que el cambio de turno (ahora concorre a la mañana) la obligaba a desayunar más rápido o no hacerlo. Comenzó a acostarse y despertarse más temprano y así “desayunaba mejor” (una infusión con leche y un pan con mermelada).

Al poco tiempo los dolores reaparecieron y la madre comenzó a administrarle gotas de antiespasmódico y analgésico con escasa respuesta. Los dolores continuaron hasta cuatro días a la semana y en estas últimas con mayor intensidad, llegando incluso a tener que retirarla de la escuela y despertarse por la noche.

Relata que el dolor se localiza a veces en el flanco izquierdo y a veces no lo puede precisar.

Muchas veces el dolor también le producía falta de apetito, pero sin dolor “come muy bien” afirma Elisa.

El ritmo evacuatorio variaba entre episodios de constipación con diarreas desligadas y explosivas. Estos cambios no se relacionaban con la ingesta de alimentos determinados ni con fiebre.

En alguna oportunidad presentó sangre en las deposiciones y en algunas ocasiones tenía náuseas y vómitos como pródromos de los dolores.

Tiene antecedentes de tratamiento familiar con Mebendazol + Tinidazol hace 3 semanas por prurito anal asociado, sin examen parasitológico previo.

Al examen físico presenta un peso en Pc 25/50, talla en Pc 50, IMC en Pc 25.

Mucosas húmedas, conjuntivas discretamente pálidas.

Frecuencia cardiaca: 98 latidos por minuto, sin soplos.

Frecuencia respiratoria 22 por minuto 15-20, entrada de aire conservada, sin ruidos agregados.

Abdomen blando, ligeramente distendido, indoloro a la palpación superficial, sin defensa, con dolor a la palpación profunda en región periumbilical, sin visceromegalias, ruidos hidroaéreos presentes, marco colónico timpánico.

Pregunta: De acuerdo a la sospecha diagnóstica inicial, cuáles son las conductas diagnósticas iniciales más apropiadas? (Marque hasta 4 opciones). Hipótesis Dx litiasis ureteral (por dolor en flanco IZQ), u parasitosis intestinal

<http://serau.org/2017/05/estrategia-diagnostica-del-dolor-en-el-flanco/>

a. Hemograma, hepatograma, urea, creatinina y glucemia. (Hepatograma porque -otras enf que simulan clínicamente cólico nefritico- dolor en flanco izq- es la colecistitis, coledocoitiasis , pancreatitis y obstruccion intestetinal)

b. IgA antitransglutaminasa y determinación de IgA sérica. (No, porque no hay clinica para eso)

c. Orina completa y urocultivo. (Para descartar litiasis ureteral, debido a dolor intenso en flaco izquierdo - por ser la ppal causa de dolor en esa Region)

d. Radiografía de abdomen de pie.

e. Coproparasitológico.

f. Videocolonoscopia.

g. Ecografía abdominal.

h. Tomografía abdominal computada con contraste de abdomen y pelvis.

i. Endoscopia digestiva alta.

j. Test cutáneo para determinación de alergia a la proteína de leche de vaca.

14 - lara es traída a la guardia por haber presentado un registro de **temperatura axilar de 38,5°C grados** constatada en el domicilio por sus padres. Es la primer hija de la pareja, tiene **21 días** de vida. El embarazo cursó sin complicaciones, **serologías y pesquisa para estreptococo negativas**. Nació a término por cesárea por trabajo de **parto prolongado y signos de sufrimiento fetal**. Apgar 8/10 **7-10**. Peso de nacimiento 2940 gramos. Isogrupo, isofactor. Recibió vacuna antihepatitis B y BCG. No presentó complicaciones y fue dada de alta conjunta a las 72 hs de nacida. Alimentada a pecho exclusivo a libre demanda. Catarsis diaria de color amarillenta de consistencia blanda. Refiere la madre que siguió con el ritmo habitual de alimentación. **Pesquisa metabólica neonatal pendiente resultado y auditiva normal.**

Al examen físico, se encuentra vigil, **tranquila, normocoloreada**. Frecuencia cardíaca **120 latidos por minuto 120-180**, frecuencia respiratoria **44 por minuto 30 - 50**, temperatura axilar **38,5°C grados**. Relleno capilar menor a dos segundos.

Auscultación cardíaca y pulmonar normal. Abdomen: se palpa hígado y bazo a 1 cm del reborde costal. Fontanela permeable, se observan latidos en la misma. Resto del examen dentro de límites normales.

Fiebre sin foco flor_co pagi 68

Pregunta:¿Cuáles son las conductas iniciales más adecuadas? (Marque hasta 4 opciones)

a. Indicar paracetamol vía oral y control en 1 hora.

b. Indicar paracetamol vía oral y control en 24 horas. KILLER

c. Internar a lara.

d. Solicitar hemograma, PCR y orina completa.

e. Solicitar hemocultivos, urocultivo.

f. Realizar punción lumbar para físico químico y cultivo.

g. Solicitar panel respiratorio de vía aérea superior.

h. Solicitar coprocultivo e hisopado anal y nasal.

i. Solicitar radiografía de tórax.

j. Solicitar serologías para TORCH.

15 - Antonio es un niño de **6 meses** de edad, que concurre acompañado por su **madre de 16 años y su padre de 18 años** a la consulta del control del 6to mes. Conviven con abuelos paternos. Sin antecedentes perinatólogicos de importancia, Peso de nacimiento: 3,500 Kg , Talla : 49 cm y Perímetro cefálico : 35 cm. Al examen físico presenta un peso de 8500 grs (Pc 50-75) , mide 68 cm (Pc 25- 50) y el perímetro cefálico de 43 cm (Pc 25-50).

Pregunta: En este paciente ¿qué pautas del neurodesarrollo debe haber logrado? (Marque hasta 3 opciones)

a) Intenta dar pasos con sostén. (10-11m)

b) Presencia de tónico cervical asimétrico. (pauta de alarma)

c) Puede sentarse solo por medio de la posición de trípode.

d) Lleva objetos a la boca.

e) Rola.

f) Repite sílabas ma ma, da da. (9M)

g) Pinza radial inferior. (Empieza a los 7-8M)

h) Saluda con la mano. (10-11M)

i) Gatea. (Empieza a los 7-8M)

j) Señala con el dedo. (12M)

16 - Consultan los padres de Carla de **3 años** de edad porque desde hace **24 horas notan que renguea al caminar**, y **le duele el miembro inferior derecho al caminar**. Refieren que el dolor parece haber aumentado en las últimas horas. No ha tenido fiebre, ni otros síntomas. No refieren antecedentes patológicos de importancia y ha recibido todas las vacunas del calendario oficial.

Examen físico: niña eutrófica, peso y talla en percentilos 50 para edad y sexo. Temperatura axilar 36,5 grados. No se observan lesiones en la piel. **Se evidencia limitación a la movilidad de la cadera derecha, con resistencia a los movimientos pasivos. No hay signos de flogosis.** Resto del examen sin particularidades.

Usted solicita: radiografía de caderas que fue normal y **ecografía que demuestra escasa cantidad de líquido en la articulación de la cadera derecha.**

Pregunta:¿Cuáles de las siguientes conductas son las más adecuadas? (Marque hasta 3 opciones) **Dx presuntivo:**

Sinovitis Aguda Transitoria flor_Co 114 san justo 3 pagina 292

a. Solicitar resonancia magnética de caderas

b. Solicitar centellograma corporal total

c. Indicar internación

d. Indicar analgesia y reposo (si, porque puede evolucionar enf de perthes)

e. Indicar cefalexina

f. Citar a control en 24 horas (Si, porque si persistir el dolor se hace tracción es el tto de la enf de perthes)

g. Solicitar punción de cadera para cultivo y fisicoquímico

h. Solicitar hemocultivos, hemograma y PCR

i. Explicar a los padres que es un proceso infeccioso que requiere intervención inmediata

j. Explicar que es un probablemente un proceso benigno que requiere observación

17 - En el mes de marzo, concurre a su consultorio Matías **de 8 años** para realizar el control en salud y confeccionar el apto físico para realizar actividad deportiva no competitiva. El niño carece de antecedentes perinatales de importancia. A partir de **los 5 años de vida padeció 4 episodios broncoobstructivos que se resolvieron ambulatoriamente.** Por tal motivo en la actualidad **recibe tratamiento preventivo con budesonide.** La mamá le comenta que la familia está pasando por un momento muy difícil ya que hace unos meses le han diagnosticado **leucemia al hermanito de Matías y comenzó a recibir tratamiento quimioterápico.** Por ese motivo se atrasaron los controles en salud de Matías.

Cuando Ud analiza el carnet de inmunizaciones de Matías constata que el paciente recibió las siguientes vacunas:

BCG: una dosis **ok**

Hepatitis: B una dosis **ok**

Pentavalente: 4 dosis **ok**

Salk: dos dosis

Sabin: dos dosis (**ojo no se adm mas sabinii**)

Rotavirus: dos dosis **ok**

Neumococo: tres dosis **ok**

Meningococo: tres dosis **ok**

Triple viral: una dosis

Hepatitis A: una dosis **ok**

Al realizar el examen físico Ud constata ausencia de cicatriz por nódulo de vacuna BCG.

El paciente presenta abundantes secreciones nasales aunque el estado general es bueno. El resto del examen físico no presenta particularidades.

Pregunta: Con respecto al registro de vacunas que presenta el paciente, Ud. piensa que: (Marque hasta 3 opciones)

a) Está **contraindicado** indicar a Matías ningún tipo de vacunas hasta finalizar la inducción de su hermano.

b) Está **contraindicado** que Matías reciba ningún tipo de vacuna a virus vivo atenuado.

c) Matías tiene vacunas completas para su edad. **KILLER**

d) Matías debe recibir una dosis de vacuna Salk.

e) Matías debe recibir una dosis de vacuna Sabin. **KILLER**

f) Matías debe recibir una dosis de vacuna Triple bacteriana **celular**. (hasta los 7 años)

g) Matías debe recibir una dosis de vacuna Triple Bacteriana **acelular**.

h) Matías debe recibir una dosis de vacuna Triple Viral y **antivaricela**.

i) Matías debe **reiniciar** el esquema de vacunación completo.

j) El tratamiento actual con Budesonide **inhalatorio** contraindica la aplicación de vacunas a virus vivos atenuados.

18 - Concurren por primera vez a su consulta Mariana de **14 años** y su madre. **La adolescente muestra actitud indiferente, cabeza inclinada mirando siempre a su celular.** Al preguntarle a la niña el motivo de su consulta, la madre responde expresando que su hija **debe obtener el apto para realizar educación física no competitiva.** y además quiere que Ud. **le explique a su hija que a esa edad no puede aplicarse piercing, no debería tatuarse ni asistir los fines de semana a locales bailables.**

Mariana **no realizó controles en salud desde hace tres años.**

Es la mayor de tres hermanos, hijos de una pareja anterior de la madre.

La señora comenta que se embarazó de Mariana a los **14 años.**

La adolescente asiste al primer año de la escuela secundaria con **buen desempeño.**

Pregunta: Ante esta situación, señale entre las siguientes las conductas más adecuadas: (Marque hasta tres opciones). **Puberdad y adolescencia** **flor_co 47**

a) Le expresa a Mariana que le sugerirá algunas ideas como si se **tratara de su propia hija.**

- b) Propone que Mariana exprese sus propias opiniones sin interrupciones de su madre.**
- c) En esta primera entrevista se debe consensuar con Mariana la presencia o no de la madre durante la entrevista.**
- d) Le asegura a Mariana que a excepción de situaciones de riesgo asegura la confidencialidad de la entrevista.**
- e) Le explica a Mariana que **es necesario que ella se comprometa** a aceptar las recomendaciones que Ud. le proponga.
- f) **Prohíbe** a la adolescente ingerir alcohol y fumar por las consecuencias que ello trae a su salud.
- g) Informa a la adolescente que puede ingerir alcohol a dosis pequeñas.** KILLER
- h) Explica que en la primera entrevista es necesaria la presencia de la madre durante toda la consulta. (No, porque a partir de los 13 puede ir sola)
- i) Realiza el examen físico incluyendo el examen ginecológico. (No, porque no hay datos que la niña ha empezado con las relaciones sexuales)
- j) Indica anticonceptivos orales por considerarla una paciente de riesgo.** KILLER

19 - Es traído por sus padres a la guardia externa, Juan de **8 años** de edad. Se trata de un niño previamente sano, a quien se le diagnosticó **otitis media aguda derecha hace 5 días** y fue **medicado con amoxicilina** 90 mg/kg/día. En el día de hoy consulta por **persistencia de la fiebre y dolor retroauricular**. Al examen físico encuentra **edema y eritema retroauricular con despegamiento y antepulsión del pabellón auricular derecho**.

Pregunta: De acuerdo a su hipótesis diagnóstica inicial, ¿cuáles son las conductas prioritarias? (Marque hasta 3 opciones) **DX mastoiditis (complicación de la OMA)** flor_co 119 san Justo 1 247

<https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2020/v118n2a19.pdf>

- a) Rotar antibiótico a cefalexina vía oral por 10 días.** KILLER (según flor_co se rota ceftriaxona IV)
- b) Solicitar Rx cráneo frente y perfil con foco en mastoides.** (No, porque se solicita TAC)
- c) Solicitar TAC de cerebro con contraste EV.** (Frente complicación el primer estudio que se pide por las complicaciones intracraneana)
- d) Rotar el antibiótico a amoxicilina-clavulánico y citar a control en 24hs.** KILLER (No, el control es en 48 hrs)
- e) Solicitar internación para tratamiento antibiótico EV.**
- f) Indicar gotas óticas con tobramicina.
- g) Indicar lavados de conducto auditivo externo.
- h) Realizar interconsulta con ORL.** (SI, por se tratar de una complicación)
- i) Indicar corticoides sistémicos.
- j) Solicitar ecografía de glándula parotídea. (No, porque no hay contexto)

20 - Santino, de **5 años**, es traído al consultorio debido a haber **presentado manchas en la piel que comenzaron 24hs antes de la consulta**. La madre relata que las **“manchas” comenzaron súbitamente como máculas rosadas y pruriginosas**, distribuyéndose de **manera asimétrica y generalizada**. Estas lesiones **tienen tendencia a confluir y formar placas eritematosas**. Además se acompaña de intenso prurito. El niño se **encuentra afebril** y en buen estado general. Diuresis conservada de características normales.

Como antecedentes personales importantes se destacan los siguientes: **Dermatitis atópica. Gastroenteritis aguda en 2 oportunidades de manejo ambulatorio. Broncoespasmos frecuentes (un episodio con internación)**. Vacunas completas para la edad.

Actualmente se encuentra **en tratamiento con amoxicilina en 7º día, por episodio de otitis media aguda** (ya ha **tenido en otra oportunidad en el invierno pasado tratada con el mismo antibiótico**). Y en el día de hoy presenta otoscopia normal.

Pregunta: Teniendo en cuenta su hipótesis diagnóstica, cuáles son las conductas más apropiadas? (Marque hasta 3 opciones) **Dx diferencial dermatitis atópica, Flor_cot 181(dermatitis atópica) o exantemáticas(pero que fue excluida)**pag139

a) Solicitar serología para rubéola. (No, porque rubéola no confluente)

b) Indicar talco mentolado 2 veces por día. (No, la indicación es sólo hidratación)

c) Tranquilizar a la madre explicando que es una situación transitoria y benigna.

d) Solicitar hemograma y dosaje de inmunoglobulinas (GAME).

e) Indicar antihistamínicos. (Si por el tema del prurito)

f) Excluir al niño del jardín hasta la desaparición total de las lesiones. (Dermatitis no es contagioso)

g) Realizar denuncia epidemiológica a la autoridad sanitaria local. (Dermatitis no es contagioso, no es de notificación y también no hay sospecha de una exantemática)

h) Suspender tratamiento antibiótico. (ya cumplió el tto no hay necesidad de continuar)

i) Solicitar hisopado de fauces. (No, porque no hay sospecha de escarlatina)

j) Indicar aciclovir crema y vía oral. (No, no hay sospecha de varicela o herpes)

21 - Se encuentra evaluando por primera vez a Mateo de **4 años** de edad, que concurre para control en salud. La madre refiere que es un niño sano, aunque le llama la atención que en el **último tiempo se cansa con facilidad cuando corre**, lo cual le dificulta el juego con el resto de los niños de su edad. No surgen otros antecedentes familiares ni personales de relevancia.

Mateo es un niño eutrófico, con peso y talla en percentilo 25 para su edad. Al examen físico se encuentra algo **pálido, taquicárdico, taquipneico, con precordio activo y pulsos saltones**. Se ausculta un **soplo sistólico continuo**, con máxima intensidad en sístole y disminución en la telediástole, audible preferentemente en la región infraclavicular izquierda y en el borde paraesternal superior izquierdo. A nivel abdominal se **palpa ligera hepatomegalia**. El resto

del examen físico no presenta otras particularidades.

Pregunta: En base a su diagnóstico presuntivo ¿qué estudios complementarios iniciales son de mayor utilidad?

(Marque hasta 3 opciones). **Soplo Sintomático** **flor_co174** opciones iguales al apunte

a) Ionograma y estado ácido-base.

b) Hemograma.

c) Ecocardiograma.

d) Teleradiografía de tórax.

e) Espirometría.

f) Angiotomografía de tórax. KILLER

g) Ecografía abdominal.

h) Electrocardiograma.

i) No es necesario solicitar estudios de imágenes. KILLER

j) Hepatograma, urea, creatinina y ácido úrico.

22 - Concorre a su consultorio Elisa, madre primeriza de 20 años, con su hijo Tomás de **7 meses** de edad.

Antecedentes: **recién nacido prematuro, de 32 semanas de edad gestacional.** Permaneció en neonatología **45 días.**

No tuvo grandes complicaciones, inició alimentación con leche materna a los **7 días de vida, que hubo que cambiar a fórmula para prematuros por hipogalactia. En neonatología recibió vitaminas ACD, hierro y complemento.**

Actualmente Elisa refiere que **le cuesta que coma semisólidos** por lo cual **refuerza su alimentación con leche de vaca ya que no le alcanza el dinero para comprar la fórmula indicada.** Al evaluar al paciente lo nota **pálido, algo apático y levemente hipotónico.** La curva de peso con respecto a controles realizados en otro centro muestran **detención de la curva,** encontrándose **actualmente en percentilo 3.** Decide realizar un laboratorio ya que desde el alta de la unidad de neonatología no se le realizó ningún control. Recibe el laboratorio y en él observa en el hemograma **ferritina sérica disminuida,** glóbulos blancos normales, plaquetas normales, **sideremia disminuida, porcentaje de saturación de la transferrina disminuido, capacidad total de saturación de hierro aumentada, hematocrito disminuido, reticulocitos normales.**

Anemia Ferropénica **Flo_co 101**

Pregunta: Según estos resultados, cuáles son las conductas iniciales prioritarias? (Marque hasta 3 opciones)

a. Solicitar interconsulta con hematología.

b. Recabar más datos sobre aporte de alimentos, hierro y vitaminas, dosis y duración.

c. Indicar leche fortificada con hierro.

d. Asumir el cuadro como anemia ferropénica por prematuridad, hipoaporte y alimentación deficiente.

e. Solicitar hemograma a la madre.

f. Realizar medulograma. KILLER

g. Solicitar sangre oculta en materia fecal.

h. Indicar hierro en forma intramuscular hasta evaluar causa.

i. Indicar hierro 3 a 6 mg/kg/día y reforzar cambios en la alimentación.

j. Asumir la hipotonía, apatía y detención de la curva de peso como cuadro relacionado a su prematurez y que deberá esperar a que realice su catch up.

23 - Isabel concurre a la consulta con su hijo **Mauricio** de **5 años** de edad quien presenta **lesiones compatibles con varicela desde hace 24 hs.**

Ella le comenta que en el jardín donde asiste se han presentado varios casos.

La madre de Mauricio está sorprendida **porque su hijo había recibido una dosis de vacuna antivariela a los 3 años.** **Además está muy preocupada porque ella no sabe si tuvo varicela y está embarazada de término.** Tiene otro hijo, Nicolás, de 7 años, que no recibió dicha vacuna y se encuentra en remisión de una LLA (Leucemia Linfoblástica aguda) hace 18 meses.

Vacunación de varicela indicaciones Flor_co 59, 63

Pregunta: Con los datos presentados, ¿cuáles son las opciones más apropiadas? (Marque hasta 3 opciones)

a. Indicar cultivo del contenido de las lesiones.

b. Mauricio seguramente cursará una varicela leve , ya que recibió vacuna.

c. La madre debe recibir la vacuna antivariela como profilaxis post exposición. KILLER (CI en embarazo a vacuna a virus atenuado, en este caso inmunoglobulina anti varicela en las primeros 48hs-72hs)

d. Si Isabel padeciera varicela perinatal, el recién nacido deberá recibir gammaglobulina específica.

(madre dx hasta 5días antes de parto o 48hs despues)

e. De haber recibido la vacuna a los 15 meses, se hubiera **evitado** que Mateo se enfermara de varicela.

f. Nicolás debe recibir vacuna como profilaxis post exposición. (Nicolás no es considerado más inmunodeprimido después de 12 meses de remisión completa de LLA, y Nicolas esta en remision a 18M)

g. Nicolás debe recibir gammaglobulina por ser un **inmunodeprimido.**

h. Solicitar serologías específicas para varicela. (NO, porque no es conducta una vez que tiene toda la clinica el DX es clinico, tincion, serologia,PCR)

i. **Excluir** al niño del hogar.

j. Es de suma importancia, informar al colegio la necesidad de proceder al **cierre** del jardín para efectuar la

desinfección y evitar nuevos casos.

24 - Mónica y su marido concurren muy preocupados a la guardia de Pediatría con **su bebé de 30 días de vida**. Refieren **que la niña se encuentra molesta, que llora mucho y se calma al tomar el pecho**. También les preocupa que **no sostiene la cabeza**. Es su primer bebé y no saben bien qué hacer.

Antecedentes:

Recién nacido de 40 semana de edad gestacional, peso al nacer: 3500 gr, G1 P1 Apgar 9/10 **7-10**. Embarazo controlado. Vacunas recibidas: BCG y hepatitis B.

Serologías (HIV, VDRL, chagas, toxoplasmosis): Negativas.

Pesquisa metabólica neonatal: **No la retiró.**

Antecedentes perinatólogicos y familiares: No refiere.

Realizó control en neonatología a los 7 días de vida: Pesó 3200 gr y luego a los 15 días: 3480 gr. Se alimenta a pecho exclusivo, moja entre 6 a 7 pañales/día y posee deposiciones líquidas con grumos **Normal**. Al examen físico: Peso 3.900 gr.

Se encuentra en buen estado general, sin datos relevantes al examen físico.

Reflejos Arcaicos presentes.

Pregunta: De acuerdo a todos los datos aportados, qué recomendaciones daría a la familia? (marque hasta 3 correctas)

a. Indicar pecho más leche de fórmula. (No, porque pecho exclusivo)

b. Explicar a los padres que el llanto de la niña es normal.

c. Administrar a la bebé gotas antiespasmódicas. KILLER

d. Indicar a la madre que continúe con pecho exclusivo.

e. Interconsulta con neurología. (No, porque no hay contexto)

f. Realizar coprocultivo. (NO, porque no hay contexto)

g. Indicar a la madre líquidos y descanso adecuados.

h. Definir horarios estrictos para alimentarlo. (libre demanda)

i. Indicar que duerma boca abajo para aliviar los cólicos. (Recomendación supino ventral)

j. Indicar dieta libre de proteína de leche de vaca a la madre. (Hay que indicar líquido y alimentación saludable)

25 - Pedro es un niño de **9 meses** que es llevado a la guardia de un hospital del conurbano bonaerense por presentar **vómitos**. La madre relata que comenzó hace **48 horas con deposiciones líquidas, sin contenido hemático, moco o**

pus, frecuentes y que posteriormente **presentó vómitos** inicialmente de **tipo alimentarios y escasos**, **incrementando en frecuencia y magnitud**. En el día de hoy **lo nota molesto, pálido e irritable**.

Antecedentes: nacido de término, de un embarazo controlado, parto vaginal, Apgar 9/10, peso de nacimiento 3.200 grs, sus vacunas están completas. Alimentado con pecho desde el nacimiento, incorporó semisólidos a partir del 6º mes. En casa de su **madrina probó unas hamburguesas caseras** los días previos y su madre piensa que no le han caído muy bien considerando que tal vez estaban **muy condimentadas**. Al examen físico ud **constata palidez cutáneo-mucosa generalizada, mucosas secas, pliegue ++**, buena entrada de aire bilateral sin rales agregados, R1 R2 en 4 focos, leve soplo sistólico en mesocardio, **enoftalmos, relleno capilar de 2 segundos, frecuencia cardíaca 150** latidos/min **100-130**, frecuencia respiratoria **44** respiraciones/min **20-40**, pulsos periféricos presentes, **llora sin lágrimas**, peso actual 7.900 gr para un peso anterior de 8.400 kg(=6%), **abdomen tenso, ruidos hidroaéreos disminuidos**, no se palpan visceromegalias, **deposiciones escasas con estrías de sangre y oliguria**.

Pregunta: De acuerdo a lo expuesto hasta el momento, cual es su impresión diagnóstica? (Marque hasta 3 opciones)

Deshidratación Moderada flor-co pagina 85

a. Shock séptico

b. **Deshidratación grave** (no tiene que tener dos criterios clinicos solo tiene uno llora sin lágrimas, el peso hay perdida > 10%)

c. Deshidratación moderada (perdio 6% de su peso)

d. Enfermedad celíaca

e. Enfermedad inflamatoria intestinal

f. Invaginación intestinal (vómitos tipo alimentario, el pcte esta lo nota molesto, pálido e irritable flor_co77)

g. Sme urémico hemolítico (hamburguesa, sangre materia fecal)

h. Parasitosis intestinal

i. Insuficiencia cardíaca

j. **Giardiasis intestinal**.(pensar más en diarrea cronica)

26 - Concurren a consultorios externos de un hospital general María con su hijo Federico de **6 años** de edad por presentar fiebre de **38°C de 48 horas de evolución y dolor de garganta, sin tos, ni rinitis**. Ud. completa la anamnesis donde surge que convive con: el padre de 34 años, albañil, la madre de 30 años, ama de casa, **una hermana de 2 años cursando un cuadro catarral** y los abuelos maternos, ambos hipertensos. La vivienda se encuentra en el conurbano bonaerense, es de material con 2 habitaciones, cohabitación con los padres y hermana, la otra habitación es utilizada por los abuelos maternos. Servicios: **pozo ciego, agua de bomba y gas de garrafa**. La zona de residencia es anegadiza, **las calles son de tierra** y dista 5 cuadras de una avenida asfaltada. Federico cursa primer grado con **buen rendimiento y adecuada integración con sus nuevos compañeros**. Vacunación acorde a la edad por **referencia materna**. Alimentación completa y variada. Presenta como datos positivos al examen físico: **37,5°C, buen**

estado general, fauces eritematosas, sin exudado, adenomegalias submaxilares bilaterales de 2cm de diámetro.

Usted le solicita un **test rápido para estreptococo que fue positivo y cultivo de fauces.**

Pregunta: De acuerdo a los datos obtenidos por anamnesis y examen físico, cuáles son las conductas más adecuadas? (Marque hasta 2 opciones)

FARINGOAMIGDALITIS flor_121

a) Indicar antitérmicos y dieta blanda.

c) Indicar clindamicina vía oral. (No, porque la primer opcion seria amoxa, como 2 opcion seria erito o azitromicina)

d) Indicar penicilina vía oral.

e) Indicar penicilina vía oral si el cultivo es positivo para estreptococo alfa hemolítico.

f) Indicar Penicilina vía oral si el cultivo es positivo para estreptococo beta hemolítico.

g) Indicar realización de cultivo de fauces a los convivientes para erradicar la portación. (No, porque ya tenemos el cultivo solicitado)

h) Indicar penicilina benzatínica intramuscular. (No, porque el tto es VO)

i) Indicar colutorio bucofaríngeo con anestésico y antibiótico local.

j) Solicitar ASTO. (No, porque no FARINGOAMIGDALITIS no sirve para agudo, solo para saber se tuvo)

27- La mamá de Sabrina de **20 días de vida**, concurre a la consulta porque **“la nota muy amarilla”**. El embarazo y el parto fueron normales. Nació a término con 3200 gramos, Apgar vigoroso. Grupo sanguíneo de la madre y de Sabrina A +. Alta a las 48 horas sin problemas perinatales. **Pesquisa metabólica neonatal pendiente**, otoemisiones acústicas normales. Se alimenta a pecho exclusivo.

En el control a los **7 días de vida presentaba leve ictericia en cara**, buen aumento de peso. Resto del examen físico es normal, a los 14 días el examen físico es normal, con buen progreso de peso.

Ahora **se nota ictericia generalizada**. Usted solicita laboratorio: **hemoglobina 11 g/dl** 14,5-22,5, **hematocrito 33%** 45-64, **bilirrubina total 10 mg/dl** 1, **directa 9 mg/dl** 0,2.

Pregunta: Ante esta situación Ud cree que la conducta más apropiada es: (Marque hasta 3 opciones).

Ictericia flor_co 21

a. Tranquilizar a la madre explicándole que la ictericia disminuirá gradualmente durante los próximos días.

b. Suspender temporalmente la alimentación materna.

c. Suspender la alimentación materna de modo permanente y continuar alimentando a Sabrina con fórmula maternizada.

d. Efectuar una prueba de compatibilidad para descartar incompatibilidad ABO. (Ambas son A)

e. Efectuar una prueba de compatibilidad para descartar incompatibilidad Rh. (Ambas son Rh+)

f. Investigar cambios en la coloración de la orina y la materia fecal. (Si, por la clínica y lab)

g. Solicitar ecografía hepática. (Si, por la BD estar elevada sospecho de alt a nivel hepático)

h. Internar a Sabrina para efectuar luminoterapia. (No, solo si bilirrubina es mayor a 17)

i. Internar a Sabrina para efectuar una exanguinotransfusión. (No, solo en casos muy graves y antes se hace luminoterapia)

j. Solicitar una consulta lo antes posible, con el hepatólogo y el cirujano pediatra.

28 - Maia de 18 meses de vida fue llevada hace 48 horas a una guardia por ambos padres muy angustiados porque presentó un primer episodio de convulsión de aproximadamente 5 minutos de duración. No hay antecedentes familiares.

Al examen físico inicial, se encontraba dormida y febril (38,3°C). Los padres previamente al episodio convulsivo le habían administrado ibuprofeno porque tenía fiebre (39,2°C).

Luego de 20 minutos se despertó, en buen estado general, reactiva, conectada. El examen físico fue normal.

Antecedentes: Se trata de una niña previamente sana, como intercurrentias solamente presentó una laringitis a los 6 meses de vida. Carnet de vacunación: completo.

En ese momento el pediatra de guardia decidió indicarle antitérmicos, pautas de alarma y control su médico de cabecera.

Los padres de Maia lo consultan a Ud. 2 días después, persiste febril hasta anoche y hoy al mediodía observaron que tenía unas manchitas en la piel.

Al examen físico se encuentra en buen estado general, afebril, vigil, reactiva, conectada, fauces y oídos levemente congestivos. Se observan máculas rosadas generalizadas a predominio de tronco que desaparecen a la vitropresión. Resto del examen físico s/p.

Pregunta: De acuerdo a todos los datos aportados, Ud decide: (Marque hasta 3 opciones)

Dx presuntivo Exantemática 6 enf flor_co 140

a) Realizar hemograma, eritrosedimentación, proteína C reactiva.

b) Realizar 2 hemocultivos y punción lumbar para citoquímico, cultivo y virológico.

c) Luego de la toma de cultivos, iniciar tratamiento con Ceftriaxone 100 mg/kg EV.

d) Internación hasta obtener resultados de cultivos.

e) Solicitar imagen de cerebro. (No, porque no hay contexto se hubiera una complicación si estaría adecuada la conducta)

f) Explicar a los padres que impresiona una infección banal posiblemente causada por el virus Herpes 6. (6 enf exatematica)

g) Solicitar electroencefalograma. (No, porque la niña presentó una convulsion febril simple)

h) Indicar diazepam para prevención de próximos episodios convulsivos. (No, porque la niña presentó una convulsion febril simple)

i) Dar pautas de alarma y seguimiento ambulatorio. (Si, porque mismo en la mayoría de los casos se resuelvan solos puede complicar y en estos casos hay que volver a consultar)

j) Explicar a los padres que el episodio convulsivo que presentó no generará secuelas neurológicas. Si, porque la niña presentó una convulsion febril simple

29 - Usted atiende en el sector de emergencias a Alan de 13 años, acompañado de su madre. Estando en una fiesta con amigos, le avisaron que se cayó porque se “descompuso”. Alan aparenta estar confundido y cuando lo quiere interrogar se torna agresivo y no colabora. Impresiona adelgazado, en regular estado general, **sudoroso, con pupilas midriáticas.** Tº axilar: **37.2 °C**, Frecuencia cardíaca: 100 / minuto **70 -100**, **Frecuencia respiratoria: 20** por minuto. **13-15**

Antecedentes: La madre refiere que desde hace 3 meses lo encuentra **apático, no comparte charlas con sus hermanos, cambió de grupos de amigos y se torna agresivo cuando le ponen algún límite o quieren hablar con él por el bajo rendimiento en la escuela. Pasa muchas horas al día con la computadora y el teléfono.**

Sociofamiliar: Sus padres están separados desde que él tenía 2 años y no tiene contacto con el padre. Su madre trabaja 8 hs al día en un negocio, **y comenta que siempre le pide dinero para comprar comida y útiles.** Tiene **2 hermanos, de 10 y 17 años, ambos escolarizados.**

Pregunta: ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada? (Marque hasta 4 opciones)

a. Solicitar intervención policial.

b. Realizar punción lumbar. KILLER

c. Indicar hidratación endovenosa.

d. Inducir el vómito. (No, porque es CI)

e. Solicitar tóxicos en orina.

f. Indicar lavado gástrico.

g. Solicitar TAC de cerebro con contraste. (No, porque se cayó de propia altura la conducta es observación por 6 hrs y luego pautas de alarma)

h. Solicitar EEG.

i. Solicitar hemograma, urea, creatinina, EAB, ionograma, hepatograma, CPK.

j. Realizar ECG / monitoreo cardíaco.

30 - En la sala de internación conjunta se encuentra Lucía con su bebé, Tomás, de **18 horas de vida**. Es un RNT, 38 semanas, PAEG, PN 2900 g, grupo y factor **A +**, prueba de coombs directa positiva, Apgar 9/10, G2P2A0C0, con cordón umbilical en período de cicatrización clampeado. Antecedentes de embarazo: fue controlado, con serologías negativas para toxoplasmosis, sífilis, hepatitis B y HIV. **Grupo y factor de Lucía 0 +**. Tomás tiene un **hermano de 3 años que requirió luminoterapia durante dos días a la semana de haber nacido**. Usted va a realizar el control de **Tomás y lo observa con ligera palidez, leve taquicardia, insuficiencia respiratoria, fontanela anterior permeable, facies conservada, tinte amarillo en conjuntiva y piel hasta el ombligo aproximadamente**, diuresis conservada. Peso actual 2800 g. **No presenta cefalohematomas**. Ha recibido la vacuna contra hepatitis B en sala de parto. Se encuentra con lactancia materna exclusiva.

Dx ENFERMEDAD HEMOLÍTICA DEL RN POR ABO flor_co 24

Pregunta: Ante su presunción diagnóstica, Usted: (Marque hasta 3 opciones)

a) Indica aumentar frecuencia de mamadas. (No, porque es una conducta general y la pregunta esta haciendo referencia al dx presuntivo)

b) Solicita hemograma, hepatograma, fosfatasa alcalina y gamma glutamil transpeptidasa.

c) Explica a los padres del niño que es necesario realizar tratamiento y repetir controles.

d) Indica complemento con leche de fórmula. (No, porque es lactancia materna exclusiva)

e) Solicita hematocrito y bilirrubina total y directa.

f) Indica luminoterapia o exanguinotransfusión según curvas de referencia.

g) Solicita 2 hemocultivos, urocultivo y cultivo de LCR.

h) Solicita serologías para CMV y HSV. (No, porque no hay contexto, embarazado fue controlado con aerologías negativas)

i) Solicita ecografía abdominal.

j) Indica exposición solar breve diaria. Killer

EFUS 2020

DICIEMBRE DE 2020

1- Hace 1 mes y medio, Mariel de 5 años concurrió a la consulta con sus padres por presentar diarrea intermitente. Presentaba fiebre y deposiciones líquidas sin sangre. Sus dos hermanos comenzaron al mismo tiempo y resolvieron el cuadro en una semana. Mariel continuó con episodios repetidos de diarrea. Desde el comienzo de los síntomas realizó dieta hipofermentativa irregularmente.

Actualmente, al examen físico Ud. la encuentra en buen estado general, afebril. Abdomen globoso, depreciable e indoloro. No palpa visceromegalias. En el resto del examen físico se encuentra dentro de parámetros normales.

Constata un descenso de peso de casi 300 gramos en este período.

¿Cuáles son las conductas más adecuadas? Marque 3 opciones

Seleccione una o más de una:

- a. Indicar leche con contenido reducido en lactosa
- b. Indicar dieta hipercalórica
- c. Solicitar coprocultivo
- d. Indicar dieta con bajo aporte de azúcares simples**
- e. Indicar tratamiento con mebendazol para el paciente y el grupo familiar
- f. Solicitar parasitológico de materia fecal (examen en fresco y seriado)**
- g. Solicitar anticuerpos para enfermedad celíaca, hemograma, eritrosedimentación y hepatograma**
- h. Indicar dieta libre de gluten

Pregunta 2

Federico, de 2 años y 6 meses de edad, concurre a la consulta con su mamá por padecer cojera de su pierna derecha y dificultad en la marcha.

La mamá comenta que su hijo estaba saltando sobre los charcos de agua de la vereda poco antes de entrar al jardín. Al efectuar el examen físico, Ud. comprueba lo siguiente:

- Niño en buen estado general
- Afebril
- Pierna derecha en semiflexión
- En el intento de abducción, la maniobra ocasiona dolor, en cual no reaparece al extender los miembros inferiores.

¿Cuáles son sus hipótesis iniciales respecto del diagnóstico probable y de las conductas más adecuadas para abordar el problema de Federico?

Marque 3 opciones

Seleccione una o más de una:

- a. Indicar inmovilización con yeso durante 4-8 semanas
- b. Luxación de rótula
- c. Indicar Rx de tobillo y rodilla
- d. Indicar Rx comparativa de ambas caderas**

e. Esguince tobillo

f. Sinovitis transitoria de cadera

g. Indicar reposo y analgésicos por vía oral

h. Epifisiolisis proximal del fémur

Pregunta 3

Inés concurre al centro de salud con su hija Lucía de 15 meses de edad. La mamá refiere que la niña come poco, es poco activa, llora mucho y desde hace 48hs presenta deposiciones desligadas.

Lucía es única hija, nacida de término, parto normal con peso de nacimiento de 2,300 Kg. Inés tiene 16 años, escolaridad primaria incompleta, vive con sus padres y 5 hermanos menores. El padre de Lucía está ausente. Vivienda: único ambiente, baño externo, colecho con la madre, agua de bomba, gas de garrafa. Lactancia materna hasta los 6 meses. La suspendió al enfermarse de gripe, luego leche de vaca. Lucía come poco del mismo plato de la mamá. Antecedentes: impétigo en 2 oportunidades, otitis y cuadros catarrales a repetición y 1 episodio de síndrome bronco obstructivo de tratamiento ambulatorio. Vacunación completa por referencia sin carnet. Neurodesarrollo: se para con apoyo, no da pasos con sostén ni camina sola.

Examen físico: Frecuencia cardíaca 110 latidos/min. Frecuencia respiratoria 28 respiraciones/min. Regular estado general, mirada triste, apática, irritable al examen, normohidratada en suficiencia cardio-respiratoria, eupneica, pulsos periféricos presentes, relleno capilar menor a 2 segundos. Se constata diuresis conservada y catarsis desligada.

Peso actual: 8,100 kg Pc 10, y Score Z: -1,3 ; Talla: 68 cm Pc < 3 y Score Z; -3,4.

Datos positivos: palidez cutáneo-mucosa, pelo escaso y fino con alopecia en la nuca, adenomegalias submaxilares pequeñas y móviles, escaso tejido celular subcutáneo, cicatrices residuales de impétigo en ambos miembros inferiores, abdomen globoso, blando, depresible e indoloro, sin visceromegalias, ruidos hidroaéreos presentes. Laxitud ligamentaria y menor trofismo muscular. Resto del examen s/p.

¿Cuál sería su conducta inicial? Maque 3 opciones

Seleccione una o más de una:

a. Citar a control ambulatorio con resultado de estudios solicitados

b. Indicar suplementos alimentarios para recuperar peso

c. Solicitar evacuación por servicio social

d. Indicar dieta hiperhidrocarbonada

e. Conectar a la mamá con el servicio de adolescencia

f. Realizar la denuncia a consejo de niñas, niños y adolescentes

g. Internar Lucía para realizar estudio

h. Evaluar riesgo ambiental por convivientes fumadores en ausencia de la niña

Pregunta 4

Ud. recibe en la guardia de un hospital provincial a Pascual, de 3 meses de edad, quien ha presentado en su domicilio un episodio convulsivo de aproximadamente 20 minutos de duración, según refiere la mamá.

Pascual está con fiebre desde ayer y hoy, antes de la convulsión, tenía 39°C.

Al examinarlo, Ud. constata que Pascual persiste febril, está letárgico y responde escasamente a los estímulos.

La mamá le informa que un hermano de Pascual, de 18 meses, recibe tratamiento con anticonvulsivantes por haber presentado una convulsión febril a los 8 meses de edad.

Pascual ha sido hasta el momento un bebé sano y tiene las vacunas correspondientes a su edad. Con los datos hasta aquí mencionados, usted, ¿qué decide? Marque 3 opciones

Seleccione una o más de una:

- a. Indicarle a la mamá diazepam para que se lo administre en los próximos episodios febriles.
- b. Efectuar en forma inmediata una punción lumbar.**
- c. Internar a Pascual**
- d. Considerar que Pascual ha tenido una convulsión febril típica
- e. Dejarlo en observaciones en guardia para bajarle la fiebre y enviarlo a su domicilio cuando la misma ceda.
- f. Tramitar de urgencia un electroencefalograma
- g. Administrar lo antes posible una dosis de ampicilina por vía endovenosa
- h. Administrar lo antes posible una dosis de ceftriaxona por vía endovenosa.**

Pregunta 5

Lorenzo, de 6 meses de edad, ingresa al Servicio de Emergencias con un cuadro de dificultad respiratoria. La presunción clínica inicial indica que se trata de una bronquiolitis. El médico a cargo le efectúa tratamiento en base a β_2 agonistas y oxígeno por máscara.

A las 2 horas del ingreso, Lorenzo presenta los siguientes parámetros:

Frecuencia cardíaca: 160x', Frecuencia respiratoria 70x', saturación de O_2 : 86% respirando aire ambiental. Con los datos disponibles, ¿cuáles serían las conductas más apropiadas en este momento de la atención? Marque 3 opciones

Seleccione una o más de una:

- a. Internarlo en la Sala de Pediatría.**
- b. Solicitar gases en sangre.**
- c. Colocarle una vía para hidratación parental.**

d. Colocarle una sonda nasogástrica para alimentarlo.

e. Efectuar interconsulta con Cardiología.

f. Solicitar de inmediato el ingreso de Lorenzo para asistencia respiratoria mecánica.

g. Proseguir con alimentación materna para evitar la deshidratación de Lorenzo.

h. Dejarlo en la guardia en observaciones para realizar una segunda serie con la misma medicación.

Pregunta 6

Santino, de 19 meses de vida, concurre a la guardia acompañado por sus padres por presentar el ojo izquierdo hinchado y fiebre ($38,4^{\circ}\text{C}$) de 1 día de evolución. Refieren haber concurrido por la mañana a otro centro donde le indicaron difenhidramina vía oral y no tuvo mejoría. Según relatan los padres Santino no ha sufrido ningún traumatismo ni le ha picado ningún insecto en la cara recientemente. Notan que come menos y está menos activo. Hace dos horas le suministraron antitérmicos.

La semana anterior tuvo rinorrea, estornudos y tos leve.

Antecedentes: crisis de broncoespasmos.

Al examen físicos, se encuentra decaído, febril($38,9^{\circ}\text{C}$), frecuencia cardíaca 120 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 24 respiraciones por minuto y tensión arterial 90/50 mmHg. Presenta tumefacción de los párpados superior e inferior izquierdos, eritema y dolor al tacto. No hay quemosis ni exoftalmos evidentes (ver imagen). Los movimientos extraoculares y la agudeza visual se pueden evaluar sólo parcialmente a causa del dolor.



¿Cuáles son las conductas iniciales más adecuadas? Marque hasta 3 opciones

Seleccione una o más de una:

a. Solicita hemograma, PCR y 2 hemocultivos

b. RX de orbita y senos paranasales

c. Internar e inicia tratamiento EV con ATB y analgesicos

d. TAC de órbita y senos paranasales

e. Control ambulatorio en 24h

f. Amoxicilina por 10 días y control

Pregunta 7

Ramiro de 5 años de edad concurre a la consulta con su mamá. A su padre José, de 36 años albañil sin trabajo fijo, le diagnosticaron tuberculosis pulmonar hace tres semanas por lo que permanece internado en un hospital del conurbano con buena respuesta al tratamiento. La madre de 32 años refiere ser sana aunque en la consulta se escucha toser.

La familia vive en González Catán, en una vivienda de material, sin revocar, de los ambientes, piso de cemento, agua de bomba, pozo ciego, gas de garrafa. Conviven con Ramiro, sus padres, un tío paterno de 17 años, una tía materna de 20 años, empleada en una panadería, y la abuela materna.

La madre refiere que realiza esta consulta por recomendación de los médicos de su marido como parte del catastro familiar. El niño tiene tos, desde hace un tiempo, come poco aunque siempre fue inapetente. Al examen físico se lo observa adelgazado, afebril con rinorrea mucosa. No presenta cicatriz de BCG, se ausculta buena entrada de aire bilateral sin ruidos agregados. Dos ruidos cardiacos en cuatro focos silencios libres. Peso en Pc 10 y Talla en Pc 25.

¿Cuáles son las conductas iniciales más correctas? Marque 3 opciones

Seleccione una o más de una:

- a. Iniciar tratamiento con Isoniacida, rifampicina, pirazinamida
- b. Suspender la concurrencia al jardín de infantes hasta completar diagnóstico**
- c. Iniciar tratamiento con Isoniacida
- d. Solicitar reacción de PPD 2 UT y control a las 48 horas**
- e. Solicitar radiografía de tórax frente y perfil**
- f. Internar a Ramiro hasta completar estudios
- g. Realizar tres lavados gástrico en ayunas

Pregunta 8

Marcela de 17 años, concurre con su hijo Santiago de 8 meses a una consulta programada de 1ra vez. Marcela es madre soltera. Su embarazo fue controlado en 5 oportunidades en los últimos meses.

Santiago realizó consultas quincenales con el pediatra durante el 1er mes y luego mensuales. Hasta ahora, según Marcela, los médicos le decían “que estaba todo bien”.

Marcela está preocupada, porque Santiago, no gatea como el hijo de su amiga de misma edad y desde hace 1 semana se despierta de noche, con un llanto que lo siente como “desgarrador”.

En este control en salud Ud. observa que Santiago se sienta de forma segura, toma objetos y los arroja al piso, se para con apoyo, toma objetos voluntariamente que se encuentran sobre la camilla, y comienza a llorar cuando intenta revisarlo.

Tenido en cuenta todos los datos mencionados, ¿qué información le aporta a la mamá acerca de Santiago? Marque 3

opciones

Seleccione una o más de una:

- a. La ausencia de gateo no constituye en sí misma un marcador de retraso del desarrollo
- b. Necesita comenzar estimulación temprana
- c. Tiene un desarrollo acorde a su edad
- d. Requiere diversas interconsultas para evaluación del neurodesarrollo
- e. A esta edad debería tomar la cuchara y comer solo
- f. Probablemente se encuentre transitando angustia por separación
- g. Los síntomas que presenta corresponden a la ausencia de la figura paterna
- h. Deberá realizar una seriada esófago-gastroduodenal para descartar reflujo

Pregunta 9

Usted se desempeña en una guardia médica. A las 22 horas atiende la consulta de una pareja que concurre con su hijo, Mateo, de 4 días de vida. Ellos se encuentran muy preocupados por notarlo más amarillo.

En la anamnesis los padres le informan que Mateo nació de parto vaginal y que fue egresado de la maternidad hace 48 horas. La médica que lo egresó realizó un control de bilirrubina y les dijo que por el momento no necesitaba tratamiento. Los citó para el control a consultorio en 24 horas. Los padres ni pudieron concurrir por no tener con quién dejar a los otros niños.

En el resumen del egreso de neonatología consta: gestas 3, partos 3, embarazo controlado, peso al nacer: 3.100 gr, edad gestacional: 38 semanas y egresado a las 48 horas de vida con un peso de 2.900 gr. Determinación de bilirrubina total de 11,5 mg/dl. Grupo y RH de madre e hijo: 0 positivo. Coombs negativa. Alimentado con pecho exclusivo.

Los padres comentan que Mateo se alimenta bien, tiene diuresis y catarsis conservadas, y no han notado otro síntoma que les llame la atención.

Al examen físico Ud. encuentra a Mateo con ictericia que se extiende hasta rodillas. El resto del examen físico se encuentra dentro de parámetros normales.

Ante esta situación, usted, ¿qué decide? Marque 3 opciones

Seleccione una o más de una:

- a. Indicar exposición a la luz solar y nueva consulta a los 7 días de vida.
- b. Solicitar hematocrito
- c. Concurrir a control clínico en 2 días
- d. Explicar a los padres que la ictericia es un proceso fisiológico y que el riesgo depende del valor de bilirrubina que tenga en este momento.

e. Solicitar un dosaje de bilirrubina total y directa por guardia.

f. Solicitar un dosaje de bilirrubina total y sedimento urinario por guardia.

g. Suspender la lactancia materna por 24 horas e indicar fórmulas lácteas

h. Citar a una nueva consulta para el día siguiente por la mañana para realizar una evaluación de la ictericia con luz de día.

Pregunta 10

Malena de 10 años de edad acude al servicio de guardia del Hospital donde Ud. trabaja en una localidad del conurbano bonaerense, por presentar, desde hace aproximadamente 6-7 horas, tos seca de tipo opresiva.

Presenta como antecedentes personales rinitis alérgica y diabetes insulínica dependiente. Concorre al colegio con buen desempeño, practica hockey en el colegio y club del barrio, tiene una vida social activa, el último cumpleaños de un amigo lo tuvo hace dos días. Vive junto a sus padres, dos hermanos con diagnóstico de asma y una abuela con diabetes y patología cardíaca.

Ud. constata palidez cutánea, la nota con dificultad respiratoria, con tiraje supra-esternal, respiración superficial y taquipnea, frecuencia cardíaca 116/min. A la auscultación se aprecian abundantes sibilancias inspiratorias y espiratorias en ambos campos pulmonares, taquicardia rítmica, rinitis acuosa. Saturometría de pulso 92% aire ambiental.

Según su hipótesis diagnóstica, ¿qué conductas adopta? Marque 3 opciones

Seleccione una o más de una:

a. Indicar salbutamol 2 puff cada 4 horas en su domicilio

b. Indicar Claritromicina vía oral durante 14 días

c. Solicitar radiografía de tórax

d. Indicar budesonide inhalatorio cada 12 horas

e. Solicitar glucemia capilar

f. Indicar metilprednisona 1 mg/kg/día vía oral.

g. Solicitar estado ácido-base por punción arterial.

h. Indicar oxígeno humidificado y salbutamol en puff

Pregunta 11

Juan de 11 años y 9 meses de edad concorre a la Guardia acompañado por su madre, por quemadura de segundo grado en ambos miembros superiores secundario a un accidente doméstico.

Completó el plan nacional de vacunas hasta las de ingreso escolar a los 6 años, donde recibió triple bacteriana, triple viral y Salk.

Teniendo en cuenta los datos aportados, ¿cuáles son las conductas más adecuadas? Marque 3 opciones

Seleccione una o más de una:

- a. Aplicar vacuna antimeningocócica
- b. Aplicar HPV tetravalente
- c. Aplicar gammaglobulina antitetánica + vacuna Triple bacteriana acelular (dTpa)
- d. Aplicar vacuna doble adultos
- e. Reiniciar esquema completo de vacunación antitetánica
- f. No aplicar ninguna vacuna
- g. Aplicar Triple bacteriana (DTP)
- h. Aplicar vacuna Triple bacteriana acelular (dTpa)

Pregunta 12

En la consulta de control en salud de Rafael, un adolescente de 14 años de edad, usted registra los siguientes datos: Talla 165 cm (Pc 75-90), Peso 75 kg (Pc mayor a 97), IMC: 27 (+ 2 Puntaje Z), Tensión Arterial 115/70 mm/Hg (menor al Pc 90).

De la anamnesis surge que el padre de 42 años de edad y una tía paterna presentaron, hace un año, en un laboratorio de rutina, valores elevados de colesterol. Al examen físico: tejido celular subcutáneo aumentado, acantosis nigricans en cuello y axilas, se palpa borde hepático de consistencia firme, a 2,5cm por debajo del reborde costal.

¿Qué estudios indica? Marque 3 opciones

Seleccione una o más de una:

- a. ECG y ergometría
- b. En ayunas hepatograma, colesterolemia, trigliceridemia y glucemia.
- c. Monitoreo ambulatorio de la presión arterial durante 24 hs
- d. Uremia y creatininemia
- e. Interconsulta con Nutrición
- f. Ecografía abdominal
- g. Insulinemia y prueba de tolerancia oral a la glucosa
- h. Dosaje de hormonas tiroideas

Pregunta 13

Fernando, de 3 años concurre a la consulta acompañado por su madre por presentar agitación la cual comenzó luego de haber jugado por más de una hora, en el transcurso del cumpleaños de un compañero del jardín.

Examen físico:

Fernando se encuentra en buen estado general, rubicundo y cursa una rinitis leve.

Frecuencia respiratoria: 20 por minuto

Frecuencia cardíaca 100 por minuto.

Tensión arterial: 80/40 mm Hg.

Pulsos regulares y simétricos.

No hay frémito.

Soplo sistólico en mesocardio 2/6 que no oculta el primer ruido y desdoblamiento no fijo del 2º ruido en área pulmonar variable con la respiración.

El soplo disminuye en intensidad en posición de pie.

De acuerdo a sus hipótesis diagnósticas, ¿qué decide solicitar? Marque 2 opciones

Seleccione una o más de una:

- a. Espirometría
- b. Electrocardiograma
- c. Rx de tórax perfil con relleno esofágico
- d. Hemograma y eritrosedimentación
- e. Ergometría
- f. Eco Doppler
- g. Rx de tórax
- h. Ecocardiograma

Pregunta 14

Concurren a la guardia de un hospital del conurbano bonaerense Rocío con su hijo, Jonas, de 5 meses de edad, por presentar vómitos copiosos y reiterados de 12 horas de evolución, sin fiebre ni diarrea.

No refiere antecedentes personales de importancia.

Vacunación completa para la edad.

Al examen físico, el niño se encuentra en regular estado general, con mucosas semihúmedas, llanto sin lágrimas, relleno capilar menor de 2 segundos, buena turgencia de la piel y diuresis disminuida.

Presenta buena entrada de aire bilateral, sin ruidos agregados, frecuencia respiratoria 30/min, soplo sistólico

efectivo en mesocardio, frecuencia cardíaca 140/min.

Abdomen globoso, con dolor a la palpación profunda, escasos ruidos hidro-aéreos.

Tumoración en región inguino-escrotal derecha.

Usted decide solicitar exámenes de laboratorio y realizar observación en guardia. Resultados: Glóbulos blancos $7000/\text{mm}^3$, 75% de PMN, urea 42mg %, glucemia 80 mg%, ionograma: Na 138 mEq/l y K 4,2 mEq/l.

Con los datos obtenidos, ¿cuáles son las conductas más adecuadas para el abordaje de este caso? Marque 3 opciones *Selecione una o más de una:*

- a. Expansión con solución fisiológica.
- b. Solicitar radiografía de abdomen de pie y ecografía abdominal.
- c. Realizar TAC abdominal
- d. Indicar internación e hidratación parenteral
- e. Solicitar interconsulta con Cirugía
- f. Solicitar Rx de tórax
- g. Indicar sales de rehidratación oral y control en 6 horas
- h. Solicitar interconsulta con cardiología.

Pregunta 15

Hace 15 días, Joaquín de 1 año y 10 meses concurre con su mamá a la consulta con su médico de cabecera por presentar dolor abdominal y deposiciones desligadas desde hacía un tiempo atrás.

Con los resultados del laboratorio y ante la ausencia del médico de cabecera, lo consultan. Laboratorio:

Leucócitos 8500/dl. N35 L60 M4 E1 B0

Frotis de sangre periférica: glóbulos rojos pequeños, hipopigmentados.

Conteo de reticulocitos disminuido.

Coprocultivo: Escherichia coli no enteropatógena.

Test de Graham: se observan huevos de oxiuros y quistes de guardía lamblia.

Proteinograma electroforético: albúmina 2,9 gr%, a_1 : 0,30gr%, a_2 : 0,60 gr%, b: 0,70 gr%, g 0.8 gr%. Anticuerpo antitransglutaminasa: 1/400.

Rx de carpo mano izquierda: informa edad ósea 10

Selecione una o más de una:

- a. El valor del anticuerpo antitransglutaminasa es normal

b. Joaquín debe recibir tratamiento para oxiurus vermicularis con mebendazol

c. La descripción del frotis de sangre periférico es típica de una anemia ferropénica

d. El informe de la Rx de carpo podría indicar retraso de la maduración ósea.

e. Joaquín debe recibir tratamiento para guardia lamblia con metronidazol

f. Los valores de las inmunoglobulinas se encuentran en valores anormales

g. Los valores de la albúmina se encuentran en valores normales.

h. La presencia de Escherichia coli no enteropatógena se asocia a trastornos digestivos y requiere medicación antibiótica.

Pregunta 16

Lisandro de 8 meses concurre a la guardia con sus padres por presentar fiebre 38.5°C de 12 horas de evolución. Su madre refiere que Lisandro pasó toda la noche llorando y no pudo descansar bien. Además lo observa decaído y con rechazo parcial del alimento. Relata que hace una semana presentó tos y rinorrea acuosa.

Antecedentes personales: niño previamente sano, sin antecedentes perinatológicos ni patológicos de relevancia, alimentado con pecho y leche de fórmula, no usa chupete. Concorre a la guardería 6 hs diarias. Vacunas completas documentadas

Su familia está integrada por 3 hermanos sanos, madre y padre, ambos fumadores.

Al examen físico se observa que el niño está decaído, con fontanela normotensa, fauces levemente congestivas, adenopatías pequeñas cervicales y retroauriculares. Le realiza la otoscopia del oído derecho con los hallazgos que puede observar en la siguiente imagen. El oído izquierdo presenta congestión peritimpánica.



El resto del examen físico es normal. No presenta signos meníngeos.

En relación con su hipótesis diagnóstica, ¿qué conductas adopta? Marque 3 opciones

Seleccione una o más de una:

a. Promover la lactancia materna y evitar la exposición al humo del cigarrillo

b. Solicitar interconsulta con ORL

c. Conducta expectante

d. Indicar amoxicilina por 10 días y control según evolución clínica

e. Indicar miringotomía y cultivo de oído medio.

f. Indicar analgesia con paracetamol las primeras 48 hs

g. Indicar gotas óticas con Ciprofloxacina e hidrocortisona

h. Indicar tratamiento con claritromicina vía oral por 7 días

Pregunta 17

Isabela, de 17 meses, concurre por primera vez a la consulta en un centro de atención primaria. Desde hace 2 meses presenta 4 a 6 deposiciones desligadas abundantes diarias sin moco ni sangre.

Isabela es la menor de una familia numerosa que vive en La Matanza, donde no cuentan con agua corriente ni servicios cloacales.

Como antecedentes presentó dos bronquiolitis de seguimiento ambulatorio.

Ud. realiza el examen físico y registra: peso Pc 10, talla Pc 25, tejido celular subcutáneo escaso, normohidratada, abdomen globuloso, ruidos hidroaéreos presentes.

¿Cuáles son las conductas iniciales más apropiadas? Marque 3 opciones

Seleccione una o más de una:

a. Solicitar parasitológico en fresco y seriado

b. Indicar dieta libre de gluten

Pregunta 18

Concurre a la consulta Sergio, de 6 años de edad, con su mamá, Eugenia. Ella le pregunta acerca de los efectos de las vacunas.

Con relación a la vacunación Ud. le informa... Marque 3 opciones.

Seleccione una o más de una:

a. A partir de este momento se le administrará a Sergio la vacuna triple bacteriana acelular porque presenta menos efectos secundarios para el componente pertussis que la vacunas celulares tradicionales. b. Al ingreso escolar Sergio debe recibir un refuerzo de la vacuna antineumocócica.

c. A pesar de que la parotiditis es una enfermedad relativamente benigna, al haber recibido la vacuna, se evita en gran medida la meningoencefalitis y la sordera.

d. La vacuna antigripal que Sergio ya recibió reduce la incidencia de resfriados estacionales e. La aplicación de la vacuna BCG al nacer impide la posibilidad de adquirir tuberculosis a edades posteriores. f. La vacuna contra la varicela evita las formas graves, en caso de contraerla, la infección transcurre más leve y con pocas lesiones.

g. La vacuna antisarampínica es una vacuna a virus vivos atenuados que Sergio recibió al cumplir los 12 meses de edad la cual no requiere una dosis adicional de refuerzo.

h. Al ingreso escolar es necesario que Sergio reciba un refuerzo de vacuna antineumocócica conjugada.

Pregunta 19

Mariana, paciente de 13 años, sin antecedentes patológicos relevantes, convive junto a sus padres y una hermana de 16 años en el Conurbano Bonaerense.

Concurre a la consulta, en el centro de atención primaria donde Ud. trabaja, acompañada por Sol, su tía. Sol manifiesta que, desde hace 6 meses, Mariana comenzó con alteraciones de conducta. Describe que su sobrina come compulsivamente, vomita al poco tiempo, se aísla, llora, y cree que estaría ingiriendo, por su propia voluntad diuréticos. Le encontraron esta medicación en su habitación. Mariana no se alimenta ni ingiere líquidos desde la tarde previa a la consulta.

Al momento de la consulta se nota débil, con poca colaboración, habla muy poco, por momento llora, tendiendo a dormirse. No presentó fiebre.

El examen físico muestra: enoftalmos, lengua seca y saburral, gingivitis, frecuencia cardíaca 139 latidos/min, frecuencia respiratoria 21 respiraciones/min, TA: 80/40 mmHg, pulsos débiles, relleno capilar 3 segundos. Sin signos meníngeos. Se observan petequias en cara. Abdomen sin características para destacar. Se encuentra oligoanúrica.

Frente a esta situación y en el contexto donde Ud. está trabajando, ¿cuáles son las conductas iniciales más adecuadas? Marque 3 opciones.

Seleccione una o más de una:

- a. Solicitar dos hemocultivos
- b. Expandir con solución fisiológica
- c. Solicitar su internación
- d. Solicitar hemoglucotest (glucemia capilar)
- e. Indicar metoclopramida
- f. Indicar Ceftriaxone y Aciclovir EV
- g. Expandir con solución dextrosada al 5%
- h. Indicar líquidos fraccionados y controlar en 6 horas

Pregunta 20

Ud. se encuentra de guardia en un Hospital cuando Celeste, de 8 meses de edad, llega a la consulta por fiebre y una tumefacción en el muslo izquierdo de 6 días de evolución.

Según refiere la madre, 12 días antes de la consulta, la niña presentaba rinorrea serosa y fiebre, por lo que consultó en un centro de atención primaria, donde se le indicó dipirone intramuscular.

Tres días después, como continuaba con fiebre y tos, realizó una nueva consulta.

En esa ocasión, se le iniciaron nebulizaciones con solución fisiológica, ibuprofeno y amoxicilina a dosis

habituales. Luego permaneció afebril hasta el día de ayer.

No refiere antecedentes personales ni familiares de importancia.

Carnet de vacunas completo.

Examen físico: regular estado general, temperatura axilar 39°C, pálida, mucosas semi-húmedas. Buena entrada de aire bilateral, sin ruidos agregados,

Seleccione una o más de una:

a. Solicitar hemocultivos y toma para cultivo de la lesión

b. Indicar Trimetoprima-Sulfametoxazol vía oral y control en 24hs

c. Solicitar hepatograma, glucemia, urea y creatinina.

d. Solicitar interconsulta con Cirugía para drenaje

e. Solicitar radiografía de miembro inferior izquierdo

f. Indicar internación y tratamiento con Ceftriaxone endovenoso

g. Indicar internación y tratamiento con Clindamicina Endovenosa

h. Indicar Cefalexina VO y control según evolución clínica.

Pregunta 21

Julián de 15 meses de vida es el primer hijo de la pareja de Gimena y Marcelo. Nació por cesárea con 3.550 gramos a las 39 semanas de gestación.

Gimena, tiene 23 años y es ama de casa. Refiere que tiene rinitis alérgica y no fuma. Tiene ambos padres vivos y un hermano mayor con diagnóstico de psoriasis. Marcelo, tiene 30 años, refiere ser sano, fuma 15 cigarrillos diarios de tabaco y trabaja como empleado en una aseguradora. Vivem en un departamento de 2 ambientes en el barrio de Pompeya.

Julián ha tenido exantema súbito a los 6 meses de edad y varicela a los 9 meses con buena evolución en ambas enfermedades. Los padres refieren que Julián tiene las vacunas del calendario oficial completas.

El niño presenta exantema pruriginoso en miembros. Al examen físico usted constata lesiones eritematoescamosas en piel de la región de extensión de miembros superiores, inferiores y en mejillas (ver imagen). No hay lesiones en la zona del pañal. Presenta lesiones de rascado en las áreas afectadas. La piel del tronco es seca con descamación fina.



Ante este cuadro, ¿cuáles son las indicaciones más adecuadas? Marque 3 opciones

Seleccione una o más de una:

- a. Antihistamínicos vía oral
- b. Permetrina crema al 5% a toda la familia
- c. Tratamiento tópico con Micomazol
- d. Tratamiento tópico con corticoides
- e. Humectación diaria de la piel
- f. Realizar pruebas cutáneas con alérgenos
- g. Suspender tomates, frutilla, chocloates y pescados de la dieta
- h. Metilprednisolona 1mg/kg/día vía oral

Pregunta 22

La mamá de Sabrina de 14 días de vida, concurre a la consulta porquw la nota amarilla “cada día u poco más” El embarazo y el parto fueron normales. No se había notado ictericia en las primeras 48 horas. El peso de nacimiento fue de 3200 gramos y se alimenta a pecho exclusivo. Actualmente pesa 3.300 gramos Ante esta situación, usted, ¿qué conductas adopta? Marque 3 opciones

Seleccione una o más de una:

- a. Efectuarle una prueba de compatibilidad para descartar incompatibilidad ABO.
- b. Efectuarle una prueba de compatibilidad para descartar incompatibilidad Rh.
- c. Indicar luminoterapia dentro de las próximas 48 horas.
- d. Descartar lo antes posible la presencia de colestasis neonatal.
- e. Suspender la alimentación materna e indicar que Sabrina se alimente con fórmula maternizada.
- f. Efectuarle una determinación de bilirrubina total, directa e indirecta.
- g. Investigar la coloración de la orina y la materia fecal de Sabrina.
- h. Tranquilizar a la madre y explicarle que la ictericia que Sabrina presenta disminuirá paulatinamente durante los próximos días.

Pregunta 23

Yanina de 3 años de edad junto a sus padres y 3 hermanos habitan una vivienda precaria de un barrio humilde del conurbano bonaerense. Carecen de cloacas y asfaltado. Tienen 2 perros y 1 gato que comparten también la casa.

La madre refiere que la niña es sana, pero que en el último tiempo presentó 2 episodios broncoobstructivos. Además, agregó, que en algunas ocasiones tuvo vómitos y disminución del apetito y que una oportunidad registró fiebre.

A la observación llama la atención la existencia de mayor sequedad y prurito cutáneos.

Yanina

Con su mamá concurren al Hospital para mostrarle los resultados de exámenes complementarios solicitados por otro colega hace una semana, fecha en la que Yanina fue llevada por cuadro de dificultad respiratoria y se le administró un tratamiento adecuado.

Actualmente ha mejorado de su cuadro bronquial. La vacunación es completa para la edad.

Los estudios informan: Hemograma: Leucocitos: 10800/mm³; 46%;; L:28%; E:26%; B:0%; M:0%; Hemoglobinemias 10,1g/dl; plaquetas: 236000/mm³. Hepatograma: TGO: 20 UI/L; TPG:48 UI/L. Urea:32 mg/dl. Sedimento urinario: L: 0- 1/cpo; H:0-1/cpo.

De acuerdo a su hipótesis diagnóstica, usted, ¿qué solicita? Marque 3 opciones.

Seleccione una o más de una:

- a. TAC de tórax y abdomen
- b. Interconsulta con Hematología
- c. Coproparasitológico y serología para toxocariasis
- d. RX de abdomen de pie
- e. Pruebas cutáneas para alergia
- f. Fondo de ojo
- g. Ecografía abdominal
- h. RX de tórax

Pregunta 24

Marina, de 6 años de edad, llega a la consulta del servicio de emergencias, por presentar desde hace 5 días, intenso dolor abdominal periumbilical de 48 horas de evolución.

Durante los últimos tres días se ha quejado de dolor en las rodillas y los tobillos.

Desde la mañana de hoy, presenta dificultades para caminar.

La mamá de Marina, refiere que su hija se ha alimentado normalmente y no ha tenido episodios de vómitos. Las deposiciones son normales. La diuresis está conservada.

Examen físico:

- Fauces discretamente congestivas
- Abdomen blando, depresible. Discreto dolor a la palpación. No se palpan visceromegalias •

Se encuentra afebril

- Frecuencia cardiaca de 80 latidos/minuto
- Frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto
- Tensión arterial 108/60 mm Hg.
- Se observa tumefacción en ambos tobillos y exantema eritematoso que no desaparece a la vitropresión, sobre elevado, en las extremidades inferiores.

No refiere otros antecedentes de importancia

Presenta vacunas completas para la edad.

Con la informacoón disponible, ¿qué exámenes complementarios son los más apropiados para indicar? Marque 3 opciones

Seleccione una o más de una:

- a. Interconsulta con el Servicio de Ortopedia y Rraumatología
- b. Función renal y orina completa**
- c. Hemograma con recuento de plaquetas**
- d. Colagenograma
- e. Punción de medula ósea
- f. Exuado de fauces
- g. Coagulograma**
- h. Anticuerpos antinucleares

Pregunta 25

Elsa, vive con su esposo, en un barrio de clase media desde hace 10 años.

Hoy concurre con Daniel, su hijo de 18 meses de edad, para control.

Al examinarlo, ¿cuáles son los parámetros de desarrollo madurativo que debe identificar en Daniel? Marque 3 opciones

Seleccione una o más de una:

- a. Realizar gabaratos con un lápiz**
- b. Decir 2 palabras juntas con significado
- c. Iniciar el control de esfínteres diurno**
- d. Realizar una torre de 4 cubos
- e. Reconocer 3 colores
- f. Señalar 2 figuras**
- g. Correr ligero
- h. Dibujar un círculo

EFUS 2021

MARZO 2021

Pregunta 1

Ariel de **4 años** de edad concurre con su madre a la consulta, **por aparición reciente de lesiones puntiformes eritematosas que no desaparecen a la presión y lesiones violáceas planas en cara, tronco y extremidades**

No refiere antecedentes de traumatismos, (aunque su madre dice que habitualmente es muy inquieto), **no tiene antecedentes patológicos, ni ingesta reciente de medicamentos.**

De sus antecedentes personales: nació de término con peso adecuado para la edad gestacional, parto vaginal sin complicaciones.

Vacunas refiere que recibió hasta el año de edad, no trae carnet. Padres separados, tiene una hermana adolescente con sobrepeso. **Tiene mascotas: dos gatos.**

EXAMEN FÍSICO: se encuentra afebril (**temperatura de 36 grados C**), con decaimiento general. **Se constatan petequias y hematomas en cara, tronco y extremidades. Presenta petequias en paladar duro sin objetivarse signos de sangrado activo.**

Se decide realizar Hemograma que informa: hemoglobinemia 12,4 g/dl , **Leucocitos 6.700/mm³** **7-13**, (con fórmula a predominio linfocitario) y **plaquetas 45.000/mm³** .

Sospecha PTI Flor_cor página 105

En función del diagnóstico presuntivo, ¿cuáles son las conductas más apropiadas? Marque hasta 3 opciones. *Seleccione una o más de una:*

- a. Solicitar TAC de cerebro urgente.
- b. Solicitar punción de médula ósea.
- c. Asumir por el momento como diagnóstico presuntivo Púrpura Trombocitopenia inmune.**
- d. Internar al paciente.**
- e. Solicitar coagulograma, sedimento urinario, serología para EBV, CMV, parvovirus B19, Hepatitis B, C y HIV.**
- f. Solicitar coagulograma, determinación de IgA y ASTO.
- g. Asumir por el momento como diagnóstico presuntivo Púrpura de Schonlein Henoch.
- h. Solicitar consulta con Servicio Social.
- i. Solicitar serología para Bartonella Henselae.
- j. Control ambulatorio en 24 horas.

Pregunta 2

Ingresa al servicio de emergencia, **Josefina de 15 años**, acompañada por una amiga desde “La Previa” de una fiesta de graduación. Ya avisó a la madre.

La paciente presenta un **discurso incoherente, aliento etílico, marcha tambaleante con aumento de la base de sustentación y resto de vómito alimentario en sus prendas**. Signos vitales FC 100 latidos/minuto **70-100**, TA 90/60 mmHg **90-140/60-95**, T 35.7° C, Glucemia 60 mg/dl **50-110**.

Al llegar la madre, nos cuenta que Josefina cursa **3er año de la secundaria con buen rendimiento escolar**, hace deportes, tiene amigos y es una joven alegre. Refiere que nunca “hizo algo así”, y eso la angustia.

En este caso, ¿cuáles son las conductas iniciales más adecuadas? Marcar hasta 3 opciones. *Seleccione una o más de una:*

a. Indicar plan de hidratación con suero dextrosado.

b. Monitorear signos vitales, control de glucemia y solicitar tóxicos en orina.

c. Solicitar resonancia magnética de cerebro.

d. Solicitar la intervención del Servicio Social, por ser menor. (La madre ya esta acompañar)

e. Indicar carbón activado.

f. Solicitar EAB, ionograma, glucemia, urea, creatinina, hepatograma.

g. Solicitar interconsulta con Salud Mental.

h. Indicar O2, realizar lavado gástrico y sonda nasogástrica abierta.

i. Indicar **expansión** con solución fisiológica.

j. Tranquilizar a la madre, explicando que **todos los adolescentes tienen este tipo de conductas**.

Pregunta 3

Tomás de 5 años, concurre a la guardia del hospital, acompañado por sus padres que se muestran preocupados porque había **presentado dolor abdominal y emisión de orinas oscuras en dos oportunidades**. Hasta la mañana de ese día, el niño, había concurrido al jardín sin haber presentado ninguna sintomatología previa.

Ambos padres son empleados bancarios y tienen 25 años de edad y viven en un departamento de 3 ambientes en Capital Federal.

EXAMEN FÍSICO

- Peso: 16²⁰⁰kg (Pc 10-25). Talla: 106 cm (Pc 10-25).
- **Rinitis serosa moderada**
- **Discreta palidez de piel y mucosas**
- **Lesión costrosa residual de 2 cm de diámetro en su rodilla izquierda de 15 días de evolución.**
- **Ganglio palpable en región inguinal derecha de 1 cm de diámetro y otro de 1.5 cm de diámetro ligeramente doloroso en región inguinal izquierda.**

- **Ganglios de 0.5 cm de diámetro en región suboccipital.**

- Hígado a 1 cm del reborde costal, indoloro. Bazo no palpable.

- **Godet incipiente en miembros inferiores.**

- **Eritema moderado en fauces.**

- Tº axilar. 36,4ºC

- Frecuencia respiratoria: 20 respiraciones/minuto. 15-25

- Frecuencia cardíaca: 100 latidos/minuto 90-120. Resto del exam en físico sin particularidades. ¿Cuáles son las conductas iniciales más adecuadas? **Marcar hasta 4 opciones.** Dx SME nefritico Flor_co 92

Seleccione una o más de una: +

a. Hemograma, urea, creatina e ionograma

b. Lipidograma (para dx diferencial con nefrotico ya que este presenta dislipidemia y no tenemos la la proteinuria de 24hs)

c. Tele Rx de tórax (Siempre a nefritico y nefrotico se les pide RX para ver si hay signos de congestión pulmonar.)

d. Frotis de sangre periférica para observación de glóbulos rojos crenados (No, porque esa opción seria para descartar un SUH)

e. Cultivo de secreciones nasales

FatIta

Pregunta 4

Julián, de 18 meses de edad, presenta **episodios reiterados de diarrea y notario “muy flaquito”**. Llega a la consulta con su madre **quien refiere que desde hace 3 meses presenta episodios de diarrea, con 4 a 6 deposiciones grumosas, malolientes - Esteatorrea, que no mejoran con la dieta que le recomendaron varias veces en la guardia.**

No presenta antecedentes personales ni familiares de interés. Julián vive con sus padres y los abuelos maternos en una **vivienda precaria** en el tercer cordón del conurbano. La vivienda tiene un dormitorio común, cocina, **agua de pozo y letrina.**

Julián tomó el pecho hasta **los 6 meses y luego leche de vaca y papillas, recibió hierro y vitaminas durante 2 meses.**

Actualmente come con sus padres preferentemente guisos y sopas. Vacunas completas con carnet.

EXAMEN FÍSICO: **impresiona algo pálido, con mirada vivaz, hidratado, abdomen globuloso y timpánico a la percusión.** Miembros inferiores algo adelgazados . Peso 9100 plo 3-10, talla 82 cm plo 25. Dermatitis de pañal.

Recientemente le hicieron algunos análisis: **Hto 29%** 35-44, **Hb. 10.1 gr/dl** 11-13,5, G. blancos 8500/mm3 7-13, neutrófilos 37% 35-60, **Linfocitos 51%** 25-50, eosinófilos 3% 1-5, basófilos 1% 0- 1, **monocitos 8%** 1-6. Orina **completa densidad 1012** 1015-1025, **pH 7** , sedimento escasos leucocitos, **y hematíes, algunos piocitos**, resto normal, inmunoglobulinas normales, anticuerpos antitransglutaminasa negativo, parasitológico pendiente.

Con respecto a las causas de la diarrea, ¿cuáles son, al momento, sus hipótesis diagnósticas? Marcar hasta 2 opciones. *Selecione una o más de una:*

Dx Parasitosis Flor_cor 88

- a. Alergia a la proteína de la leche de vaca (No, porque no hay contexto)
- b. Diarrea por malabsorción de lactosa (No, porque no hay contexto)
- c. Diarrea por mala absorción de grasas (por deposiciones malolientes y grumosas)
- d. Diarrea perdedora de proteínas (No, porque no hay contexto es por EEI clínica debería tener desinteria)
- e. Probable enfermedad inflamatoria intestinal (No, porque no hay contexto es por EEI clínica debería tener desinteria)
- f. Probable giardiasis intestinal
- g. Diarrea por rotavirus (No, es una diarrea osmótica y en este caso es esteatorrea)

Pregunta 5

Los padres de **Mariano de 24 meses**, consultan **preocupados por el crecimiento de su hijo**. Su último control fue a los 8 meses de edad y refieren que no lo trajeron a nuevos controles porque la salita de su barrio estuvo cerrada y no les alcanzaba el dinero para acercarse al hospital. La madre comenta preocupada que **desde que nació el hermanito hace 6 meses notaron que no crece y lo ven cada vez más delgado**.

El niño recibió lactancia exclusiva hasta lo 6 meses, luego de lo cual incorporó alimentación complementaria y continuó con pecho materno hasta los 16 meses. El padre refiere graves problemas económicos y falta de ayuda de su familia, por lo cual, **en ocasiones el niño no realiza más de una comida por día**. La dieta del niño se basa principalmente en hidratos de carbono como arroz y polenta.

La madre trae consigo una libreta con los siguientes datos: Peso al nacer: 3.100g

- Peso a los 2 meses en percentilo 50
- Peso a los 4 meses en percentilo 25/50
- Peso a los 8 meses en percentilo 50

EXAMEN FÍSICO: **paciente emaciado, con ligero edema en ambos pies, con abdomen distendido y pelo quebradizo**.

Peso por debajo de los -3DE. Flor_co 166 DESNUTRICIÓN CRÓNICA CALÓRICO-PROTEICA San justo 1 362

¿Cuáles son las conductas más adecuadas que deben adoptarse? Marcar hasta 4 opciones. *Selecione una o más de una:*

- a. Internar al paciente para ampliar estudios y comenzar tratamiento. (Hay criterios porque presenta desnutrición desnutrición crónica)
- b. Iniciar aportes de hierro a dosis tratamiento lo antes posible. (Hay que tratar la desnutrición desnutrición grave como conducta inicial)

c. Solicitar interconsulta a gastroenterología para descartar enfermedad celíaca. (No, porque el caso clínica apunta para situación socioeconómicos)

d. Priorizar la valoración y tratamiento de la hipotermia, deshidratación e hipoglucemia.

e. Calcular el aporte energético que requiere el niño e indicar alimentación administrando 1.5 veces el valor calculado. (No, porque no es una conducta inicial, falta datos)

f. Solicitar interconsulta con Psicopatología para que la familia trate los celos entre hermanos.

g. Indicar no superar las 4 comidas diarias. (No, porque hay que indicar comidas con frecuencia y en pequeñas raciones 7 x día)

h. Interpretar como desnutrición secundaria, solicitar orina completa y citar a control con el resultado. (No, porque el contexto de caso dice la situación socioeconómica y dice que baja ingesta)

i. Indicar pesar diariamente al paciente. (el peso es uno de los mejores indicadores nutricionales)

j. Administrar suplementos de potasio y magnesio en caso de desequilibrios electrolíticos.

Pregunta 6

Manuel, de 16 años, concurre con su papá al consultorio de Pediatría por una tumoración en la axila derecha, de 30 días de evolución, en ocasiones levemente dolorosa. Nunca tuvo fiebre. El padre le comenta que hace 15 días consultaron a un centro de salud cercano, donde le indicaron tratamiento oral con antibióticos que cumplió durante 10 días, pero que al no notar cambios, decidió volver consultar.

Ellos viven en el conurbano, alquilan una habitación en un hotel familiar, baño y cocina compartidos. No tienen cloacas y agua de bomba. Tienen en la casa un gato.

El padre refiere notar que bajó mucho de peso en los últimos 4-5 meses. Antecedentes de vacunación completa con cicatriz de BCG.

EXAMEN FÍSICO: buen estado general, afebril, en suficiencia cardiorespiratoria; Peso: 50 kg (Pc 10), Talla: 166 cm (Pc 25-50). Se constata una tumoración axilar derecha, dura, algo dolorosa a la palpación, de 4 x 4 cm de diámetro aproximado, adherida a planos profundos, lo que limita moderadamente la movilidad del miembro superior derecho. No presenta otras adenomegalias, sí se palpan microadenopatías submaxilares e inguinales. Resto de examen físico sin otras particularidades.

Usted decide realizar estudios para la aproximación diagnóstica del cuadro de Manuel, ¿cuáles son los que solicita en un primer momento? Marcar hasta 4 opciones. DX TBC, aranazo de gato, linfoma, **pequisar ADENOPATÍAS en clínica completo 1547 San justo 2, 644 /flor_co**

Seleccione una o más de una:

a. Centellograma corporal con tecnecio 99 (No, porque no es conducta inicial, solo si dx de linfoma para evaluar progresión)

b. Punción – aspiración del ganglio axilar

c. Radiografía de tórax de frente y perfil

d. Radiografía comparativa de miembros superiores

e. Centrollograma con Galio

f. Tomografía de tórax y abdomen

g. Hemograma con frotis, eritorosedimentación, hepatograma (Ante una cifra de leucocitos elevada en un paciente, el laboratorio será observar el frotis de sangre periférica en busca de linfocitos de aspecto centrocítico.

h. Ecografía-doppler de axila derecha y abdomen

i. Hemograma, urea, creatina, ionograma

Pregunta 7

Thiago de 3 años de edad, reside en una zona periférica a un barrio privado del conurbano de la provincia de Buenos Aires, **vivienda familiar** precaria de un solo ambiente **con agua de pozo y baño con descarga**, sin antecedentes patológicos de importancia, con vacunas completas para la edad.

Es el **6to hijo de 7 hermanos**, el padre Cartonero, recoge desechos de los barrios lindantes y a veces Thiago lo acompaña.

Thiago, sin antecedentes patológicos de importancia y con las vacunas completas para la edad, en el último mes, ha comenzado **con un cuadro clínico de distensión y dolor abdominal asociado al hábito de geofagia con vómitos alimentarios esporádicos y tos.**

En las últimas 72 horas **el dolor abdominal se hizo más intenso**. Llega a la consulta por guardia. Al momento de su ingreso, el paciente presentaba los siguientes signos vitales:

Presión arterial 96/71 mm Hg **80-120/50-80**; frecuencia cardíaca 110 latidos/minuto **90-120**; frecuencia respiratoria 25 respiraciones/minuto **15-25**; temperatura 36,2°C; SpO2 95% AA. Datos antropométricos: peso 13kg; talla 95 cm; IMC 14kg/m2. Valoración nutricional según parámetros de la OMS: T/E= entre 0 y -1 **ok** DE; P/T = -1 DE; IMC = -1 DE.

Palidez mucocutánea, BEAB, se **auscultan algunos rales subcrepitantes bibasales**, **abdomen globoso, doloroso a la palpación profunda, a la predominio de la región periumbilical**, sin reacción peritoneal, hígado a 1 cm de reborde costal, se palpa polo de bazo.

Se realizó: **radiografía de tórax con infiltrado intersticial inespecífico y radiografía de abdomen de pie con asas intestinales distendidas y niveles hidroaéreos.**

Los análisis de laboratorio evidenciaron: **glóbulos blancos 18000/mm³** **7-13**, NS 40% **35-60**, **15% Eo** **1-5**, M 5% **1-5**, **Hb 9.8 gr/dl** **11 -13,5**, VCM 65 fl **80-100**, **albúmina de 3,1 g/dl** **3,2-5,4**, transaminasas normales, fosfatasa alcalina (FAL) normal.

Sedimento urinario: ph 6, densidad 1020, Leucocitos 2-3/cpo.

¿Cuál de las siguientes conductas iniciales considera las más correctas? Marcar hasta 3 opciones. *Selecione una o más de una: (Igual pregunta página 129)* **SOSPECHA Dx Parasitosis intestinales complicada obstrucion intestinal por**
San justo 2 pag 723

- a. Indicar tratamiento antibiótico empírico parenteral (No hay sospecha de neumonía, la sospecha es parasitosis que hace el ciclo de Loofer que justifica los rales subcrepitantes bibasales)
- b. Solicitar tomografía de abdomen **con doble contraste**
- c. Realizar endoscopia digestiva (No, porque solo en casos específicos)
- d. Indicar enemas con solución fisiológica (No hay indicación en esta situación)
- e. Comenzar con ayuno y colocar sonda nasogástrica abierta
- f. Comenzar con líquidos **vía oral** fraccionados
- g. Indicar tratamiento antiparasitario **urgente**
- h. Indicar hidratación por sonda nasogástrica
- i. Realizar interconsulta con Servicio de Cirugía Infantil
- j. Indicar hidratación parental

Pregunta 8

Antonio concurre a control de salud. Es un niño de **3 años** al que le **diagnosticaron desnutrición leve** en un centro de salud y por haberse mudado de ciudad, realizará seguimiento en su hospital.

Examen físico: **buen estado general**, con **peso y talla por debajo del percentilo 3**. Ambos en -2,5DE. La madre mide **1,6 (pc 50)** y el padre **1,75 (pc 75)** metros.

Trae los siguientes registros de peso y talla:

- Peso y talla a los 2 meses en percentilo 50
- Peso y talla a los 6 meses en percentilo 50 Peso a los 12 meses en percentilo 25
- **Peso a los 18 meses en percentilo 10 y talla en percentilo 25**
- **Peso a los 24 meses en percentilo 3 y talla en percentilo 10**

La familia no manifiesta tener problemas socio económicos y le comentan que realizan 4 a 5 comidas por día, en muchas de las cuales el **niño se niega a ingerir alimentos**. Dx desnutrición crónica flor _co 163

Con los datos recolectados hasta el momento, ¿qué conducta considera la más adecuada? Marcar hasta 4 opciones. *Seleccione una o más de una:*

- a. Indicar internación (No, porque no hay criterio) se hace control semanal
- b. Interpretar la desnutrición como crónica
- c. Explicar a la familia que el primer año de vida el niño tuvo una velocidad de crecimiento normal.
- d. Considerar la enfermedad celíaca como diagnóstico diferencial
- e. Indicar tratamiento de renutrición y control ambulatorio en un mes. (no, porque el control es semanal)
- f. Indicar hierro y vitaminas parental (No, porque falta datos)
- g. Explicar a los padres que se trata de una baja talla familiar (No, porque no es el caso de baja talla familiar es por

desnutrición crónica)

h. Interpretar que la velocidad de crecimiento entre los 18 y 24 meses de vida es normal.

(no, porque hay cruce de percentilos)

i. Interpretar que la relación peso / talla del paciente es normal

j. Interpretar como desnutrición aguda (No, porque es una desnutrición crónica)

Pregunta 9

Rodrigo, de **4 años**, consulta porque desde hace **6 días presenta hematomas inicialmente eran 2-3 lesiones, pero han aumentado en número y tamaño.**

Es un niño de buen carácter y algo travieso, pero **no refiere traumatismos** especiales en los últimos 6 días. EXAMEN FÍSICO

Rodrigo se encuentra en **aceptable estado general, afebril y con desarrollo pondoestatural normal. Presenta discreta palidez cutánea**, aunque las mucosas están bien coloreadas.

En la **piel presenta manchas que tienen el aspecto de hematomas, de tamaño variable, en piernas, caderas y codo derecho, en distinto estadio de evolución, así como petequias puntiformes a lo largo de todo el tronco y algunas en extremidades.** La auscultación cardiopulmonar es normal.

El abdomen es blando depresible e indoloro sin visceromegalias. No se palpan adenomegalias y el examen neurológico es normal.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

- Hematíes: 4.100.000/mm³ (3800 - 5300) . Hb: 12,4 gr% (11 - 13,5) Htc 37% (35 - 44).
- Leucocitos: 7200 (7 - 13 mil); N 60 (35-60) ; N en cayado 4 (0 - 5); L 28 (25 - 50); M 6; E 2 B 0.
- Plaquetas: 18.000/mm³. (150 - 400 mil)**
- **ERS: 14 mm/h. (0 - 10mm)**
- Quick: 80% KPTT: 36 seg. (35 - 45seg)

En relación con el diagnóstico presuntivo de Rodrigo, Ud. responde a diversas inquietudes formuladas por sus padres. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sería la **información más adecuada** que Ud. les brindaría? Marcar hasta 3 opciones. **DX PTI** **Flor_co 104**

Seleccione una o más de una:

a. La posibilidad de que se transforme en una condición crónica es excepcional.

b. La posibilidad de un desenlace fatal para Rodrigo es excepcional. (si, porque hay remisión completa en los dx recientes)

c. Antes de comenzar el tratamiento es imprescindible efectuarle a Rodrigo una punción de médula ósea.

d. En general casos como los de Rodrigo revierten antes de los 6 meses.

e. Es frecuente el antecedente de infección viral previa. (50% de los casos de PTI es precedida de infección)

f. La esplenectomía es una eventualidad probable a la edad de Rodrigo.

g. Habitualmente el problema de Rodrigo suele presentar antecedentes familiares.

h. El pronóstico definitivo no depende de la edad de presentación. (No, porque SI es dependiente de la edad)

i. Deben realizar interconsulta urgente con oncología infantil. (No, porque hay remisión completa)

j. Superado el cuadro, Rodrigo puede realizar actividad física de contacto con valores normales de hemoglobina.

Pregunta 10

Filomena, de 18 meses llega la guardia donde usted se desempeña acompañada por sus padres. Presenta un comunicación interventricular, fiebre de 48 horas de evolución, que durante las últimas horas se acompaña por cianosis progresiva.

EXAMEN FÍSICO: Peso 10 kilos. FC 175 latidos por minuto 100-130, TA 80 / 45 mm Hg 80-105/45-70, FR 40 por minuto 20-30, oximetría con aire ambiental 80% 95-100, temperatura axilar 38°C. Se evidencia mal estado general, cianosis intensa generalizada, irritable. Dos ruidos en 4 focos, sin tercer ruido, soplo sistólico en mesocardio, pulsos femorales palpables, pulsos pedios disminuidos, manos y pies fríos. Hipoventilación más marcada en hemitórax izquierdo sin crepitantes. Se palpa el borde hepático 3 cm por debajo del reborde costal derecho.

LABORATORIO AL INGRESO: Hemoglobina 12,7 g/dl 11-13,5, hematocrito 39% 35-44, leucocitos 5.110 por mm³ Leucopenia 6-15 (NS 42% 35-60, L 53% 25-50), plaquetas 50.300 por mm³ 200-400. PCR 248 mg/l. Glucemia 168 mg/dl, creatininemia 0,6 mg/dl. Natremia 131 mEq/l 135-145, kalemia 3,2 mEq/l 3,5-5, calcemia 6,5 mg/dl 8-10,5. EAB venoso con FiO₂ 0.21; pH 7,2; pCO₂ 68 mm HG, pO₂ 58 mm Hg, HCO₃ 24,8 mEq/l, EB -3,78 mEq/l.

¿Cuál es el diagnóstico inicial y qué tratamiento iniciaría? Marcar hasta tres opciones. Dx shock séptico

Seleccione una o más de una:

a. Contraindicar las expansiones con solución fisiológica por hepatomegalia

b. Sepsis de probable origen respiratorio

c. Indicar insulina corriente intramuscular

d. Corregir la hipocalcemia

e. Administrar antibióticos parentales después de estabilizar al paciente

f. Administrar O₂ por máscara

g. Shock séptico de probable origen respiratorio

h. Colocar un acceso vascular central de larga permanencia

i. Crisis de disnea y cianosis (No, porque es un shock sepetico)

j. Endocarditis bacteriana subaguda

Pregunta 11

Concurre al consultorio la madre de César, de 4 semanas, por persistencia del color amarillo de la piel, que apareció al cuatro día de vida. No presentó vómitos y las deposiciones desligadas de color amarillo oro son tres al día. En dos oportunidades anteriores consultaron y fue interpretado como fisiológico. Trae un examen de orina completo normal.

Antecedentes personales: embarazo controlado, con serologías para rubéola y toxoplasmosis inmunes, así como para sífilis, hepatitis B y HIV negativas. Parto vaginal con presentación cefálica. Edad gestacional 41 semanas. Peso de nacimiento 3850 gramos. Apgar 9/10. Peso al alta a las 48 horas 3580 gramos, sin ictericia, con lactancia materna exclusiva. Grupo y factor materno A Rh (+) y de César A Rh (-). Cribado hipotiroidismo, fenilcetonuria y FQP negativos.

Antecedentes familiares: ambos padres sanos sin consanguinidad ni antecedentes de hepatopatía crónica.

EXAMEN FÍSICO Peso: 4450 gramos. Talla 51 cm. Perímetro cefálico 36 cm. Signos vitales: FC 140 lpm 120-180, FR 34 por minuto 30-50, temperatura axilar 36°C, oximetría con aire ambiental 95%. Buen estado general, ictericia de cara y tronco (zona 4 de Kramer). Cefalohematoma parietal derecho muy pequeño. Se palpa el borde hepático como 2 cm por debajo del reborde costal derecho a nivel de línea medio-clavicular, sin esplenomegalia. Resto sin particularidades.

Laboratorio: bilirrubinemia total 14.4 mg/dl 1, bilirrubinemia directa 1.8 mg/dl 0-0.2, TGP 15 UI/l 37, TGO 52 UI/l 37, glucemia 90 mg/dl, prueba de Coombs directa negativa. Dx ictericia fisiológica Florco 21

¿Cuáles son sus hipótesis y conductas iniciales? Marcar hasta 3 opciones.

Seleccione una o más de una:

- a. Asociar la ictericia de César al cefalohematoma.
- b. Indicar tratamiento antibiótico parental después de obtener urocultivo.
- c. Solicitar ecografía de abdomen urgente.
- d. Indicar fototerapia con cobertura ocular e genital. (No, porque es indicado >17mg)
- e. Confirmarle a los padres que se trata de una ictericia fisiológica del neonato. (Es a predominio de bilirrubina no conjugada)
- f. Indicar alimentación con fórmula sin lactosa y proteínas parcialmente hidrolizadas.
- g. Explicar a los padres que este cuadro se resolverá espontáneamente sin complicaciones.
- h. Informar a los padres que se trata de una ictericia por incompatibilidad Rh.
- i. Indicar que se prenda al pecho no menos de 8 veces al día.
- j. Suspender la lactancia materna.

Pregunta 12

Usted se encuentra en la guardia de pediatría de hospital general de su ciudad. Ingresa desesperada una madre con su hijo, Astor, de **4 años** de edad en brazos, quien **presenta importante compromiso del estado general y dificultad respiratoria con disnea grave, sialorrea, disfonía, estridor, tos y tiraje supraesternal.**

La madre refiere que **comenzó bruscamente.** No refiere antecedentes de importancia. La madre desconoce que estaba haciendo, porque estaba en otro lugar de la casa.

Se comprueba la **estabilidad hemodinámica y respiratoria en ese momento, con tensiones arteriales normales, frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto 90-120 y saturación periférica de oxígeno de 82%** con aire ambiente. **Afebril.** Se administra oxígeno suplementario al 50% con máscara facial, que eleva la saturación periférica al 92%. En la exploración física **se destacan sibilancias en hemitórax derecho a la auscultación pulmonar.**

Ante esta situación clínica, ¿cuáles son las conductas más apropiadas? Marcar hasta 3 opciones. *Selecione una o más de una:* **DX DIFERENCIAL: ENFERMEDADES QUE SIBILAN: CUERPO EXTRAÑO o Aparición brusca + crisis asfíctica**

- a. Indicar el tratamiento con metilpredisolona cada seis horas y adrenalina nebulizada. (No, porque no hay indicación)
- b. Realizar el barrido digital a ciegas de fauces para retirar cuerpo extraño.**
- c. Colocar al niño en posición de olfateo con oxígeno suplementario.**
- d. Asumir que se trata de epiglotitis aguda. (no, porque no hay clínica compatible)
- e. Asumir al paciente en insuficiencia respiratoria, indicar intubar y derivar a la terapia, previa colocación de vía periférica. (No, porque no es conducta inicial)
- f. Realizar la maniobra de Heimlich. (No, porque solo se hace si sospecha de obstrucción en vía aérea alta)
- g. Asumir el cuadro como una crisis asmática. (No, porque no hay datos clínicos anteriores)
- h. Indicar tratamiento **antibiótico E.V.**
- i. Sospechar la presencia de un cuerpo extraño y solicitar radioscopia.**
- j. Derivar a centro que cuente con endoscopia respiratoria.**

Pregunta 13

Concurren a la consulta Juan y Marcela con su hija **Camila de 6 años** de edad. Refieren con preocupación que la niña presentó en el corriente año, **dos episodios afebriles de "ardor al orinar"**, acompañados de micciones frecuentes y, en forma esporádica, incontinencia urinaria.

Recibió tratamiento con distintos antibióticos con involución de los síntomas mencionados. El tratamiento **siempre fue precedido por toma de urocultivo y en forma recurrente cultivó + de 10⁵ UFC/ml de Escherichia Coli.**

Camila presenta examen físico dentro de límites normales, eutrófica con Peso en Pc 50 y Talla Pc 75. Diuresis: retención y 2-3 micciones diarias. Catarsis: cada 2-3 días, con escóbalos.

¿Qué conductas iniciales considera las más adecuadas? Marcar hasta 3 opciones.

Seleccione una o más de una:

- a. Indicar profilaxis antibiótica con cefalexina durante **6 meses**
- b. Derivar al urólogo por **incontinencia urinaria**
- c. Recomendar vaciado vesical frecuente 9 (6-8 micciones por día)
- d. Indicar ecografía renovesical
- e. Realizar **pielografía**
- f. Indicar **enemas** evacuantes de Murphy
- g. Indicar microenemas
- h. Incrementar la ingesta de líquidos, dieta rica en fibras y adecuada higiene genital
- i. Indicar cistouretrografía miccional (No, porque no es conducta inicial)
- j. Indicar profilaxis antibiótica con nitrofurantoína durante **6 meses**

Pregunta 14

Llega a la guardia Rocco, de **6 años** de edad, con **mielomeningocele**. Consulta por **fiebre de 48 horas de evolución**. **Luego de examinarlo**, se decide solicitar los siguientes exámenes complementarios: laboratorio de sangre y orina. **Mientras esperan los resultados el niño juega con un guante inflado** con sus padres en la sala de espera. Comienza con **dificultad respiratoria, estridor laríngeo y exantema urticariano**.

EXAMEN FÍSICO: frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto **90-120**, saturación 96% con aire ambiente y ITA 90/55 mmHg. **Se auscultan sibilancias y se observa exantema urticariano en tronco y abdomen**.

(Anafilaxia apunte clínica todo 1, página 1492) obs mielomeningocele hay alergia a latex

Frente a este cuadro, ¿cuáles son las conductas iniciales más adecuadas? Marcar hasta 3 opciones. *Seleccione una o más de una:*

- a. Administrar adrenalina intramuscular
- b. Administrar tratamiento tópico con corticoides en las lesiones de piel
- c. Indicar corticoides por **vía oral**
- d. Indicar **antihistamínicos** EV e **altas dosis** (no es conducta inicial, se lo adm después para prevenir recurrencias)
- e. Indicar glucocorticoides EV a altas dosis
- f. Colocar venoclisis y administrar oxígeno
- g. Indicar antihistamínicos por **vía oral**
- h. **Intubar** electivamente al paciente
- i. Indicar dopamina EV
- j. Administrar beta2 inhalatorios 2

Pregunta 15

Juana de **8 años**, sin antecedentes de relevancia, concurre para control de salud. Su mamá está preocupada por “su desarrollo”.

Al examen físico **presenta botón mamario unilateral derecho, vello pubiano Tanner 1**, peso y talla acordes a edad (Pc 25). El resto del examen físico sin particularidades.

¿Cuáles de las siguientes son las conductas más apropiadas? Marcar hasta 3 opciones.

Seleccione una o más de una:

- a. Solicitar laboratorio con LH, FSH y estradiol.
- b. Solicitar radiografía de mano y muñeca izquierda con foco en tercer metacarpiano.**
- c. Solicitar RMN de silla turca.
- d. Tranquilizar a la mamá y explicarle la normalidad de los hallazgos para la edad.**
- e. Sugerir excluir el pollo y la soja de la dieta.
- f. Citar control en 4 a 6 meses para evaluar el crecimiento y progresión de la pubertad.**
- g. Solicitar interconsulta con endocrinología.
- h. Anticipar a Juana y su madre los próximos cambios puberales esperables.**
- i. Solicitar ecografía mamaria.
- j. Solicitar interconsulta con ginecología infanto-juvenil.

Pregunta 16

Ingresa al Servicio de Obstetricia, Maria, de 24 años de edad, **en trabajo de parto**.

Antecedentes: FUM 38 semanas. Gesta 2 para 1. Embarazo controlado. Serologías, realizadas en el últimos trimestre del embarazo: lues, toxoplasmosis, HIV y Chagas, **negativas; serología.**

Hepatitis B: **HBs Ag (antígeno de superficie) y H Be Ag (antígeno E), ambos positivos.** Test de detección de **Estreptococo beta hemolítico Grupo B vaginal y rectal negativos.** No presenta otros antecedentes perinatales patológicos. Nace Mateo, presentación cefálica, parto vaginal. **Rotura de membranas de 4 hs.** Es un recién nacido de peso adecuado a su edad gestacional. Vigoroso. **Madre cursando con hep B activa flor _co 10**

¿Cuáles son las conductas más adecuadas para este caso? Marcar hasta 3 opciones.

Seleccione una o más de una:

- a. Solicitar serología para hepatitis B al recién nacido para decidir el momento de vacunación.
- b. Administrar 1 mg de vitamina K intramuscular a las 48 horas de vida. (No, es en el momento)
- c. Indicar la realización de Otoemisiones acústicas como prueba de pesquisa para evaluar el funcionamiento coclear.**
- d. Ubicar al neonato al pecho inmediatamente y comenzar la lactancia durante la primera hora de vida.**

e. Realizar el pasaje de sonda oral y rectal para descartar malformaciones.

f. Solicitar la pesquisa de enfermedades endócrino metabólicas dentro de las 24 horas de vida.(48hs)

g. Indicar colirio con Tobramicina para profilaxis de oftalmía gonocócica y por Chlamydia.

h. Colocar al neonato sobre su madre y realizar la ligadura del cordón umbilical a los 30 segundos de vida. (

i. Indicar vacuna BCG en sala de recepción. (antes de la alta)

j. Indicar la aplicación de la vacuna antihepatitis B dentro de las 12 horas de nacido. (ademas se le administra gamaglobulina hasta 7 de vida)

Pregunta 17

Sabrina de **15 años** de edad concurre a la consulta acompañada por una amiga de la misma edad. **Ella está de novia hace unos meses e inició relaciones sexuales con su novio de 17 años. Usa preservativo como método anticonceptivo y quiere saber cómo cuidarse mejor.**

Concurre a la escuela secundaria, practica hockey. Sus padres están separados y vive con su mamá y su hermana menor.

Antecedentes personales: consumo de alcohol sólo los fines de semana en fiestas, alimentación variada.

Ocasionalmente presenta cefaleas tensionales y padece de asma intermitente leve.

Antecedentes ginecológicos, menarca a los 12 años, duración de ciclos: 30 días, duración del periodo menstrual 5 días, acompañado de dismenorrea leve. FUM hace 15 días.

Antecedentes familiares: madre hipotiroidea, padre colesterol aumentado y abuela materna operada cáncer de mama.

EXAMEN FÍSICO: normal. IMC 20,86. TA 100/60 **90-140/60-95** mmHg. Examen mamario normal. Examen genital: escaso flujo vaginal blanquecino.

Con **respecto a la administración de anticonceptivos orales (ACO) en esta paciente,** ¿qué le indica a Sabrina?
Marcar hasta 3 opciones.

Seleccione una o más de una:

a. Recitar a Sabrina acompañada de un adulto responsable para brindarle asesoramiento sobre ACO.

b. Las cefaleas que padece son contradicción para el uso de ACO.

c. Solicitar hemograma, hepatograma, lipidograma, coagulograma y ecografía ginecológica antes de iniciar ACO.

d. Advertirle que existe riesgo de embarazo en la primera semana de uso, y aumenta con el número de pastillas olvidadas.

e. Anticiparle que los ACO pueden interferir en su crecimiento e provocar acné.

f. Indicarle ACO de progestágenos solos para evitar el desarrollo de hipertensión arterial.

g. Aconsejarle interrumpir por uno o varios meses la toma de ACO a modo de descanso, luego de un año de uso

continuo de los mismos.

h. Indicarle ACO con 30 mcgr de etinilestradiol + gestágeno y refuerza continuar con el uso de preservativo.

i. No considera que Sabrina inicie con ACO como primera opción debido al antecedente de cáncer de mama de su abuela.

j. Advertirle a Sabrina sobre la posible presencia de mastalgia, sangrado intermenstrual leve y ligero incremento de la tensión arterial como efectos colaterales reversibles de los ACO.

Pregunta 18

A la guardia de un hospital de segundo nivel, concurren los padres de Carlos, de **20 días** de vida, **por vómitos, rechazo a la alimentación e ictericia**. No constataron fiebre y las deposiciones son escasas.

Embarazo controlado, con serologías maternas negativas, nació por cesárea con 38 semanas de edad gestacional y 3.440 gramos de peso. Apgar 9/9. Lactancia materna exclusiva. Grupo y factor materno y de Carlos: O +. **Fue dado de alta 72 horas atrás con diagnóstico de sepsis con cultivos negativos y examen de orina completa normal.**

EXAMEN FÍSICO: Peso: 3.550 gramos. Talla 49 cm. Perímetro cefálico 36 cm. Signos vitales: FC 150 por minuto **120-180**, FR 34 por minuto **30-50**, temperatura axilar 36°C, oximetría con aire ambiental 95%. Buen estado general, **ictericia de cara y tronco, normohidratado y dormido en brazos de su madre. Ausencia bilateral de reflejo rojo pupila**. Semiología cardiovascular y respiratoria normales. Abdomen levemente distendido, **hígado de 9cm de altura total a nivel de línea medio** lactante 4,5-5, >=12 7-8 H/6,5M clavicular, sin esplenomegalia. Resto sin particularidades.

Laboratorio: **bilirrubinemia total 14mg/dl, bilirrubinemia directa 10 mg/dl, TGP 48 UI/l, TGO 52 UI/l, fosfatasa alcalina 800 UI/l** 95-368, **gamma glutamil transpeptidasa 250 UI/l** 13-147, glucemia 75 mg/dl, **albuminemia 3,6** 3,2-5,4 **g/dl**. Tasa de protrombina 85%, KPTT 38 segundos.

Cuerpos reductores en orina positivos. Pesquisa metabólica neonatal pendiente. **Sospecha galactosemia**

¿Cuáles son sus conductas iniciales frente a la sospecha diagnóstica? Marcar hasta 3 opciones. *Seleccione una o más de una:*

a. Indicar tratamiento antibiótico parenteral después de obtener urocultivo

b. Indicar alimentación complementaria con fórmula de inicio

c. Indicar dosaje de hormonas tiroideas

d. Solicitar telefónicamente el resultado de la pesquisa neonatal

e. Indicar exposición al sol

f. Indicar alimentación con fórmula láctea a base de soja

g. Solicitar perfil inmunohematológico y haptoglobina

h. Indicar fórmula de inicio libre de lactosa

i. Suspender la lactancia materna

j. Solicitar ecografía de abdomen

Pregunta 19

Usted atiende por primera vez a Santino, un paciente de **18 meses** procedente de **Neuquén**. La familia vivió siempre en esa provincia en un pueblo de la cordillera. El **niño es sano, sólo tuvo fiebre en una oportunidad durante tres días luego de lo cual tuvo un exantema que tardó 72 hs en desaparecer**. En esa oportunidad el médico general le **diagnosticó sarampión con buena evolución**. Se encuentra en percentilos 50 para talla y peso y presenta el siguiente esquema de vacunación:

- BCG a los dos días de vida **ok**
- Hepatitis B el día del nacimiento **ok**
- **Sextuple, antineumocócica trecevalente y antirotavirus a los 2 y 4 meses**
- **Antimeningocócica tetravalente a los 3 y 7 meses.**
- Sextuple a los 7 meses.
- Hepatitis A y antineumocócica trecevalente a los 14 meses.

En relación con la vacunación, ¿cuáles de las siguientes vacunas están indicadas en este niño en este momento?

Marcar hasta 3 opciones. **Vacunacion**

Seleccione una o más de una:

- a. DPT, Hib + Salk
- b. Triple viral (sarampión, paperas y rubéola)**
- c. Sabin
- d. Antimeningocócica tetravalente**
- e. Antineumocócica trecevalente
- f. DPT, Hib
- g. Sextuple
- h. Antorotavirus
- i. Antivaricela**
- j. Doble viral (paperas y rubéola)

Pregunta 20

José, de **6 años y 3 meses** de edad llega a la consulta con su madre. Ella está **preocupada por la altura de José, ya que lo nota más bajo que sus compañeros**.

Antecedentes: nacido a término con peso adecuado para la edad gestacional. Sin antecedentes patológicos de importancia. Vive con su madre, su padre ha fallecido en un accidente y no hay antecedentes patológicos familiares de importancia.

La libreta sanitaria de José muestra una **curva de talla que a partir de los 2 años de vida ha crecido entre los percentiles 10-25 hasta los 5 años**. A partir de esta edad, la curva empieza a descender, ubicándose **actualmente debajo del percentil 3, con un puntaje Z de -3,4 y velocidad de crecimiento menor a percentil 3**.

Con respecto al cuadro clínico del paciente, ¿cuáles de las siguientes conductas son las más adecuadas? Marcar hasta 3 opciones.

Seleccione una o más de una:

- a. Explicar a la madre que se trata de un madurador lento. (no, porque falta datos)
- b. Internar al paciente (no, porque no hay criterios)
- c. Citar ambulatoriamente en 6 meses.
- d. Solicitar interconsulta con endocrinología
- e. Explicar a la madre que se trata de baja talla familiar. (no, porque falta datos)
- f. Explicar a la mamá que su niño tiene un retardo constitucional del crecimiento (no, porque falta datos)
- g. Solicitar resonancia magnética de cerebro con gadolinio
- h. Solicitar radiografía de silla turca
- i. Solicitar laboratorio con panel celíaco y hormonas tiroideas, y radiografía de mano izquierda
- j. Solicitar tomografía computada de silla turca e hipófisis (No, porque primero se solicita radiografía)

Pregunta 21

Marcela de **14 años** concurre a la consulta para obtener su certificado de aptitud física escolar. Como concurre sola no se pudo contar sus antecedentes perinatológicos, ni de su período de primera infancia. Cuenta que siempre fue sana y nunca estuvo internada.

Es buena alumna aunque le aburre ir a la escuela. Participa en el equipo de Vóley del colegio con el que realiza además de actividad escolar, **actividad física de entrenamiento (tres horas semanales) y partidos los fines de semana**.

Tuvo su **menarca hace 10 meses y aún no ha regularizado sus ciclos**. Hizo una **consulta con ginecología** en esa oportunidad. Su **última menstruación fue hace 52 días** y eso la inquieta. No tiene pareja, se identifica como “mujer” y “cree que es heterosexual”. Tuvo relaciones **sexuales dos veces** con un compañero de clase. **Usaron preservativo, aunque dice que una de las veces él se lo puso “antes de acabar”**. Al día siguiente de esa relación realizó un test de embarazo que fue negativo y se tranquilizó “un poco”.

Tiene un peso en PC 50 y una talla en Pc 25-50. Trae carnet de vacunas completo. Tiene una **discreta desviación de la columna que corrige cuando se le pide que se ponga en posición erguida**. El resto del examen físico no presenta alteraciones.

Para este caso, ¿Cuáles son las **conductas iniciales** más adecuada? Marcar hasta 3 opciones *Seleccione una o más de una:*

- a. Solicitar ecografía transvaginal
- b. Citar a la madre lo **antes posible** (no, porque solo cita la madre si confirmacion de embarazo)
- c. Indicar suplemento de Vitamina ACD y hierro
- d. Realizar hemograma, hepatograma, serología para VIH, Hepatitis B y C, VDRL**
- e. Solicitar interconsulta con ginecología infanto-juvenil**
- f. Solicitar dosaje de hormonas tiroideas (no, porque no hay contexto)
- g. Solicitar FSH, LH estradiol, DHEA
- h. Solicitar Rx de columna espinal frente y perfil**
- i. Realizar dosaje de B-HCG**
- j. Solicitar ECG, ecocardiograma y ergometría

Pregunta 22

Joaquín de **2 años** que concurre a la **salita** cercana a su domicilio donde Ud. trabaja junto a su madre, quien refiere que el niño **ha ingerido "algo"** que estaba en el suelo. La madre comenta que Joaquín es un niño muy inquieto.

Joaquín no tiene antecedentes de enfermedades previas, al examen físico, se ausculta buena entrada de aire bilateral y presenta semiología abdominal normal. Ud. decide realizar estas **radiografías y verifica la existencia de un cuerpo extraño radiopaco.**



Luego de la interpretación de la imagen radiológica, ¿cuáles son las conductas iniciales más adecuadas? Marcar hasta 3 opciones.

Seleccione una o más de una:

- a. Indicar dieta blanda
- b. Realizar seguimiento ambulatorio y control radiológico en 24hs
- c. Indicar internación y aguardar la progresión espontánea del cuerpo extraño
- d. Solicitar interconsulta urgente con endoscopia digestiva infantil**
- e. Realizar seguimiento ambulatorio con pediatra de cabecera

f. Deriva de manera urgente a centro de alta complejidad

g. Solicitar fibroendoscopia respiratoria de urgencia

h. Solicitar evaluación por gastroenterología infantil

i. Realizar maniobra de Heimlich

j. Indicar ayuno e hidratación parenteral

Pregunta 23

Consultan en la guardia los padres de Juan de **5 años**, por **lesiones cutáneas de reciente aparición, pruriginosas y que desaparecen después de unos minutos y aparecen nuevamente en otros lugares del cuerpo.**

Es la primera vez que le ocurre. En la cena comió fideos con crema y manzana de postre. Antes había concurrido a la escuela. **Jugó con plastilinas** y realizó clase de educación física.

EXAMEN FÍSICO se observan **lesiones en eritematosas, maculopapulares en tronco extremidades y cara.** No se auscultan sibilancias, ni otros ruidos respiratorios. La TA es de 90/55 (**80-120/50-80**) mm/Hg y la **frecuencia cardíaca de 80** latidos por minutos (**90 - 120**). Temperatura axilar 36,7 grados.

Ante este cuadro, ¿cuáles son las **conductas más apropiadas**? Marcar hasta 3 opciones.

Seleccione una o más de una:

a. Realizar control ambulatorio

b. Indicar corticoides endovenosos

c. Indicar adrenalina intramuscular (No, solo si sospecho de anafilaxia)

d. Contraindicar chocolates, frutillas, naranja y quesos hasta solución del cuadro. (si porque son comida inflatorias y podem generar reaccion alergica)

e. Indicar corticoides por via oral durante 4 dias

f. Explicar que es el comienzo de una enfermedad recurrente que requerirá de estudios.

g. Indicar antihistamínicos por vira oral

h. Internar al paciente para control durante al menos 24 horas

i. Explicar que es una enfermedad en general autolimitada

j. Colocar venoclisis

Pregunta 24

Concurren a un consultorio en el interior de Santa Fe, los padres de Julio, de **20 días de vida**, por **ictericia de piel y escleróticas.** En **dos oportunidades anteriores consultaron por un leve tinte amarillento que fue interpretado como fisiológico.**

Nacido por cesárea con 38 semanas de edad gestacional y 3440 gramos de peso. Apgar 9/9. Grupo y factor materno

y de Julio. A+. Alimentación con fórmula de inicio.

EXAMEN FÍSICO:

- Peso: 3700 gramos. Talla 50 cm. Perímetro cefálico 36 cm.
- Signos vitales: FC 140 lpm (120-180), FR 36 por minuto (30-50), temperatura axilar 36 °C, oximetría con aire ambiental 95%

Buen estado general, **ictericia de cara y tronco**. Se palpa el **borde hepático romo 2 cm** por debajo del reborde costal derecho a nivel de línea medio-clavicular, sin esplenomegalia. Resto sin particularidades.

LABORATORIO: **bilirrubinemia total 15 mg/dl, bilirrubinemia directa 12,3 mg/dl**, TGP 15 UI/l, **TGO 52 UI/l (37)**, **fosfata alcalina 1.995 UI/l (95-368)**, **gamma glutamil transpeptidasa 790 UI/l (13-147)**, glucemia 90 mg/dl, albuminemia 3,9 g/dl (3,5 - 5,4). Tasa de protrombina 92%, KPTT 38 segundos. **Dx ictericia(atresia)**

¿Cuáles son las conductas iniciales más adecuadas? Marcar hasta 3 opciones.

Seleccione una o más de una:

- a. Solicitar ecografía hepática y de vías biliares**
- b. Indicar alimentación con fórmula sin lactosa y proteínas parcialmente hidrolizadas
- c. Solicitar interconsulta con Cirugía Infantil**
- d. Indicar dosaje de hormonas tiroideas
- e. Solicitar telefónicamente el resultado de la pesquisa neonatal
- f. Tranquilizar a los padres e indicar exponer a Julio al sol
- g. Observar las características de las deposiciones**
- h. Citar al control con hepatograma en cuatro semanas
- i. Solicitar radiografía de abdomen frente en posición vertical
- j. Indicar tratamiento antibiótico parental después de obtener urocultivo.

Pregunta 25

La mamá de Mariana, de **16 años**, consulta preocupada porque ve a su hija **muy delgada**. **“dejó de hacer las actividades que solía hacer, no ve a sus amigas, no quiere hablar”**. Mariana dice que le gustaría subir de peso pero **no tiene hambre, se siente triste la mayor parte del tiempo y duerme mucho**.

EXAMEN FÍSICO : se constata **descenso de 6 kg** con respecto al peso del año anterior. **IMC 17**. **Menstruaciones regulares**.

¿Cuáles de las siguientes son las conductas iniciales más apropiadas? Marcar hasta **3** opciones. *Seleccione una o más de una:*

- a. Indicar tratamiento con paroxetina.**

b. Indicar suplemento polivitamínico

c. Indagar sobre ideación suicida

d. Solicitar interconsulta con nutrición.

e. Indicar dieta hipercalórica.

f. Solicitar laboratorio con hemograma, hepatograma, función renal, medio interno.

g. Solicitar ecografía abdominal

h. Solicitar internación en institución monovalente

i. Solicitar interconsulta con salud mental

j. Solicitar resonancia de cerebro.

MAYO 2021

GRILLA OFICIAL ok

Pregunta 1

Matias, de 12 meses de edad, concurre a la consulta con su madre para un control de salud. Se trata de un RNTPAEG sin antecedentes de importancia. La madre le comenta que recién ha comenzado a dar sus primeros pasos solo. Usted decide evaluar el desarrollo de Matias. Para ello, le coloca sobre el escritorio unas pasas de uva, unos cubos de colores, un papel y un lápiz. Que espera que realice Matias? Marcar hasta 3 opciones. (meu resumen san justo MF)

a) Agarrar la pasa de uva con un movimiento de barrido con el lado cubital de la mano (pauta alarma)

b) Agarrar la pasa de uva con toda la mano realizando un movimiento un de rastrillo (pauta alarma)

c) Se toma la pasa de uva y se la lleva a la boca, usted le dirá que NO, y Matias se pondrá serio y lo obedecerá

d) Armar un puente con los cubos (NO, Armar una torre dos y fracasa)

e) Agarrar la pasa de uva con una pinza entre el dedo índice y el pulgar

f) Con el papel y el lápiz, dibujar un garabato

g) Armar una torre de 3 cubos (NO, dos y fracasa)

h) Con el papel y el lápiz, dibujar una figura humana de 3 partes (No, marca papel con lapis)

Pregunta 2

María José, de 3 años, llega a la consulta acompañada por su madre quien se encuentra alarmada por la presencia recurrente de prurito vulvar y fluido que mancha la ropa interior de la pequeña, con rascado muy frecuente del área vulvar y anal. María José recibió tratamiento local en dos oportunidades.

La niña no presenta antecedentes personales de importancia. La madre fue tratada recientemente con óvulos vaginales. La niña concurre al jardín desde este año con buena adaptación y realiza colecho eventual con los padres.

Al examen presenta: enrojecimiento de labios mayores, hiperemia de labios menores e introito, himen íntegro y se

observa fujovaginal blanco-amarillento. Además, se observan lesiones de rascado en el área perianal. De acuerdo a su diagnostico presuntivo, culles son las conductas correctas? Marcar hasta 3 opciones. a) Indicar crema local con Clotrimazol

b) Solicitar Test de Graham (Oxiurius vermicularis)

c) Indicar baños de asiento con Malva Flor_co pag 184

d) Solicitar evaluación por psicología (no, no hay sospecha de abuso sexual)

e) Realizar vaginoscopia (No, flujo amarillento o amarronado y sospecho de cuerpo extraño, placa de pelvis, se hace con anestesia)

f) Recomendar el uso de ropa interior de algodón y dar pautas de higiene (no puede falta)

g) Toma de muestra para Gonococo y Chlamydia

h) Solicitar evaluación por servicio social (no, no hay sospecha de abuso sexual)

Pregunta 3

Concurre a la guardia del hospital con sus padres, Emanuel de **25 días** de edad. Ellos refieren que su hijo comenzó con **vómitos hace 5 días y con cada día que pasa, los vómitos son más abundantes e intensos**. Emanuel se alimenta solo con **leche materna, llora mucho, pareciendo que se queda con hambre**. La madre intenta calmarlo ofreciéndole el pecho nuevamente, tras lo cual reaparecen los vómitos. 48hs antes concurre a un centro de salud próximo a su domicilio **donde le indicaron complementar el pecho con un biberón de 100cc de fórmula** espesada con cereal de **arroz luego de cada mamada**. La mamá comenta que antes del inicio de los **vómitos, las deposiciones de Emanuel eran frecuentes, bastante blandas y amarillentas, pero en estos últimos días son mas escasas y algo más oscuras**.

Antecedentes perinatales: Parto eutócico en cefálica. Apgar 9/10. Peso al nacer 3500 gramos. Talla 51,0cm. Perímetro cefálico 36,0cm. Alta a las 48 horas con peso de 3220 gramos. Control a los 15 días: 3600 gramos.

Examen físico: **Buen estado general, fontanela normotensa, pupilas isocóricas, mucosas rosadas, buen relleno capilar.**

Normohidratado. Temperatura axilar: 37.1°C. Peso 3650 gramos (**aumentó poco el peso**). Buena entrada de aire en ambos campos pulmonares. Frecuencia respiratoria 40 respiraciones por minuto. Dos ruidos cardíacos en los cuatro focos. Silencios libres. Frecuencia cardíaca 140 latidos por minuto. Reflejos y tono muscular de acuerdo a la edad. Abdomen blando, depresible, levemente distendido en hemiabdomen superior. Hígado a 2cm del reborde costal en línea mamilar. Bazo no palpable. Le efectúan a Emanuel exámenes complementarios que indican: Hemograma: Hematocrito 33%. Hemoglobina 11.2g/dl. Globulos blancos: 11.700/mm³. Linfocitos 53%. Neutrófilos 38%. Eosinófilos 4%. Monocitos 5%. Basófilos 0%. **No infeccioso** Frotis: eritrocitos normocíticos y normocrómicos. Eritrosedimentación: 8 mm/h. Estado **Acido-Basico ph 7,63 Alcalosis**. Bicarbonato: 39,5; Ionograma: Na 135mEq/L. **K: 2,8 mEq/L. 3,5-5 Cl: 90mEq/l 96-108**. Coagulograma: concentracion de protrombina 85% . Hepatograma: bilirrubina total: 0.8mg/dl. bilirrubina indirecta: 0.5mg/dl. bilirrubina directa: 0.3mg/dl. TGP: 48UI/L; TGO: 35 UI/L. Orina completa: 1020. Sedimento: escasos cilindros hialinos. También le realizan una ecografía abdominal.

De acuerdo com los datos clínicos y de laboratorio presentados y el informe en curso de la ecografía, que definirá el

diagnostico que Ud. Presume. Cuales son las conductas más apropiadas para la resolución de la afección que presenta Emanuel? Marque hasta 2 opciones. (Sospecha ESTENOSIS HIPERTRÓFICA DE PÍLORO tto sanjusto 3) página 642

a. Enviar a Emanuel a su domicilio y recomendar a los padres que no le ofrezcan biberones cada vez que llore.

b. Mantener los biberones de cereales de arroz después de las mamadas y agregar aceite al 1%.

c. Efectuar cirugía, previa corrección de las alteraciones del medio interno.

d. Internar e indicar prueba tolerancia por vía oral con sales de rehidratación oral por cucharitas.(el paciente esta normohidratado y en vomito es CI de rehidratacion oral)

e. Internar, indicando ayuno, e hidratación parenteral.

f. Continuar con la lactancia y ofrecer sales de rehidratación oral por cucharitas luego de cada vómito.(en vomito es CI de rehidratacion oral)

g. Internar a Emanuel y enviarlo con urgencia a cirugía.

h. Indicar expansión rápida con solución fisiológica a 20 cc/kg. (No, porque el paciente no esta en shock)

Pregunta 4

Concurre al control en salud, Ignacio de 1 mes de edad. La madre le pregunta a Ud. sobre la importancia de la hernia en el ombligo y el aumento de tamaño de la bolsa escrotal. (Flor _co página 75)

Al examinar a Ignacio Ud constata:

-Hernia umbilical con anillo amplio.

-Bolsa escrotal con mayor tamaño del lado derecho, mientras el izquierdo impresiona normal.

-No se observa tumefacción compatible con hernia inguinal.

-La transiluminación de la bolsa escrotal derecha es positiva. (Hidrocele)

Ante estos hallazgos ¿Qué le informa a la mamá de Ignacio? (Marque hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una:

a. Es preferible no corregir quirúrgicamente la hernia umbilical porque es alto el riesgo de recurrencia postoperatoria. (no, porque tiende a cerrar sola en los primeros 2 años de vida)

b. Es necesario realizar una consulta urgente con Cirugía infantil.

c. El hidrocele podría ser un factor condicionante de torsión testicular.

d. El hidrocele se reducirá de modo progresivo durante el transcurso del primer año.

e. Es común que el hidrocele comunicante varíe de tamaño durante el día.

f. Es conveniente efectuar la corrección quirúrgica del hidrocele antes de los dos años de edad.(No. porque suele resolver en forma espontanea en primer año de vida sino se resuelve se indica cx)

g. La hernia umbilical que presenta Ignacio, podría requerir corrección quirúrgica sólo por razones estéticas.

h. Es útil ocluir precozmente la hernia umbilical de Ignacio con moneda y tela adhesiva.

Pregunta 5

Dario, de **1 mes** de edad, concurre con sus padres a una consulta en salud. Su mamá, Monica, está preocupada porque, desde hace **6 días 10, no ha presentado deposiciones 10**. Refiere que **con frecuencia llora y se pone colorado**, antes de **evacuar materia fecal. La última deposición fue a los 24 días de vida. La materia fecal fue de consistencia blanda, grumosa, color amarillo oro.**

Antecedentes de embarazo y parto: primer embarazo, controlado, de término. Parto eutócico en cefálica. Apgar 9/10 **7-10**. **Alimentación exclusiva con leche materna.** Monica refiere que el cordón umbilical cayó al octavo día de vida, y que eliminó meconio a las 24 horas de haber nacido. La prueba de pesquisa neonatal está pendiente. Antecedentes personales: Peso al nacer 3400 gramos. Al alta, 48 horas de vida: 3300 gramos. Control a los 7 días de vida: 3100 gramos.

Dario tiene sueño tranquilo. Solo se despierta para tomar el pecho. Succiona con avidez y parece disfrutar el momento de alimentarse. Pocas veces está algo llorón. Presenta una regurgitación escasa luego de alguna de las tomas. Examen físico: buen estado general. Peso actual 3850 gramos. El abdomen es globuloso, blando y la palpación no desencadena llanto. El hígado se palpa a 2.5cm del reborde costal en la línea axilar media y el polo de bazo se insinúa bajo la parrilla costal izquierda. No se palpan masas fecales.

Cuales son las conductas más adecuadas a seguir con Dario? Marcar hasta 3 opciones. **RN NORMAL CLINICAS**
3250_FLOR_CO 15

- a) Colocar un supositorio de glicerina si Dario no presenta deposiciones en las próximas 24 horas
- b) Comenzar la administración de lactulosa si no constatan dispositivos luego de siete días
- c) Informar a los padres que el ritmo evacuatorio de Dario es normal al estar alimentado exclusivamente con leche materno**
- d) Administrar jugo de compota de ciruelas por medio de un gotero durante 48-72 horas
- e) Efectuar la consulta en un servicio de emergencia si luego de siete días Dario no ha presentado deposiciones
- f) Mantener la alimentación materna a libre demanda**
- g) Informar a los padres que el llanto y el "ponerse colorado" no indica que Dario está constipado**
- h) Complementar la alimentación con fórmula de inicio

Pregunta 6

Facundo de **18 meses** de edad llega a la consulta con sus padres, tras haber presentado en su domicilio, **un episodio de convulsión generalizada de dos minutos de duración con desconexión del medio y recuperación posterior de la conciencia.** Los padres comentan que Facundo **tenía temblores, se agitaba y ponía los ojos en blanco.** Llevaba 12 horas con fiebre **38°C, tos y congestión nasal.**

La gestación y el parto fueron normales. Apgar 9/10 **7-10**, peso al nacer, 3300g, talla 50cm. Test de pesquisa neonatal normal. Desarrollo psicomotor normal.

Se alimentó con leche materna exclusiva hasta los 5 meses. Actualmente, tiene una alimentación variada, sin

inconvenientes.

Inmunizaciones completas según calendario.

Antecedentes familiares. El padre refiere convulsiones en la infancia y epilepsia en un tío paterno. Examen físico: peso 11kg. Talla 82cm. Temperatura **38.2°C**

Regular estado general ojeroso, decaído, mucos oral pastosa, color normal de piel y de mucosas, sin exantemas ni petequias. Buena nutrición y perfusión. ORL: faringe algo congestiva. Otoscopia: ambos tímpanos congestivos. No se visualiza triángulo luminoso.

Examen cardiopulmonar. Abdomen blando. Depresible. No es doloroso. No se palpan masas ni visceromegalias. Examen neurológico: Facundo se encuentra consciente, reactivo. El tono y fuerza musculares, marcha, reflejos osteotendinosos, pares craneales, son normales.

Signos meníngeos negativos.

Los padres se muestran muy angustiados y preguntan si su hijo ha tenido una crisis epiléptica y cuál es su tratamiento.

Con relación al problema de Facundo, Ud, ¿qué conductas considera más apropiada? Marcar hasta 3 opciones.

Convulsiones febriles benignas flor_co 151o San Justo 3 CONVULSION FEBRIL pagina 363

- a) Administrar con urgencia una dosis de ceftriaxona EV**
- b) Internar a Facundo** (No, porque solo interna cuando hay 2 episodios en <24hs, en < 1 año se interna y hace PL.)
- c) Informar a los padres que la aparición de una convulsión, ocurre solo con temperaturas elevadas.**
- d) Controlar a Facundo en forma ambulatoria**
- e) Efectuar lo antes posible un estudio de imágenes cerebrales**
- f) Informar a los padres que la resolución espontánea es la evolución habitual**
- g) Informar a los padres que Facundo ha presentado una crisis epiléptica** (No, es sinónimo de epilepsia, el pcte ha presentado Convulsiones febriles benignas)
- h) Informar a los padres que el desarrollo neurológico e intelectual de Facundo será normal**

Pregunta 7

Florencia, de 12 años y 3 meses, concurre a la consulta con sus padres quienes se encuentran muy preocupados porque su **hija parece muy baja en comparación con otras amigas de su misma edad** y aún **no ha tenido su menarca**. Revisando los controles en salud efectuados hasta ahora. Florencia ha mantenido siempre el crecimiento de su **talla en pc 3**.

Antecedentes personales. La madre de Florencia cursó embarazo gemelar de 38 semanas. Nacimiento de Florencia por cesárea. Peso al nacer 2150 gramos.

Los padres refieren que su hija cursa el último grado de la escuela primaria y es una excelente alumna. Examen físico: peso **22.6kg (Pc<3) PZ-2.7**. Mamas. Estadio I; **Vello pubiano: II-III**. Talla materna: 159cm (Pc-50-25). **Talla paterna: 176cm (Pc75-50)**

Con los datos disponibles, ¿cuáles son los más adecuados para comenzar la valoración de Florencia? Marcar hasta 3 opciones. **Baja talla/madurador lento/ Clínicas página 222**

- a) Radiografía de muñeca con foco en 3er metacarpiano**
- b) Centellogramas de tiroides con I131
- c) Interconsulta con endocrinología
- d) Función renal TSH, T4L**
- e) Determinación de los niveles de las hormonas de crecimiento
- f) Radiografía de silla turca
- g) Determinación de IgA antitransglutaminasa**
- h) Cariotipo

Pregunta 8

Gastón de 4 años y 10 meses concurre a la consulta con sus padres porque no habla bien. Según refieren el **aún no arma oraciones y parece, a veces, no entender lo que se dice.**

Antecedentes personales: Gastón fue producto de un embarazo término, controlado que cursó sin complicaciones. Parto eutócico. Peso de nacimiento 3440 gramos. No se presentaron complicaciones perinatales. Desde el punto de vida madurativo, presenta un desarrollo motor grueso adecuado: **sosten cefálico a los 3 meses, sedestación a los 6 meses, gateo a los 9 y marcha independiente al año y un mes.** A los **dos años utilizaba correctamente la cuchara y el tenedor.** Dijo sus **primeras palabras alrededor de los 2 años y cerca de los 3 algunas frases rudimentarias** como “dame eso”, “guaguau no está”. Sus padres perciben que, si bien habla más que el año anterior, aun no habla con la claridad de los niños de su edad.

Gastón es un chico hiperactivo y no suele hacer caso cuando se le solicita algo. Hace muchos **berrinches sobre todo cuando se lo contradice.**

Concurre a jardín desde salita de 3 años desde entonces las maestras alertaron acerca de su escaso lenguaje. Actualmente, concurre a sala de 4 en el mismo establecimiento y las maestras comentan **que le cuesta adaptarse al grupo y que presenta una actitud solitaria.**

Arma varios rompecabezas, junto a su prima de 9 años. Reconoce la mayoría de las letras y números.

No presenta antecedentes familiares ni patológicos de importancia.

Examen físico: **fue dificultoso debido a su constante movimiento y falta de colaboración.** Dentro de límites normales para su sexo y edad. Buen estado general, examen neurológico normal.

Ante esta situación, ¿cuáles son las conductas más adecuadas para abordar el motivo de consulta? Marcar hasta 3 opciones

(fuente: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92272012000300010)

- a) involucrar estrecha y obligadamente a los padres en el tratamiento**
- b) suspender transitoriamente la concurrencia de Gastón al jardín
- c) indicar **lo antes posible** una evaluación con psiquiatra infantil

d) **considerar** que Gaston presente un trastorno generalizado e inespecífico del desarrollo

e) informar a los padres que Gaston presenta un retardo habitual en la maduración del lenguaje

f) informar a los padres que Gaston presenta signos inequívocos de autismo

g) **realizar una evaluación audiológica**

h) solicitar una consulta inicial con genética

Pregunta 9

Marianela, de 11 años de edad, concurre con sus padres al hospital más cercano a su domicilio. Ingresó con cuadro clínico de **48 horas evolución caracterizado por lesiones maculopapulares en ambos miembros inferiores acompañado de dolor abdominal difuso.**

Antecedentes: presentó un episodio de **faringoamigdalitis**, dos semanas antes, y fue medicada en dicha oportunidad con amoxicilina e ibuprofeno con evolución favorable.

Examen físico: se evidencian **lesiones maculopapulares palpables sobreelevadas en miembros superiores y ambos miembros inferiores extendiéndose a región glútea y petequias. Discreto edema levemente doloroso en ambos tobillos y ambas rodillas, sin evidencia de flogosis.** Abdomen blando, depresible con peristaltismo conservado, no doloroso a la palpación profunda.

Durante la evolución clínica, se le efectuaron los siguientes estudios: Leucocitos de 9200/mm³, neutrófilos segmentados 53%, linfocitos 47%, hemoglobina 13,6g/dl, hematocrito 40%, plaquetas 171000/mm³, concentración de protombina de 80%.

Marcar hasta 3 opciones: **Glomerulonefritis: principalmente es postestreptococcica** flor_cor página 94 San Justo 3
470xVasculitis porPurpura de schonlein henoch flor_cor105

a) Debe efectuar controles oftalmológicos a cada 3 meses

b) Es muy importante el control periódico de la función renal

c) Podría requerir un esplenectomía a largo plazo

d) Marianela podría presentar episodios de melena o hematuria

e) Es probable que las manifestaciones articulares produzcan rigidez articular prolongada(No, deja secuelas)

f) Puede volver a tener otros episodios similares a los actuales

g) Existe un riesgo importante de hemorragia del sistema nervioso central

h) Marianela no debe recibir corticoides mientras persistan las lesiones cutáneas (Considerar GC casos graves y derivar especialista)

Pregunta 10

Se presenta en la guardia **Fausto, de 12 años de edad**, sin antecedentes patológicos de importancia, **refiriendo dolor de 1 hora de evolución en la región escrotal derecha.**

En la exploración física se observa **tumefacción dolorosa del escroto y testículo derecho, con reflejo cremastérico**

negativo. El examen físico es **muy difícil debido al dolor referido** por el paciente. Dado el cuadro clínico de Fausto, ¿qué conductas decide adoptar? Marcar hasta 2 opciones.

Torsión Testicular Urgencia Urológica- Escroto agudo **pagina flor_co pag 76 pagina San justo 3 _pagina57**

- a) Solicitar centellograma testicular (porque se ecografía Doppler testicular)
- b) Solicitar ecografía Doppler testicular diferida (o fecha posterior, NO, porque es Urgencia Urológica)
- c) Realizar ecografía testicular con Doppler vascular urgente**
- d) Indicar reposo y analgésicos por vía oral
- e) Solicitar orina completa y tratamiento con cefalexina
- f) Interconsulta inmediata a cirugía pediátrica**
- g) Observación en guardia durante 6 horas
- h) Control ambulatorio en 24 horas

Pregunta 11

Julián, de 19 meses de edad, concurre con su madre y su abuela materna a su consultorio. Están preocupadas por su maduración. Nació de un embarazo controlado, a las 39 semanas de edad gestacional por parto por vía vaginal con presentación cefálica. **Tuvo sufrimiento fetal agudo por circular de cordón y fue deprimido grave, y recibió reanimación en la sala de partos. Estuvo internado tres semanas en unidad de cuidados intensivos neonatales, con buena evolución. También fue internado por bronquiolitis por 5 días a los 6 meses.** Inmunizaciones completas para la edad. Antropométricamente . peso pc 25, talla pc 25-50, perímetro cefálico pc 50. Examen físico sin particularidades.

En este caso, la ausencia de pautas madurativas son **signos de alarma?** Marcar hasta 3 opciones:

- a) Usar triciclo (No, porque lo hace con 3a)
- b) Saltarse en un pie (No, porque lo hace con 4 a)
- c) Pararse en un pie (No, porque lo hace con 2 a)
- d) Lanzar una pelota con ambas manos (No, porque lo hace con 2 a)
- e) Hacer talón con punta hacia adelante (No, porque lo hace con 5a)
- f) Dar cinco pasos sin agarrarse**
- g) Patear una pelota (debería hacer con 15 m)**
- h) Agacharse y levantarse sin caerse**

Pregunta 12

Usted es pediatra de guardia de un hospital general del conurbano bonaerense. Consultan Laura y Martín con su hijo **Bautista de 4 meses y medio** de vida. Motivo de consulta: **fiebre de 39°, vómitos, rechazo del alimento y somnolencia de 24 horas de evolución.**

Bautista es el primer hijo de la pareja, sin antecedentes personales ni familiares a destacar. Se alimenta con **lactancia materna y complemento con fórmula de inicio**.

Vacunas: BCG, Heatitis B, 2 dosis de vacuna conjugada 13 valente para neumococo, 2 dosis pentavalente, 2 dosis de polio (IPV) y 2 dosis de rotavirus, 1 dosis de meningococo ACYW135.

Examen físico: temperatura axilar **40°**, en mal estado general, **depresión del sensorio marcada, relleno capilar 5 segundos**, frecuencia cardíaca 150 por minuto, tensión arterial 60/30 mmHg . Examen neurológico: **hiporreflexia osteotendinosa, letargo, estrabismo derecho, anisocoria y fontanela anterior bombé**. Durante la evaluación presenta una **convulsión tonico-clonica generalizada que cede con medicación y aparecen lesiones máculas rojizas que no desaparecen a la vitropresión**.

Flor_co pagina página 86 Shock hipovolemico(clase deshidratacion) Meningococemia dfx con meningitis bacteriana, PTI(clase purpura)

Ante esta situación, cuáles son las conductas iniciales más adecuadas? Marcar hasta 3 opciones.

- a) Solicitar en este momento, TAC de cerebro
- b) Solicitar inmediatamente dos hemocultivos, y hemograma, coagulograma, glucemia interno y PCR
- c) Indicar impregnación con difenilhidantoína
- d) Solicitar derivación urgente a un hospital especializado en atención pediátrica
- e) Colocar oxígeno**
- f) Dexametasona EV y antibióticos EV**
- g) Realizar en este momento punción lumbar para diagnóstico y tratamiento
- h) Realizar expansión con solución fisiológica**

Pregunta 13 —

Nicolás **tiene 42 días** de vida. Concorre con sus padres a la consulta debido a que presenta un **cuadro febril de 24 horas de evolución**. Ellos se encuentran muy preocupados y refieren que Nicolás se alimenta con **lactancia materna exclusiva cada 3hrs, viven a 3 cuadras del hospital**. Usted realiza la anamnesis completa y el examen físico de Nicolás. No presenta antecedentes del embarazo ni perinatológicos de importancia. Nació de término, con un peso de 3200gs. Regurgita ocasionalmente.

Al momento del examen físico, Nicolás presenta **38.6°C**, no presentando otros datos positivos ni foco infeccioso evidente. Se le realiza por guardia un laboratorio inicial con los siguientes resultados.

Globulos blancos **21.000/mm3**, **NS 70%** (**hasta 45 es normal**), L 30%, **Hb 9.5gr/dl**, plaquetas **240000/mm3**. **Proteína C reactiva 50 mg/l**

Sedimento urinario normal Hemocultivos e urocultivos : pendiente resultados

De acuerdo a su interpretación diagnóstica, cuales de las siguientes son las conductas inmediatas más adecuadas. Marcar hasta 3 opciones **Lactante febril sin foco clinica pagina 931**

- A) Indica cefalexina via oral hasta recibir la lectura del urocultivo**

B) Realizar punción lumbar y medicar empíricamente con antibióticos por vía endovenosa

C) Indicar antitérmicos y antibiótico por vía oral

D) Solicitar RX de tórax

E) Internar a Nicolás

F) **Posponer punción lumbar** de no mediar signos neurológicos y medicar urgente con antibióticos por vía endovenosa

G) Dar pautas de alarma y enviar al domicilio regresando a control en 24 horas (No, porque hay criterios de internación)

H) Mediar por **vía intramuscular** con antibióticos y control en 24hrs

Pregunta 14

Damián, de **1 año 10 meses** de edad, llega a la consulta con su madre por presentar **fiebre de 39°** en las últimas 24 horas. Refiere que comenzó con **decaimiento e irritabilidad en las últimas 48 horas** a lo que se agregó **rechazo parcial del alimento, abundante babeo y aliento fétido**. Sano hasta la enfermedad actual, concurre al jardín maternal por la mañana. Presenta inmunizaciones para la edad.

Al examen se parecía un niño con regular estado general, **febril a 39.3°, decaído algo pálido con adenopatías submaxilares bilaterales de 1.5cm y dolorosas a la palpación. Babeo intenso**. En la boca se observan encías **tumefactas, eritematosas y algo sangrantes, lengua blanquecina, y varias vesículas en paladar blando y duro con lesiones y ulcerativas en lengua, surco gingival y mucosas. Las amígdalas tapizadas con exudado blanquecino y algunas lesiones ulcerativas**. La otoscopia bilateral es normal y el resto del examen físico sin particularidades.

En relación con el cuadro clínico, ¿cuáles considera las conductas más adecuadas para transmitir a la madre? Marcar hasta 3 opciones: **FARINGOAMIGDALITIS en menores de 2 A tto sintomático** Flor_co página 122

a) Indicar paracetamol 2 gotas por kg de peso hasta 4 veces por día

b) Indicar amoxicilina/ácido clavulánico 50mg/kg/día (No, porque es más F viral en menores de 2A)

c) Administrar líquidos por boca fraccionados

d) Indicar tropicaciones locales con gel de lidocaína al 1% (NO es conducta)

e) Indicar aciclovir oral si la fiebre dura más de 5 días (NO, si es viral por lo general se autolimita).

f) Solicitar test rápido de fécenes y cultivo (NO, porque es más F que sea viral)

g) Internación del paciente para control estrecho y tratamiento

h) Indicar dieta blanda y fría

Pregunta 15

Milo de **3 años y 4 meses** de edad concurre para realizar su control de salud para ingreso a jardín de infantes. No usa pañales durante el día pero por la noche moja la cama por lo que persiste con pañales para dormir. En la familia comen mirando televisión y la madre le da de comer en la boca porque de otro modo come poco.

Usa **chupeta para dormir a la noche**. Usa el vaso para tomar líquidos. Duerme en la habitación con su hermana de **once años y ven televisión hasta que se duerme**.

Cuales son las **recomendaciones de puericultura** más adecuado? Marcar hasta 3 opciones

a) indicar sacar los pañales a la noche

b) evitar que vea TV mientras come y sacar el televisor de la habitación

c) indicar sistema de alarma nocturna

d) limitar el uso de televisor **en la habitación** a dos horas por día

e) permitir el uso del chupete para favorecer el sueño

f) sugerir suspender el uso de chupete (no usar antes de los 15 días de vida, después se recomienda hasta 1 año medio)

g) permitir que coma solo (el ideal)

h) sugerir que el niño coma antes que el resto de la familia (el ideal que coma con la familia)

Pregunta 16

Concurre a su consultorio Victoria con su hija **Chiara de 5 meses** para realizar el control de salud mensual. Ud observa al evaluar su desarrollo psicomotor los siguientes datos: realiza **trípode inestable, rola, pasa objetos de una mano a otra y los lleva a la boca, vocaliza y modula reciprocamente, sonríe y se ríe a carcajadas, y sigue con la mirada. No se sienta sola, no hace saltarín, no usa pinza radial inferior y no usa consonantes. No emite sílabas (balbuceo)**

Chiara nació de parto vaginal y requirió maniobras de reanimación mínimas, sin otros datos perinatales de relevancia. Pesquisa metabólica neonatal, otoemisiones acústicas y reflejo rojo normales. Presenta reflejo plantar. Es alimentada con pecho exclusivo con **buen progreso ponderal estatural. Efectúa los controles periódicos pautados por Ud. Con buena adherencia a las pautas de puericultura**. Victoria le pregunta **se ya puede comenzar a brindar semisólidos a Chiara. (Introducción alimentaria -Página 52 flor_co) desarrollo flo_co 40 y san justo 284**

De acuerdo a la evaluación realizada indique las conductas más adecuadas. Marque hasta 3 opciones:

A) Informar a la madre que en el próximo mes comenzará con alimentos semisólidos

B) Solicitar tomografía cerebral

C) Indicar estimulación temprana y control en un mes

D) Retrasar la incorporación de semisólidos por su retraso psicomotriz

E) Continuar con los controles pediátricos habituales

F) aconsejar a la madre sobre prevención de caídas

G) Solicitar interconsulta con neurología infantil

H) Solicitar interconsulta con un especialista de desarrollo infantil

Pregunta 17

Ramiro, de **5 meses** de edad, concurre a la guardia con sus padres por presentar **fiebre 38.5°C de 12 horas** de evolución. Su madre refiere que **pasó la noche llorando y que no pudo descansar bien**. Además lo observa decaído y con **rechazo parcial del alimento. Relata que hace una semana presentó tos y rinorrea acuosa**.

Al examen físico se lo **observa decaído, con fontanela normotensa, fauces levemente congestivas, adenopatías pequeñas cervicales y retroauriculares**. A la otoscopia **presenta abombamiento de la membrana timpánica y eritema de la misma en oído derecho confirmándose con la otoscopia neumática reducción de la movilidad de la membrana timpánica**. El oído izquierdo presenta **congestión peritimpánica**. El resto del examen físico es normal. No presenta signos meníngeos.

Antecedentes: niño previamente sano, sin antecedentes perinatólogicos ni patológicos de relevancia, alimentado con leche de fórmula, no usa chupete. Concorre a jardín maternal a 6 horas diarias. Su familia consta de 3 hermanos sanos, **madre e padre, ambos fumadores**. Vacunas completas. Marcar hasta 3 opciones: **DX: OMA** **flor_co 119**

a) Evitar la exposición del niño al humo del cigarrillo

b) Indicar amoxicilina a 80-90mg/kg/día por 10 días, con control a las 24 horas-48 horas

c) Indicar clatritromicina por 7 días

d) Indicar solamente analgésicos y evaluar la evolución

e) Indicar miringotomía y cultivo de oído medio

f) Indicar gotas óticas con ciprofloxacina/hidroocortisona

g) Tratamiento parenteral con ceftriaxona

h) Indicar analgesia con paracetamol a 10mg/kg dosis las primeras 24 horas

Pregunta 18

Lorena asiste al consultorio con su hijo **Lautaro, de 5 meses** de edad, quien no presente antecedentes de relevancia. Es el quinto hijo de la familia. Viven en Flores.

Laura refiere que notó a Lautaro **más decaído durante los últimos días**. Lo alimenta con pecho materno exclusivo a libre demanda y comenta que, **desde hace 72 horas, presenta mala actitud alimentaria con diuresis conservada y catarsis negativa**.

Antecedentes personales: nacido de término (39 semanas) peso de nacimiento 3165 gr. Alta conjunta a las 48 horas con un peso de 2.985g (**descenso de 5.7%**), pesquisa metabólica neonatal normal.

Presentó **falta de seguimiento clínico presencial** desde los 3 meses de vida, debido a la pandemia por Covid-19. Último registro de peso a los 3 meses: 4.900gr (Pc 50).

Se constata en el examen físico: **paciente adelgazado con mal progreso de peso, peso actual de 5.100gr (Pc 3.)**. se observa a **Lautaro aletargado con regular estado general, mucosas semi húmedas**.

Se lo deriva a la guardia para solicitar estudios y se informan los siguientes resultados.

Hto 35%, Hb, 11.1gr/dl, **G blancos 18000/mm³**, neutrófilos 60%, linfocitos 25%, eosinófilos 3%, basófilos 1%, monocitos 6%, **plaquetas 420.000/mm³** **200-400**, **proteína C reactiva ultrasensible 35mg/l**. Orina completa turbia, densidad 1015, pH7, **sedimento con abundantes leucocitos (30-40)**, **hematíes 3-5**, **nitritos positivos con campo cubierto de piocitos**. Hepatograma y función renal normal. Hemocultivo y urocultivo pendientes.

De acuerdo a su hipótesis diagnóstica, cuáles son las conductas más adecuadas en el abordaje de este paciente?

ITU flor_Co pagina 71/ San Just completo 3 402

Marcar hasta 2 opciones.

- a) Indicar antibiotico via oral, realizar manejo ambulatorio y controlar en 48 horas (NO, hay que internar)
- b) Dar pautas nutricionales y citar al paciente con los resultados **pendientes en 1 semana** (NO, porque hay que internar)
- c) Si presenta urocultivo patológico solicitar ecografia y cistouretrografia miccional**
- d) Si presenta urocultivo patológico realizar ecografia renal y de vias urinarias **sin indicar** otros estudios complementarios (NO, hay que solicitar centellograma).
- e) Realizar centellograma renal una vez completado el tratamiento
- f) Internar y tomar conducta antibiotica expectante hasta el resultado del urocultivo (NO, hay que empezar el tto empírico)
- g) Internar e indicar tratamiento antibiotico parenteral**
- h) Realizar interconsulta con nefrologia y nutrición (NO, no es conducta)

Pregunta 19

Aytor, de **9 meses** de vida, concurre a la consulta con su mamá y papá, porque lo observan, **desde hace dos horas, muy decaído y con mucho sueño**.

Refieren que durante las últimas **48 horas** **presentó deposiciones líquidas que sobrepasaron el pañal**. Al examen físico se observan: **ojeras marcadas, somnoliento, polipneico. Presenta pliegue cutáneo persistente, mucosas secas, relleno capilar de 5 segundos y extremidades frías**. **Shock hipovolemico** flor_co 86

Ante este cuadro clínico, cuáles son sus **conducta iniciales**? Marcar hasta 2 opciones.

- a) Rehidratación mediante sonda nasogástrica
- b) Prueba tolerancia oral y rehidratación en guardia
- c) Indicar expansión con solución fisiológica**
- d) Indicar radiografia de tórax
- e) Internación, realizar hemocultivos y coprocultivo
- f) Prueba de tolerancia oral y continuar con dieta en su casa con **control ambulatorio** en 24hrs
- g) Administrar loperamida** Nunca se da antidiarreico
- h) Colocar oxigeno por mascara.**

Pregunta 20

Mariana de 25 años acude a su centro de salud a un control postparto a los **6 días del nacimiento de Sofia**, una RNTPAEG (3.350 gr, Apgar 9/10 **7-10**) que recibe lactancia materna exclusiva. La madre **presenta grietas en ambos pezones**. Al no acudir con Sofia, no se puede valorar la técnica alimentaria. Se recomienda para conseguir la cura de las grietas, dejar los pezones al aire libre el de lactancia para conseguir variar los puntos de presión y disminuir el dolor. Se cita en cuatro días para ver su evolución y se recomienda acudir con la recién nacida para valorar la toma.

A los 9 días Mariana sigue presentando grietas en el pezón izquierdo, que no han mejorado a pesar de llevar a cabo las recomendaciones. Refiere un **dolor muy intenso como "pinchazos"** que le hace **difícil amamentamiento** del pecho izquierdo, el cual la **niña hace un día que lo rechaza e no quiere mamar del mismo**. A la palpación, **le aprecia una pequeña induración en el cuadrante superior externo de la mama, con dolor, calor y rubor**. **Fue medicada por su obstetra con Cefalexina via oral**. La grieta del pezón derecho está cicatrizando y ya no le duele al mamar. Se valora la toma: se observa un buen agarre y una succión en el pecho que la lactante acepta. **PROBLEMAS FRECUENTES DE**

LA LM flor_co página 49

En esta situación usted, que le aconseja? Marcar hasta 3 opciones.

- a) Indicar tratamiento topico con mupirocina sobre la mama afectada cada 12 horas por 7 días
- b) Aconsejar amamentar a libre demanda, ofreciendo también el pecho afectado**
- c) Rotar tratamiento de la madre a amoxicilina a dosis habituales por 5 a 7 días, según evolución
- d) Suspender la lactancia del lado afectado, de manera transitoria (No, es CI)
- e) Intercalar lactancia materna con formula de inicio (No, lactancia materna exclusiva)
- f) Vaciar eficazmente el pecho que rechaza la lactancia durante 20 min a cada 3 horas** (si, porque previene las grietas)
- g) Suspender antibioticos maternos, por el pasaje a traves de la leche
- h) Indicar Paracetamol o Ibuprofeno cada 6 u 8 horas a la mama**

Pregunta 21

Anahí es una **niña de 6 meses** de vida, primera hija de Sandra (32 años, docente) y Julio (32 años, docente). Fue una RNTPAEG y no presentó hasta el momento ningún problema de salud. Tiene aplicadas vacunas completas para la edad. La familia vive en el conurbano bonaerense y los padres trabajan en una escuela en el partido en el que viven. Anahí queda al cuidado de su abuela materna durante el tiempo que ellos están trabajando. Anahí sigue tomando el **pecho y también toma biberones con fórmula de inicio**.

Al examen físico anahi se sienta, **toma objetos y los lleva a la boca, y no se observa reflejo de extrusión lingual**. Peso: 7kg (pc 25) y talla 64cm (pc 25) En la consulta los padres preguntan acerca de comenzar con la alimentación con semisólidos. Ante esta consulta usted, qué considera informarles? Marcar hasta 3 opciones. **Introduccion**

alimentar -Página 52 flor_co 50

- a) Indica que comiecen con sucedaneos lácteos inicialmente
- b) Se debería aguardar a que alcanzara un peso y una talla en percentilo 50 para comenzar con semisólidos (NO, se puede empezar con pc 25)
- c) **Alimenta la ingesta de agua y desalienta la de jugos industriales y gaseosas**
- d) Aclara que pueden añadir sal, azúcar y/o miel a las comidas (NO, se indica miel por riesgo de botulismo)
- e) Indica que comiecen con vegetales inicialmente y más tarde incorporar otros grupos de alimentos (carnes, cereales y frutas) (Comida variada)
- f) **Estimula el agregado de grasas a las comidas que se le ofrezcan**
- g) **Es un buen momento para comenzar con semisólidos**
- h) Indica alimentos variados, pero limitando carnes y algunas frutas (No, no se limita solo a carnes y algunas verduras)

Pregunta 22

Florencia, es una niña de 6 años de edad que concurre a un control de salud. No tiene antecedentes de importancia. Usted encuentra que según la curva de crecimiento su talla se encuentra en percentilo 75 y creció 2.5cm en este último año, y durante este mismo periodo, su peso se mantuvo en percentilo 50.

Cómo interpreta estos resultados? Marcar hasta 2 opciones **Crecimiento y desarrollo** flor-co pagina 36

- a) Presenta una estatura normal para la edad con una velocidad de crecimiento normal. (No, porque el crecimiento está anormal)
- b) Presenta peso en percentilo 50, esto refleja el promedio de su peso en los últimos meses. (NO, porque no refleja su peso)
- c) Presenta una estatura normal para edad con una velocidad de crecimiento anormalmente alta para su edad. (NO, porque la velocidad de crecimiento está baja).
- d) Presenta una estatura anormal con una velocidad de crecimiento anormalmente alta. (NO, porque la estatura está normal)
- e) Presenta un peso en el límite inferior a lo normal.
- f) **Presenta una estatura normal para la edad con una velocidad de crecimiento anormalmente baja.**
- g) **Presenta peso normal para la edad.**
- h) Presenta una estatura anormal para la edad con una velocidad de crecimiento anormalmente.

Pregunta 23

Consulta por guardia Natalia quien trae a su hija Olivia de 4 años por presentar fiebre (38°C) de 24 hora de evolución y dolor que refiere en codo y hombro izquierdo desde hace aproximadamente una semana y cede con ibuprofeno a 10mg/kg/dosis.

Sin antecedentes de importancia. Vacunas completas para la edad según calendario oficial. Concurre a jardín de

infantes sala de 4 sin ninguna dificultad.

Examen físico: **Buen estado general, febril (38.3°C), normohidratada, palidez de mucosas**, frecuencia cardiaca 125 lpm, frecuencia respiratoria 20 irpm, Saturación O2 97%. Diureses conservada.

Auscultación cardiaca: 2 ruidos en 4 focos, silencios libres, pulsos periféricos presente y conservados. Semiología cardiopulmonar y normal. Abdomen: blando depresivo indoloro, ruidos hidroareos positivos. **Altura hepática 8cm, bazo palpable por debajo del reborde costal**. Presenta en ambos miembros inferiores varias **lesiones equimóticas y dolor en la articulación del codo y hombro izquierdo**, sin signos de flogosis.

Teniendo en cuenta la anamnesis y el examen físico. Cuáles son las hipótesis diagnósticas más adecuadas? Marcar hasta 3 opciones:

Seleccione una o más de una: **(SÍNDROMES PURPÚRICOS flor-co 103)**

a) Hemofilia

b) Fiebre reumática (No, no hay antecedentes de VA)

c) Trombocitopenia inmune

d) Hepatitis autoinmune (No, mal estado general, fatiga cambios de conducta, ictericia o signos de hepatopatía crónica según google)

e) Osteomielitis (No, san justo página 3 448)

f) Mononucleosis aguda

g) Leucemia linfocítica aguda

h) Lupus eritematoso sistémico

Pregunta 24

Agustín, **de 1 año** de edad, consulta para el control de salud.

Usted ha realizado los controles previos, desde el nacimiento. Agustín es un niño **nacido a término**, con peso adecuado para la edad gestacional, sin complicaciones perinatales. Es hijo de Vanina de 23 años y Alejandro, de 28, ambos sanos. El niño ha tenido un crecimiento adecuado, neurodesarrollo acorde a edad. Recibió lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, y actualmente, tiene una dieta variada. **Recibe suplemento de hierro y vitaminas desde los 2 meses de vida**. Su carnet de vacunas se encuentra completo según calendario. **PROFILAXIS CON HIERRO flor-co53**

Cuales son las indicaciones más adecuadas en esta consulta? Marcar hasta 3 opciones

A) Suspender la profilaxis con hierro y vitaminas A,C, D

B) Indicar ubicar al niño en el auto en el asiento trasero **en brazos de la madre** (NO, En los vehículos el recién nacido debe viajar en el asiento trasero, preferentemente con una silla adecuada a su tamaño y mirando hacia la luneta trasera.)

C) aconsejar la higiene dental del niño con cepillo y **pasta dental abundante**

D) aconsejar sobre prevención de accidentes en el jugar y cuidado bucal

E) Indicar compartir la comida familiar

F) aconsejar entretenimiento con dibujos animados o videos, en dispositivos móviles o a través de pantallas, con un máximo de una hora diaria (No, pantalla no está indicado a menores de 2 años)

G) aconsejar el juego con pares (a los 2 años)

H) Indicar el destete (No, se recomienda hasta lactancia materna hasta 2 años)

Pregunta 25

Ciro de 8 años concurre al hospital por decaimiento, **fiebre de 39°C y dolor abdominal en hemiabdomen derecho**. No posee antecedentes personales de importancia y su familia es sana.

Comenzó hace 24 horas con **tos seca y anorexia**.

Al examinarlo se constata **taquipnea**, tos y a la auscultación pulmonar **murmullo vesicular disminuido en base derecha, algunos rales crepitantes sin otros ruidos agregados**. A la palpación refiere dolor en hemiabdomen derecho, sin signos peritoneales, puñopercusión negativa. Ruidos hidroaéreos conversados. Saturometría 98% con aire ambiental. Rx de tórax: muestra imagen redondeada radiopaca con patrón alveolar en campo inferior derecho.

¿Cuáles son las conductas más adecuadas que ud, adopta? Marcar hasta 3 opciones **Dx Neumonía, flo_co 135**

Seleccione una o más de una

a) Indicar ceftriaxona parenteral (No, el tto es vo)

b) Solicitar hemocultivos, hemograma y PCR

c) Solicitar radiografía de control en 30 días

d) Indicar penicilina VO

e) Citar en 24 o 48hrs con pautas de alarma

f) Solicitar ecografía pleural (No, tiene signos de derrame pleural)

g) Internar al paciente (NO, el tto es ambulatorio)

h) Solicitar TAC de tórax (NO, porque ya tenemos una radiografía)

JUNIO 2021

GRILLA OFICIAL ok

Pregunta 1

Lucía es una niña de 8 años de edad que concurre a la consulta. No presenta antecedentes de importancia. Su peso de nacimiento fue de 3.500 g. Con talla de nacimiento de 52,0 cm. No tenemos datos antropométricos de sus controles. Se alimenta con dieta variada. Tiene un desarrollo normal. Cursa tercer grado en modalidad presencial y virtual con buen rendimiento.

Como **antecedentes familiares**: su mamá es sana, profesional, mide 162,0 cm (pc 50-75) y tuvo su menarca a los 11 años. Su papá es sano, comerciante, mide 175,0 cm (pc 50-75). **Blanco genético familiar=162,25 (pc 50-75), rango genético= entre 153,75 (pc 10) y 170,75cm (pc 90 – 97).**

Al **examen físico constata una niña** en buen estado general, frecuencia respiratoria 20 por minuto, frecuencia cardíaca 80 por minuto, 2 ruidos en 4 focos, silencios libres. Abdomen blando. No visceromegalias. Reactiva, vital. Buen estado nutricional. **Se observa nódulo mamario bilateral. No se observa vello pubiano.** Talla 134,0 (pc 97). Ante este examen físico y esta curva ¿Cuáles son las opciones más adecuadas? (Marque hasta 3 opciones) Seleccione una o más de una:

a. El estadio de maduración puberal de Lucía corresponde al desarrollo de mama estadio de Tanner 3.(No, tanner 2)

b. Lucía se encuentra en un estadio **prepuberal**.

c. Lucía se encuentra fuera del rango genético familiar.

d. Asume que se encuentra **dentro de la variante de la normalidad** de crecimiento por lo que no solicita estudios.

e. Considerar realizar la **consulta inmediata** con endocrinología infantil.

f. Lucía se encuentra **dentro del rango** genético familiar.

g. Solicita radiografía de mano y muñeca izquierda con informe de edad ósea.

h. Lucía comenzó con su desarrollo puberal.

Pregunta 2

Ud. está atendiendo en el consultorio a **Gabriel de 2 años de edad**.

Su madre, Malena, consultó oportunamente porque su hijo, presentaba desde hacía aproximadamente tres meses, **deposiciones más blandas y abundantes** que las que acostumbraba tener antes. Junto con la valoración clínica de Gabriel, se le investigaron en la última consulta los **anticuerpos IgA antitransglutaminasa que resultaron positivos**, la **biopsia confirma la sospecha diagnóstica**.

¿Cuál es la información más adecuada para comunicar a Malena respecto de la afección de Gabriel? (Marque hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una:

a. El crecimiento pondoestatural **será subóptimo**, aunque el tratamiento se cumpla dentro de las pautas previstas.

b. Gabriel tendrá un crecimiento pondoestatural normal, si cumple con las indicaciones y los controles regulares.

c. Debe efectuar dieta libre de gluten **hasta completar el cierre de los cartílagos de crecimiento**. (NO, porque se hace de por vida)

d. Gabriel **requiere estudios adicionales** para comenzar una dieta libre de gluten (No, ya tiene el dx de certeza)

e. Es muy probable que Gabriel **pueda consumir gluten sin inconvenientes**, durante el transcurso de su vida adulta.

f. Debe efectuar régimen libre de gluten de por vida.

g. Si se mantiene sin síntomas clínicos, después de 1 año de no recibir gluten, **podría incorporar el mismo de modo paulatino**, bajo estricta supervisión médica. (NO, porque se hace de por vida).

h. Es necesario investigar la posible presencia de enfermedad celíaca en el grupo familiar.

Pregunta 3

Los padres de **Tomás, de 8 meses** de edad, concurren al servicio de emergencias refiriendo que su hijo comenzó con **dolor abdominal intermitente y vómitos**, desde hace aproximadamente **6 horas**. Se realizan estudios que incluyen una **ecografía abdominal** en la que se evidencia imagen en **escarapela en región de fosa ilíaca derecha**. Al revisar la historia clínica de Tomás, ¿cuáles de los siguientes datos clínicos es más probable que se hayan registrado? (Marque hasta tres opciones). **Dx invaginación intestinal ES UNA URGENCIA QUIRURGICA sanjusto 3 199 página 77 flor-co**

Seleccione una o más de una:

a. Las deposiciones fueron desligadas con presencia de moco y sangre.

b. La madre refiere que por momentos lo ha notado mas somnoliento.

c. Ha presentado vómitos biliosos.

d. En la radiografía no se visualizaba claramente la sombra del psoas derecho.

e. Presentó un episodio de hematemesis.

f. Ha tenido fiebre mayor a 39°C.

g. Al palpar el abdomen de Tomás se percibía una tumoración en epigastrio.

h. Padeció una infección reciente de vías aéreas superiores. (No, encontramos nada que justifique)

Pregunta 4

Concurre a control Johana con su hija **Juanita de 10 días de vida**. Se trata de una recién nacida de embarazo controlado sin patología. Alta a las 72 hs de vida. Nació a **término (40 semanas)** y con 3000 gr de peso. Al examen físico actual pesa 2.900 gr y se presenta en buen estado general, vital y reactiva. Se observa tinte **ictérico hasta las rodillas**. Aún no se le ha caído el cordón. No se palpan visceromegalias. **Se alimenta con lactancia materna exclusiva.**

¿Cuáles de las siguientes son las conductas iniciales correctas? (Marque hasta 3 opciones) Seleccione una o más de una: **Ictericia flor_co 21**

a. Tranquilizar a Johana y control ambulatorio en 48 hs.

b. Solicitar ecografía hepática y de vías biliares.

c. Indicar luminoterapia y si no funciona exanguinotransfusión. (no es Killer)

d. Solicitar hemograma, hepatograma y orina completa.

e. Solicitar hematocrito, dosaje de bilirrubina total y directa.

f. Solicitar test de Coombs.

g. Indicar a la madre colocar a Juanita al sol a través de la ventana.

h. Solicitar grupo sanguíneo y factor Rh de Johana y de Juanita.

Pregunta 5

Ud. se desempeña como médico generalista de guardia en una clínica, ese día le comunican que el pediatra no puede concurrir porque fue diagnosticado **covid +**. Entonces Ud. debe realizar el control de Martín, un **recién nacido** que se encuentra con su **madre en internación conjunta** y le acaban de dar el alta. Martín nació de parto normal, pesó 3.500 grs. En la epicrisis de alta Ud. lee, Apgar 9/10 **7-10** y que ya recibió vacunas hepatitis B y BCG. ¿Qué pautas le indica a la mamá para el cuidado de su bebé en el hogar? (Marque hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una:

a. Indica dejar una *gasa húmeda con alcohol* luego de finalizar la higiene del cordón.

b. Indica dormir con enteritos de algodón y posición supina del bebé.

c. Indica colocarlo al pecho cada tres horas, 5 minutos de cada lado.(libre demanda)

d. Indica limpieza del cordón con alcohol.

e. Sugiere que es mejor colocar una *pequeña almohada* para posicionar la cabeza. (no poner objetos en la cuna)

f. *Indica para el sueño seguro colocarlo en posición ventral.*(posición supina del bebé)

g. Sugiere dar de mamar a libre demanda.

h. Sugiere que si el recién nacido llora mucho, complementar su alimentación con leche de fórmula. (No)

Pregunta 6

Concurre a la consulta Ana con sus dos hijas **mellizas de 2 años** de edad previamente sanas. Ana refiere que ambas han comenzado con **diarrea hace 48 horas**, pero se encuentra más preocupada por **María** que se encuentra **molesta, llora sin lágrimas, ha vomitado 6 veces en las últimas 2 horas a pesar de ofrecer líquidos fraccionados con cucharas y no ha orinado en las últimas 12 horas. (deshidratada grave)**

Al examen físico **María** presenta frecuencia cardíaca de **140** latidos por minuto, **buen relleno capilar, ojos hundidos, signo del pliegue y mucosas secas.**

La otra niña, **Carmela**, **no ha presentado vómitos**, y al examen físico se **observa mucosas semihúmedas, frecuencia cardíaca 100 latidos por minuto, esbozo de signo de pliegue, resto sin particularidades (deshidratada leve).** Ante esta situación ¿cuáles opciones son las más adecuadas? (Marque hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una:

a. Indica a Carmela sales de rehidratación oral y reevalúa en una hora.

b. Internar a María.

c. Indica probar tolerancia oral a Carmela con solución isotónica en su domicilio.

d. Usted decide internar a ambas hermanas, e indica hidratación convencional por vía enteral.

e. Rehidrata a María por sonda nasogástrica con sales de rehidratación oral. (No internar a ambas)

f. Rehidrata a María en forma endovenosa.

g. Usted decide internar a ambas hermanas, e indicar a ambas niñas soluciones polielectrolíticas. (No, no debe internar a ambas)

h. Decide internar a ambas hermanas, solicita laboratorio en indica hidratación convencional por vía parenteral. (No, no hay criterio para internar a ambas)

Pregunta 7

Los padres de **Esteban, de 22 meses (1 año 10 meses)**, acuden a su consultorio. Están preocupados por su maduración. De un embarazo controlado, nació a las 37 semanas de edad gestacional por cesárea de urgencia por desprendimiento de placenta. **Tuvo sufrimiento fetal agudo y fue deprimido grave, recibiendo reanimación en la sala de partos.** Estuvo internado un mes en la unidad de cuidados intensivos neonatales, con muy buena evolución. Inmunizaciones completas para la edad.

Antropometría: Peso pc10-25, talla pc 25, perímetro cefálico pc 25-50. Examen físico sin particularidades. ¿La ausencia de cuáles pautas madurativas es **signo de alarma** para usted? (Marque hasta 3 opciones). Seleccione una o más de una: Dx

a. Señalar las figuras de su papá y mamá en un dibujo.

b. Decir mamá y papá. (12M)

c. Entonar una canción infantil sencilla.

d. Hacer una torre de 12 cubos. (apilar 5 cubos)

e. Decir oraciones de dos palabras.

f. Introducir pequeños objetos dentro de un recipiente.

g. Subir escaleras alternando pies.

h. Patear una pelota. (18 M)

Pregunta 8

Fiorella, de 6 años, es llevada por sus padres a control luego de haber efectuado una consulta previa un mes atrás. En dicha oportunidad, el motivo de consulta había sido el **poco apetito y la ingesta reducida de alimentos, mayormente fideos, pan y galletitas**. Por esta razón se le habían efectuado una serie de estudios, en los que se informaba que Fiorella estaba levemente anémica (**tenía una hemoglobina de 11.3 gr/dl**), por lo que se decidió indicarle hierro por vía oral y **regresar en 3 meses para evaluar la respuesta al tratamiento**. La madre refiere que actualmente su dieta es mas variada. Ello ocurre hace una semana, momento en que se solicitan nuevos exámenes complementarios, cuyos resultados se detallan más abajo.

Antecedentes personales: Fiorella es una niña por lo general sana, concurre a primer grado con buen rendimiento

escolar.

Examen físico: Fiorella se encuentra en buen estado general. Peso: 17,0 kg. (Pc 25), Talla 114,0 cm (Pc.25-50), mucosas húmedas y coloreadas. Aparato cardiovascular: se auscultan dos ruidos en los cuatro focos. Silencios libres. TA: 90/55 mmHg. Frecuencia cardíaca: 90 latidos por minuto. Abdomen blando, depresible, no se palpan visceromegalias. Resto del examen físico sin particularidades.

Los nuevos estudios que se le han solicitado a Fiorella muestran: **Hb 11.8 gr/dl** hay que subir 1g/mes., Hematocrito 36%. Volumen Corpuscular Medio 60 femtolitros; Hemoglobina Corpuscular Media 24 picogramos. Reticulocitos 1.2%. Bilirrubina total: 1.2 mg/dl., Bilirrubina indirecta: 0.9 mg/dl. Bilirrubina directa: 0.3 mg/ dl.

Con los datos disponibles, ¿Cuáles son las conductas más adecuadas a seguir? (marque hasta tres opciones) Seleccione una o más de una:

Anemia flor_co pagina 100

a. Solicitar sangre oculta en materia fecal.

b. Solicitar ferremia, ferritina séricas y saturación de transferrina.

c. Continuar tratamiento con hierro por vía oral y controlar nuevamente en un mes.

d. Suspender tratamiento con hierro por vía oral y administrar por vía parenteral.

e. Considerar adecuada la respuesta al tratamiento con hierro y evaluar nuevamente en seis meses.

f. Investigar antecedentes de anemia en el grupo familiar.

g. Solicitar electroforesis de hemoglobina.

h. Complementar la dieta con alimentos ricos en hierro.

Pregunta 9

Los padres de **Elena de 2 meses** de edad están preocupados porque la niña, si bien fija la mirada en una cara y la sigue brevemente, no sigue objetos hasta la línea media (**ese está normal**). La preocupación de los padres se centra en que **su hijo de 4 años tiene un trastorno del desarrollo no especificado**. Elena es una niña nacida de un embarazo controlado, con **32 semanas de edad gestacional**. Al examen físico se encuentra en buen estado general, vital reactiva, presenta un buen tono muscular. En suficiencia cardiorrespiratoria. Presenta **reflejo de moro completo, reflejo ccleopalpebral presente**.

Con respecto al desarrollo de esta niña y a la preocupación de los padres, ¿Cuáles son las opciones más correctas? (Marque hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una:

a. Durante la evaluación del desarrollo se **debe separar** a Elena de sus padres para que el examen sea más objetivo.

b. Elena presenta un trastorno transitorio del desarrollo.

c. Elena es **muy pequeña para poder detectar un trastorno** del desarrollo.

d. Se debe conocer las edades de adquisición de las pautas madurativas.

e. Para darle una respuesta a los padres debe evaluar todas las áreas de desarrollo.

f. Es **muy poco probable** que Elena tenga un trastorno del desarrollo.

g. Se debe tener en cuenta la edad corregida por edad gestacional.

h. La edad gestacional de Elena es un **factor protector** para los trastornos del desarrollo.

Pregunta 10

Celeste, de **1 año y 3 meses** de edad, es llevada por sus padres al servicio de emergencias del hospital cercano a su domicilio. Ellos refieren que su hija comenzó con **fiebre, vómitos y dolor abdominal** hace poco más de **72 horas**, período en el cual, luego de la consulta con su pediatra de cabecera, le habían **administrado antitérmicos y líquidos fraccionados en cucharitas**. En las últimas horas del día de ayer comenzó a presentar **deposiciones diarreicas sanguinolentas**.

Examen físico: Peso 10,0 kg. Talla: 77,0 cm. Regular estado general. **Acentuada palidez, decaimiento e irritabilidad**. Se observa **rash petequial difuso y algunos hematomas en miembros**. Se le solicitan a Celeste distintos estudios complementarios para efectuar el diagnóstico.

De acuerdo a su hipótesis diagnóstica **(puede ser SUH anemia por palidez, trombocitopenia por petequia, IRA)**
flor_co 96

, en el laboratorio de Celeste ¿qué es lo más probable que se observe? (Marque hasta tres opciones)

Seleccione una o más de una:

a. Hipocromía y microcitosis en el frotis.

b. Hematocrito: 31%.

c. Leucocitos: 15000/dl. (normal para edad)

d. Urea: 35 mg/dl. (normal para edad)

e. Hemoglobina: 7.5 gr/dl.

f. Plaquetas: 250000/mm³. (normal para edad)

g. Natremia: 125 mEq/l.

h. Hematíes en orina: 30 por campo.

Pregunta 11

Dana, de **20 meses** es llevada por sus padres, al servicio de Urgencias **por cojera de 6 días** de evolución. En las últimas **48 horas presenta fiebre de 38°C y tumefacción de rodilla derecha que se acompaña de dolor con el apoyo**. Examen físico: Buen estado general, normohidratada. Peso: 11.700 gramos. Temperatura axilar **38°C**. Se observa **tumefacción y calor en rodilla derecha, dolor a la palpación y a la movilización articular, choque rotuliano presente**. **Limitación a la flexo-extensión, abducción, aducción, rotación interna y externa de la rodilla derecha**. Cadera derecha con movilidad activa y pasiva conservadas. DX

Ante este cuadro clínico, ¿cuáles son las conductas inmediatas más apropiadas? (Marque hasta 3 opciones) Seleccione una o más de una: **DX Artritis septica** **flor_co** página 114

a. Solicitar ecografía de rodilla derecha.

b. Realizar toma de muestras para hemocultivo e iniciar tratamiento antibiótico luego de conocer germen y sensibilidad.

c. Solicitar resonancia magnética de rodilla derecha. (no está mal pero no es la primera conducta)

d. Indicar tracción de partes blandas. (indicado se enfermedad de Perthes)

e. Solicitar radiografía frente y perfil de rodilla. (indicado se enfermedad de Perthes, osteomielitis)

f. Realizar toma de muestras para hemocultivo e iniciar tratamiento antibiótico empírico.

g. Indicar inmovilización articular con férula de yeso. (indicado se enfermedad de Perthes)

h. Efectuar artrocentesis y cultivo del líquido articular.

Pregunta 12

Concurre a control **Pamela de 5 años y 6 meses de edad.** Es una niña con **diagnóstico de asma moderada tratada con corticoides inhalados** dos veces por día desde hace un año y **salbutamol de rescate durante las crisis.** En este momento se encuentra sin interurrencias, la última crisis la presentó hace 1 semana, pero resolvió sin requerir internación. Su desarrollo es adecuado para su edad, está por ingresar a primer grado. **Las últimas dosis de vacunas las recibió al año de edad.** **Su madre se encuentra cursando un embarazo de 20 semanas.** (Carnet vacunación)

¿Cuál es su conducta con respecto a las inmunizaciones? (Marque hasta 3 opciones).

Seleccione una o más de una:

a. Pamela debe recibir Salk, DPT, vacuna antimeningocócica tetravalente, pero no puede recibir triple viral ni vacuna de varicela porque su madre está embarazada.

b. Pamela no puede vacunarse porque está recibiendo tratamiento prolongado con corticoides. (corticoides inhalados)

c. Pamela debe recibir Salk, DPT y Triple Viral, por su edad no está indicada la vacuna de varicela ni la antimeningocócica.

d. Pamela debe recibir Sabin, DPT, Triple Viral, vacuna antimeningocócica tetravalente y vacuna de varicela.

e. Pamela debe recibir Salk, DPT, Triple viral, vacuna antimeningocócica tetravalente y vacuna de varicela.

f. Indicar a la madre vacuna DPT acelular y Hepatitis B, si no la tiene aplicada y vacuna antigripal estacional.

g. Pamela debe recibir vacuna antigripal estacional y una dosis de Neumo 23 valente. (FR, paciente asmática)

h. Debe esperar 15 días luego de una crisis asmática para poder vacunar a Pamela.

Pregunta 13

Concurre al control en salud, **Ignacio de 1 mes de edad.** La madre le pregunta a Ud. sobre la importancia de **la hernia en el ombligo** y **el aumento de tamaño de la bolsa escrotal.**

Al examinar a Ignacio Ud constata:

-Hernia umbilical con anillo amplio.

-Bolsa escrotal con mayor tamaño del lado derecho, mientras el izquierdo impresiona normal. -No se observa tumefacción compatible con hernia inguinal.

-La transiluminación de la bolsa escrotal derecha es positiva.

Ante estos hallazgos ¿Qué le informa a la mamá de Ignacio? (Marque hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una: (Flor _co página 75)

- a. Es preferible no corregir quirúrgicamente la hernia umbilical porque es alto el riesgo de recurrencia postoperatoria.
- b. Es necesario realizar una consulta urgente con Cirugía infantil.
- c. El hidrocele podría ser un factor condicionante de torsión testicular. (Factor desencadenante sería la hiperlaxitud de los tej)
- d. El hidrocele se reducirá de modo progresivo durante el transcurso del primer año.
- e. Es común que el hidrocele comunicante varíe de tamaño durante el día.
- f. Es conveniente efectuar la corrección quirúrgica del hidrocele antes de los dos años de edad.
- g. La hernia umbilical que presenta Ignacio, podría requerir corrección quirúrgica sólo por razones estéticas.
- h. Es útil ocluir precozmente la hernia umbilical de Ignacio con moneda y tela adhesiva.

Pregunta 14

Gastón de 18 meses de edad es traído a la guardia del hospital donde usted trabaja, porque fue encontrado en la habitación de su abuelo con varios frascos de pastillas abiertos. La madre refiere que le quitaron dos comprimidos, no identificables de la boca y hallaron 25 más desparramados por el piso. Al examen físico el niño se encuentra somnoliento, pero se puede despertar. Su temperatura es de 37 °C, la frecuencia cardiaca es de 160 latidos 100-130 por minuto, la frecuencia respiratoria es de 24 respiraciones por minuto. Tensión arterial de 66/34 mm de Hg 80-105/45-70, el resto del examen físico es normal. (Intoxicación BZD)

Frente a esta situación, ¿cuál es la conducta inicial más adecuada?

(Marque hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una:

- a. Indicar jarabe de Ipeca para rescatar los tóxicos. (Casi siempre es CI)
- b. Solicitar tomografía de cerebro. (No, no hay contexto)
- c. Indicar pasar solución fisiológica hasta revertir la situación.
- d. Estabilizar la vía aérea colocando oxígeno con máscara al 100%.

e. Colocar una vía periférica de buen calibre.

f. Indicar una dosis de carbón activado.

g. Indicar sulfato de Magnesio.(Casi siempre es CI)

h. Realizar lavado gástrico para rescatar los tóxicos (No, porque es una CI)

Pregunta 15

Pedro de 4 meses y medio de edad es traído a la consulta hospitalaria por su madre Teresa de 26 años, preocupada porque el bebé tose desde hace aproximadamente **20 días cada vez con mayor intensidad en forma de ataques de tos varias veces por día y desde hace 4 días es tan violenta que lo hace vomitar, lo despierta de noche, lo deja agitado, se congestiona la cara y al finalizar el acceso de tos produce un ruido respiratorio raro.** El cuadro comenzó con fiebre de **38°C durante los primeros tres días y luego no volvió a repetir pero la tos seca se fue haciendo más intensa.** Conserva el apetito y se alimenta con pecho exclusivo. Es un RN de término con PN 3720 gr. Refiere que es sano hasta la enfermedad actual, realiza controles mensuales de salud y exhibe carnet de vacunas completo para la edad.

Convive con el padre, Luis de 26 años, tosedor habitual quien **fuma 20 cigarrillos por día**, empleado en una droguería, madre sana de 26 años, no fumadora, maestra jardinera y un hermano Rafael de 10 años con antecedentes **de alergia respiratoria** quien también presenta tos de más de un mes de evolución pero sin fiebre y sin complicaciones. Cursa 5º grado. Viven en un departamento de tres ambientes con todos los servicios.

Al examen físico se aprecia un lactante eutrófico, con cicatriz de BCG en deltoides. Afebril **con leve inyección conjuntival bilateral y algunas petequias en la frente y mejillas.** Presenta respiración tranquila, buena entrada de aire bilateral, **roncus bilaterales sin otros ruidos agregados, leve disminución del murmullo vesicular en vértice derecho:** FC 110 latidos por minuto, FR 40 respiraciones por minuto, SpO2 97% aire ambiental. Bajó 200 gr de peso respecto al control previo.

De acuerdo a su hipótesis diagnóstica, cuáles son las conductas adecuadas? (Marque hasta 3 opciones) Seleccione una o más de una:

obs convive con hermano en edad escolar, y madre jardinera, en ese contexto es comun neumonía por mycoplasma y el tto es claritro u eritro.El paciente presenta sintomas para sospecha de Neumonía y en este contexto puedo sospecha de Mycoplasma aunque no sea el germen más frecuente para esta edad.

a. Indicar metoclopramida para evitar los vómitos.

b. Realizar PPD 2UT a toda la familia. (No, no hay contexto clínico de los padres para TBC)

c. Solicitar test del sudor. (solo se sospecho de FQ, que no es el caso)

d. Realizar Radiografía de Tórax a los padres. (No, no hay contexto clínico de los padres para TBC)

e. Realizar aspirado nasofaríngeo para inmunofluorescencia de virus respiratorios.

f. Iniciar tratamiento con claritromicina 15 mg/kg/d hasta obtener resultados. (

g. Iniciar quimioprofilaxis con isoniacida 1 vez por día hasta obtener resultados. (No, no hay contexto clínico de los padres para TBC)

h. Realizar aspirado nasofaríngeo para Elisa para Bordetella Pertussis.

Pregunta 16

Sabrina es una inquieta niña de **6 meses** de edad. Concorre al Centro de salud por su control periódico. Se trata de una RNT de PAEG (38 semanas y 2560 gr al nacer). No tiene antecedentes patológicos y cumple regularmente con los controles de salud. No concurre a la guardería. **Al pesarla y medirla la nota conectada y algo decaída, sin compromiso del estado general.** Su peso y su talla se encuentran en percentil 50. Se alimenta con pecho y en ocasiones muy excepcionales le administran biberón de leche de fórmula cuando la madre debe realizar un trámite.

Al examen físico presenta: frecuencia respiratoria de 38 respiraciones por minuto con buena entrada de aire bilateral y sin ruidos agregados, frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, ritmo regular, silencios libres. Abdomen globuloso, indoloro, depresible y blando sin aumento de tamaño del hígado, no se palpa el bazo. **Se mantiene sentada con trípode inestable, tiene barrida cubital y balbucea.** Al examinar las **fauces, revela ampollas y vesículas en paladar blando.** Las membranas timpánicas se encuentran normo coloreadas y con triángulo luminoso presente.

La madre relata que tuvo y le **administró paracetamol**, y que el **hermanito de 4 años** fue visto en guardia hace **36 horas y medicado por “anginas” con Amoxicilina.** Actualmente persiste febril. Ante este cuadro, ¿Cuáles son las conductas más adecuadas? (Marque hasta 3 opciones) Seleccione una o más de una: (Faringoamigdalitis) pagina flor_co 122 algortimo)

a. Posponer la administración de vacunas que corresponden.

b. Solicitar exudado de fauces para estreptococo beta hemolítico del grupo A. (No, primero se hace tto sintomático x 5días y se no responde hace el strep test)

c. Indicar nistatina en gotas 4 veces al día El contexto del paciente nos hace pensar Faringoamidalitis no el Muguet)

d. Colocar al pecho con más frecuencia.

e. Suspender el inicio de incorporación de alimentación complementaria.

f. Indicar higiene con agua con bicarbonato de chupetes, tetinas y pezones. (El contexto del paciente nos hace pensar Faringoamidalitis no el Muguet)

g. Indicar amoxicilina 50/mg/kg día vía oral. (No, primero se le hace tto sintomático x 5días y se no responde hace el strep test si +)

h. Indicar paracetamol 10/mg/kg (2 gotas/kg) vía oral si repite fiebre hasta 4 dosis diarias.

Pregunta 17

Gemma tiene 9 días de vida y es traída a la consulta por su madre, muy preocupada, ya que manifiesta que “**no le baja suficiente cantidad de leche de sus pechos**”, y que la niña desde hace **2 días no presenta deposiciones.** Antecedentes: embarazo controlado, sin patología gestacional.

Gemma es una RNT, sana, con peso de nacimiento: 3,200 kg, talla: 49,0 cm y perímetro cefálico: 35,0 cm. Se alimenta con lactancia materna exclusiva desde el nacimiento. Peso al alta: 2,900 Kg.

El examen físico es normal. Peso actual: 3,180 kg.

Frente a esta situación Ud. decide: (Puede elegir 3 opciones)

Seleccione una o más de una: **obs Si la sospecha fuera de cólico del lactante** **flor_co Pag 78**

a. Observar técnica de amamantamiento.

b. Continuar con lactancia materna exclusiva.

c. Indicar gotas de simeticona. (No, simeticona sería indicado para tto de flatulencia, no es el caso de la pcte no hay sintomatología de colico de lactante)

d. Indicar a la madre metoclopramida.

e. Aconsejar a la madre que ingiera abundantes líquidos.

f. Medicar a Gemma con lactulosa. (NO, caso fuera necesario el indicado sería bifidosa, lactulosa y vaselina sería después de los 6 meses).

g. Indicar supositorios de glicerina. No, la niña no se encuentra constipada esta

h. Agregar fórmula para complementar la lactancia materna. (NO, no hay indicación)

Pregunta 18

Consulta a la guardia Mariela con su hija **Sofía de 20 meses** de edad, **previamente sana**. Sofía comenzó **con fiebre hace 72 horas con 3 registros de 38,5 grados por día que mejoran con antitérmicos**. Durante las primeras 48 horas hizo seguimiento telefónico con su pediatra de cabecera **y en el día de hoy al persistir la fiebre y tener dos episodios de vómitos** le indicó consultar a la guardia donde usted la recibe.

Al examen físico Sofía se **encuentra febril, decaída, con 38 grados, dolor a la palpación abdominal periumbilical**, sin defensa. Resto del examen físico normal.

Administra dosis de Ibuprofeno y al ceder la fiebre Sofía se encuentra en buen estado general. Se realiza orina completa: pH 6, densidad 1020, **nitritos positivos, leucocitos 20 a 30 por campo (normal es 5- 10)**. Resto normal. ¿Qué conductas se consideran **más adecuadas** en este momento? (Marque hasta 3 opciones). Seleccione una o más de una: **ITU flo_co70**

a. Indicar tratamiento con antibiótico vía oral.

b. Controlar en forma ambulatoria en 24-48 horas.

c. Solicitar urocultivo por punción suprapúbica, recuento de colonias y antibiograma.

d. Indicar tratamiento con antibiótico parenteral. (No, no está en estado toxico para hacer IV)

e. Solicitar hemograma, eritrosedimentación, PCR.

f. Solicitar urocultivo al acecho y recuento de colonias con antibiograma.

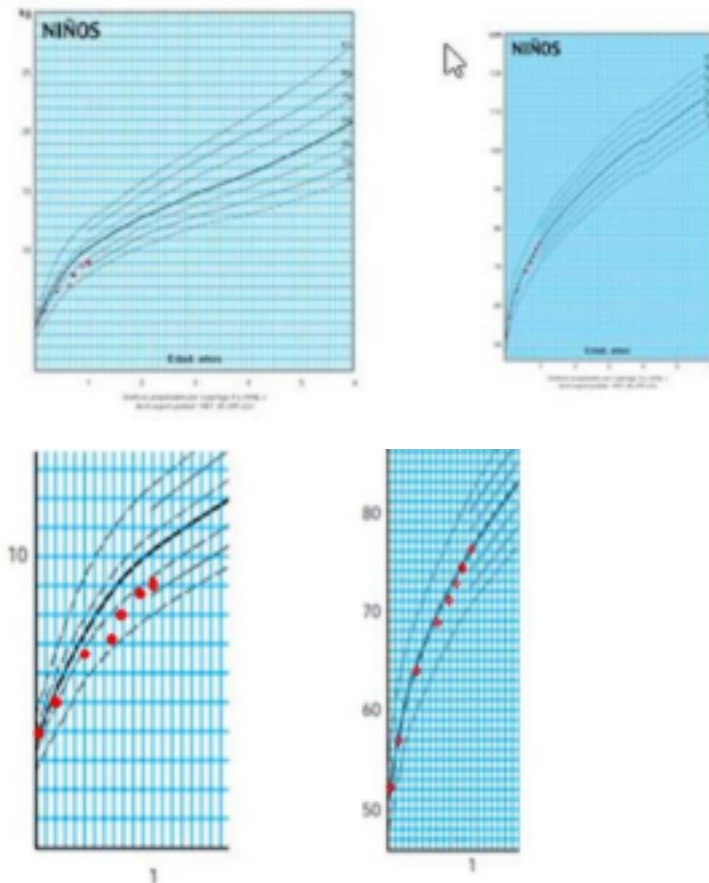
g. Internar a Sofía. (No, pcte no esta en estado toxico para internar y tiene mas de 2 meses)

h. Diferir inicio de antibiótico hasta recibir los resultados pendientes.

Pregunta 19

Concurre a control de salud **Santiago de 12 meses** de edad. El niño tiene como antecedentes ser RNT-PAEG, su talla y perímetro cefálico también eran acordes a su EG. Tuvo un episodio de **infección urinaria a los 8 meses**, por el cual **recibió tratamiento adecuado**. Maduración normal para su edad.

Usted realiza la antropometría de Santiago y grafica.



Ante estas curvas ¿Cuál es la interpretación más adecuada? (Marque hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una:

- a. Se observa un retardo de crecimiento de talla secundario a la infección urinaria.**(No, porque la talla se relaciona con proceso crónico y la ITU es un proceso agudo que se relaciona con peso)
- b. Tomás tiene Peso/Talla adecuado.**
- c. La talla de Tomás es acorde a su rango genético.** (No, porque falta datos de los padres)
- d. La curva muestra una caída en el percentilo de peso a los 8 meses.**
- e. En la curva de peso se observa recuperación antropométrica.**
- f. Tomás tiene baja talla para la edad.**
- g. Tomás tiene talla adecuada para edad.**

h. Tomás tiene bajo peso para edad.

Pregunta 20

Valentin de 3 meses de edad, es traído a la consulta por sus padres **por presentar vómitos desde la primera semana de vida**. Los vómitos **son generalmente postprandiales, sin esfuerzo, abundantes, intercalados con regurgitaciones de menor volumen**. En ocasiones, **vomita hasta 4 o 5 veces después de haber finalizado la ingesta**. La mamá se encuentra preocupada y afirma que, a veces, **“vomita toda la toma”**.

Valentín se alimenta con lactancia materna exclusiva a demanda, toma 6-10 veces al día y descansa bien después de cada toma.

Antecedentes personales: Embarazo controlado de curso normal. Parto por cesárea por falta de progresión. **Cribado neonatal de enfermedades metabólicas congénitas negativos**. Peso ao nacer: 3450 gramos. Talla: 49cm

Antecedentes familiares: **madre alérgica a polenes de gramíneas con asma estacional tratada con corticoides durante la primavera**. Padre con rinitis alérgica. Hermano de **6 años diagnosticado de enfermedad celiaca** hace 2 años.

Examen físico: Peso actual: 6.100kg. talla: 61,0 cm. Buen estado general. Mucosas húmedas. Conjuntivas rosadas. Aparato cardiovascular: se auscultan 2 ruidos en los cuatro focos, sin ruidos agregados. Frecuencia cardiaca: 130 latidos por minuto. Aparato respiratorio: buena entrada de aire en ambos pulmones. Frecuencia respiratoria: 35 respiraciones por minuto. Abdomen blando, depresible. Hígado: altura 6.5cm, se palpa borde inferior en línea mamilar a 2cm bajo el reborde costal. **“Vomitador feliz” (todo normal) flor_co pagina 80, san justo 1 pagina 600**

En consideración al problema de Valentin, ¿cuáles son las conductas más apropiadas?

a. Solicitar una seriada gastroduodenal. (ESTENOSIS HIPERTRÓFICA DE PÍLORO)

b. Controlar la curva pondoestatural sin indicar medicación.

c. Indicar a los padres que Valentín debe dormir en decúbito supino.

d. Solicitar la realización de una pHmetría. (No, porque no hay sospecha de ERGE [pagina 77](#))

e. Explicar a los padres acerca del riesgo potencial de desarrollar una esofagitis. (No, porque no hay sospecha de ERGE)

f. Solicitar una ecografía del canal pilórico. (ESTENOSIS HIPERTRÓFICA DE PÍLORO)

g. Explicar a los padres que los síntomas se atenuarán con el inicio de la alimentación semisólida.

h. Iniciar tratamiento con antieméticos previo a cada toma de alimento.

Pregunta 21

Ramiro tiene 50 días de vida, RNT PAEG, producto de un embarazo controlado, sin antecedentes perinatológicos relevantes. Vacunación completa. Acorde a la edad. Se alimenta con lactancia materna exclusiva. Es traído a la guardia por su madre, quien refiere que Ramiro presentó un **pico febril de 38.4°C la noche anterior, por lo que**

administró paracetamol. En la mañana del día de la consulta constató un registro térmico de 37.8°C y acude a la consulta. La madre manifiesta que el paciente se alimenta con avidez cada 2 horas, que no presentó vómitos, que no modificó la coloración de la piel ni se mostró irritable.

Al momento del examen físico: vigil, reactivo. Temperatura axilar: 37°C. fontanela anterior normotensa. Normocoloreado. **Normohidratado.** Frecuencia respiratoria: 36/min. Buena entrada bilateral de aire sin ruidos agregados. Frecuencia cardíaca: 135/ min. **Soplo sistólico 2/6 (Soplo inocente)** que modifica su intensidad con los cambios de decubito, sin irradiación. Hemodinamicamente compensado. Buen relleno capilar. Resto del examen físico sin características a destacar.

Ud. Solicita exámenes complementarios que informan: Hemograma: **Leucocitos: 13.900/mm³**, neutrofilos segmentados: 35%. Neutrofilos en cayado 4%. **Linfocitos 61%.** Hemoglobina: 12.9g/dl; Plaquetas: 235000/mm³. ERS: 19mm a la 1era hora, **PCR: 4.10.** Radiografía de torax: normal. Silueta cardíaca sin características a destacar. Orina: pH 5.8; densidad: 1010. **Leucocitos: 20-25/cpo. Hematíes 2-5/cpo. Uratos amorfos.** Dx fiebre sin foco flor_co pagina 69 algoritmo

Además de indicar antitermicos, Cuales son las conductas más adecuadas? (Marque hasta 3 opciones)

a. Mediar con antibióticos parenterales una vez tenido los resultados de cultivos.

b. Solicitar ecografía abdominal, renal y de vías urinarias.

c. Dar pautas de alarma y controlar en 24 horas. No, porque no cumple todos los requisitos de Rochester,/ Leucocitos: 20-25/cpo.

d. Mediar con ceftriaxona de inmediato. Si, porque no cumple todos los requisitos de Rochester,/ Leucocitos: 20-25/cpo.

e. Realizar hemocultivos y urocultivo.

f. Mediar con cefalexina.

g. Indicar la internación. (Si, porque no cumple todos los requisitos de Rochester,/ Leucocitos: 20-25/cpo.)

h. Solicitar ECG y evaluación cardiológica.

Pregunta 22

Enrique de 7 días de vida es traído a la consulta porque presenta **tendencia al sueño, succión débil y un vómito.** Al examen físico **se observa ictericia y hepatomegalia.** Aún **persiste cefalohematoma bilateral en cuero cabelludo.** Resto del examen físico normal. Se trata de un recién nacido de término con peso adecuado a su edad gestacional (39 semanas / 2950gr). Embarazo controlado sin patología. Alimentado con lactancia materna exclusiva. La bilirrubina total sérica es de **17mg/dl , bilirrubina directa 4mg/dl.** Ictericias flor_co pag 22

¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales más probables? Marque hasta 3 opciones

Obs: Si la prueba de coombs es negativa y el paciente presenta Bilirrubina Directa elevada, tengo que pensar en

causas Hepáticas: hepatitis, colestasis, galactosemia, sepsis y torch (sífilis).

a. Ictericias por déficit de glucosa 6 PD.

b. Ictericia por lactancia materna. (No, porque no es fisiológica dado que a hiperbilirrubinemia significativa o grave >17 mg)

c. Ictericias por hemoglobinopatías. (esta pienso se el Hto es bajo, tengo que solicitar frotis)

d. Ictericia por atresia de vías biliares.

e. Ictericia por cefalohematoma. (No, porque no es fisiológica dado que a hiperbilirrubinemia significativa o grave >17 mg)

f. Ictericia fisiológica. (No, porque no es fisiológica dado que a hiperbilirrubinemia significativa o grave >17 mg)

g. Ictericia por infecciones intrauterinas tipo TORCH.

h. Ictericia por sepsis neonatal.

Pregunta 23

Mara de 10 años es traída a la consulta hospitalaria por presentar **tos seca irritativa, persistente, sofocante por momentos y que finaliza con un ruido raro**. Su padre comenta que el cuadro comenzó hace aproximadamente 15 días con 48 hs de fiebre, resfriado y con tos leve a predominio nocturno. Le administro un jarabe para la tos, pero la misma se fue intensificando y algunos episodios son accesos de tos sofocantes, hasta que en el día de hoy un **vómito alimenticio luego de un acceso**. Refiere que una hermana mayor, Florencia de 17 años tuvo un cuadro similar de **tos y fiebre 15 días antes por lo que fue medicada con antibióticos y mejoró**.

Al examen físico se observa una niña delgada de piel morena **algo decaída** con mucosas rosadas, **ojos con inyección conjuntival pero sin secreciones**. respiración tranquila, frecuencia respiratoria 20 respiraciones por minuto con buena entrada de aire bilateral, ruidos sin otros ruidos agregados. Frecuencia cardíaca 120 latidos por minuto, silencios pulmonares. Cicatriz de BCG en región deltoidea derecha. Abdomen blando depresible indoloro sin visceromegalias.

Ud. decide efectuar por guardia una **radiografía de tórax frente que muestra imágenes hiliofugales bilaterales y una pequeña imagen opaca en seno cardiofrénico derecho** - (**derrame pleural**). Presenta carnet de inmunizaciones completo para la edad. Con los datos disponibles, cuáles son las hipótesis? **Neumonía atípica** flor_co pagina 136

a. Coqueluche.

b. Neumonía bacteriana aguda. (No, porque los síntomas son compatibles a una neumonía atípica y Neumonía bacteriana aguda es una neumonía típica)

c. Neumonía atípica primaria.

d. Neumonía viral aguda.

e. Tuberculosis primaria.

f. Fibrosis quística del páncreas. (La niña ya tiene 10 años ya le hicieron las pesquisa neonatal, entonces no es lo primero que pienso)

g. Crisis asmática leve persistente. (No hay datos suficientes que haga sospecha de asma dx coqueluche por la tos irritativa a predominio noturno)

h. Bronquitis viral aguda. (Dx con coqueluche, esta última se asocia con vómitos y la bronquitis no)

Pregunta 24

Usted se encuentra de guardia en un hospital materno infantil, y lo llaman a sala de partos, porque Marta, de 25 años de edad, que cursa su primer embarazo, controlado, y de bajo riesgo, se encuentra en periodo expulsivo (dentro de una maternidad segura y centrada en la familia, donde se cumplen las consignas de parto respetado). Nace un varón de término, respira y llora espontáneamente, es vigoroso, con buen tono muscular, líquido amniótico claro.Cuál es su conducta apropiada? **Recepción del RN flor_co pagina 9**

Marque hasta 3 opciones

a. Realizar el clampeo del cordón inmediatamente y trasladar al niño a la sala de recepción.

b. Colocar al niño sobre el pecho materno mientras aguarda 1 a 3 minutos para el clampeo del cordón.

c. Realizar la identificación en la sala de recepción durante el examen físico completo y sistematizado.

d. Realizar en la sala de recepción la toma de muestra para la pesquisa neurometabólica.(No, porque se realiza 48hrs despues del nacimiento y antes de la alta hospitalar)

e. Realizar la identificación del recién nacido antes de salir de la sala de partos.

f. Realizar en la sala de recepción las otoemisiones acústicas.(No, porque se realiza en 36 - 48 horas de nacido)

g. Luego de realizar las rutinas en la sala de recepción dejar al niño en observación durante 1 hora.

h. Luego de realizar todas las rutinas, el recién nacido inmediatamente regresa junto a su madre al sector de internación conjunta.

Pregunta 25

Concurre a la guardia del hospital con sus padres, Emanuel de **25 días** de edad. Ellos refieren que su hijo comenzó con **vómitos hace 5 días** y con cada día que pasa, **los vómitos son más abundantes e intensos**. Emanuel se alimenta solo con leche materna, llora mucho, **pareciendo que se queda con hambre**. La madre intenta calmarlo ofreciéndole **el pecho nuevamente, tras lo cual reaparecen los vómitos**. 48hs antes concurre a un centro de salud próximo a su domicilio donde le **indicaron complementar el pecho con un biberón de 100cc de formula espesada con cereal de arroz luego de cada mamada**. La mamá comenta que antes del inicio de los vómitos, las deposiciones de Emanuel eran frecuentes, bastante blandas y amarillentas, pero en estos últimos días son mas escasas y algo más oscuras.

Antecedentes perinatales: Parto eutócico en cefálica. Apgar 9/10 **7-10**. Peso al nacer 3500 gramos. Talla 51,0cm.

Perímetro cefálico 36,0cm. Alta a las 48 horas con peso de 3220 gramos. Control a los 15 días: **3600 gramos**.

Examen físico: Buen estado general, fontanela normotensa, pupilas isocóricas, mucosas rosadas, buen relleno capilar. Temperatura axilar: 37.1°C. Peso **3650 gramos**. Buena entrada de aire en ambos campos pulmonares. Frecuencia respiratoria 40 respiraciones por minuto. Dos ruidos cardíacos en los cuatro focos. Silencios libres. Frecuencia cardíaca 140 latidos por minuto. Reflejos y tono muscular de acuerdo a la edad. Abdomen blando, depresible, levemente distendido en hemiabdomen superior. Hígado a 2cm del reborde costal en línea mamilar. Bazo no palpable.

Le efectúan a Emanuel exámenes complementarios que indican: Hemograma: Hematocrito 33%. Hemoglobina 11.2g/dl. Globulos blancos: 11.700/mm³. Linfocitos 53%. Neutrófilos 38%. Eosinófilos 4%. Monocitos 5%. Basófilos 0%. **no infeccioso** Frotis: eritrocitos normocíticos y normocrómicos. Eritrosedimentación: 8 mm/h. Estado **Acido-Basico ph 7,63. Alcalosis** Bicarbonato: 39,5; Ionograma: Na 135mEq/L. **K: 2,8 mEq/L 3,5-5. Cl: 90mEq/l. 96-108** Coagulograma: concentración de protrombina 85%. Hepatograma: bilirrubina total: 0.8mg/dl. bilirrubina indirecta: 0.5mg/dl. bilirrubina directa: 0.3mg/dl. TGP: 48UI/L; TGO: 35 UI/L. Orina completa: 1020. Sedimento: escasos cilindros hialinos. También le realizan una ecografía abdominal.

De acuerdo con los datos clínicos y de laboratorio presentados y el informe en curso de la ecografía, que definirá el diagnóstico que Ud. Presume. Cuáles son las conductas más apropiadas para la resolución de la afección que presenta Emanuel? Marque hasta 2 opciones. **Sospecha estenosis hipertrofica del piloro** **ttto san Justo 3 642 flor_co 77**

a. Enviar a **Emanuel a su domicilio** y recomendar a los padres que no le ofrezcan biberones cada vez que lllore.

b. Mantener los biberones de cereales de arroz después de las mamadas y **agregar aceite al 1%**.

c. Efectuar cirugía, previa corrección de las alteraciones del medio interno.

d. Internar e indicar prueba tolerancia por vía oral con sales de rehidratación oral por cucharitas. (Paciente normohidratado, en vómitos CI SRO -sales de rehidratación oral)

e. Internar, indicando ayuno, e hidratación parenteral.

f. Continuar con la lactancia y ofrecer sales de rehidratación oral por cucharitas luego de cada vómito. (en vómitos CI SRO -sales de rehidratación oral).

g. Internar a Emanuel y enviarlo **con urgencia** a cirugía.

h. Indicar expansión rápida con solución fisiológica a 20 cc/kg. (No, pq el pte no se encuentra en shock)

23/julio/2021

1- Concurren a su consultorio en el interior de Santa Fe, los padres de Julio, **de 20 días** de vida, **por ictericia de piel y escleróticas**. En **dos oportunidades** anteriores consultaron por un leve tinte amarillento que fue interpretado como fisiológico.

Nacido por cesárea con 38 semanas de edad gestacional y 3.440 gramos de peso. Apgar 9 / 9 **7-10**. Grupo y factor materno y de Julio: A+. **Alimentación con fórmula de inicio.**

Examen físico: Buen estado general, **ictericia de cara y tronco**. Peso actual: 3.700 gramos. Talla 50.0 cm. Perímetro cefálico 36.0 cm. Signos vitales: frecuencia cardíaca: 140 por minuto **120-180**, frecuencia respiratoria 36 por minuto **30-50**, temperatura axilar 36 °C, oximetría con aire ambiental 95 %. Se palpa el borde hepático **romo** 2 cm por debajo del reborde costal derecho a nivel de línea medio-clavicular, sin esplenomegalia. Resto sin particularidades.

Laboratorio: **bilirrubinemia total 15 mg/dl, bilirrubinemia directa 12,3 mg/dl**, TGP 15 UI/l **37**, **TGO 52 UI/l 37**, **fosfatasa alcalina 1.995 UI/l 95-368**, gamma glutamil transpeptidasa 790 UI/l, glucemia 90 mg/dl, albuminemia 3,9 g/dl **3,2- 5,4**. Tasa de protrombina 92 % **70-100**, KPTT 38 segundos **35-45**.

Dx: Atresia de vías biliares flor_Co78

¿Cuáles son las conductas iniciales más adecuadas? (Puede marcar hasta 3 opciones).

Seleccione una o más de una:

- a. Solicitar telefónicamente el resultado de la pesquisa neonatal.
- b. Citar a control con nuevo hepatograma **en una semana**.
- c. Indicar alimentación con fórmula sin lactosa y proteínas parcialmente hidrolizadas.
- d. **Solicitar interconsulta a cirugía infantil.**
- e. Indicar dosaje de hormonas tiroideas.
- f. **Solicitar ecografía hepática y de vías biliares.**
- g. **Investigar las características de las deposiciones.**
- h. **Tranquilizar a los padres e indicar exponer al sol a Julio.** Killer

2 -Anahí consulta para un control de salud, tiene **6 meses** de vida, es la primera hija de Sandra y Julio (ambos de 32 años, y docentes). Fue una RNTPAEG y no presentó hasta el momento ningún problema de salud. Vacunación completa para la edad. La familia vive en el conurbano bonaerense y los padres trabajan en una escuela en el partido en el que viven, quedando Anahí al cuidado de su abuela materna en el tiempo en que ellos están trabajando. **Sigue tomando el pecho y también toma biberones con fórmula de inicio.**

Al examen físico se sienta, toma objetos y los lleva a la boca, y no se observa reflejo de extrusión lingual. Peso: 7.0

kg (pcn 25) y talla 64.0 cm (pc 25). En la consulta los padres preguntan acerca de comenzar con la alimentación con semisólidos. **Introduccion alimentar** -Página 52 flor_co50

Usted considera que: (Puede marcar hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una:

a. Alienta la ingesta de agua y desalienta la de jugos industriales y gaseosas.

b. Se debería aguardar a que alcanzara un peso y una talla en **percentilo 50** para comenzar con semisólidos. (No, si indica a los 6M)

c. Aclara que pueden añadir sal, azúcar y/o **miel** a las comidas.

d. Indica alimentos variados, pero **limitando** carnes y algunas frutas.

e. Considera un buen momento para comenzar con semisólidos.

f. Estimula el agregado de grasas (en forma de aceites o manteca, por ejemplo) a las comidas que se le ofrezcan.

g. Indica que comiencen con sucedáneos lácteos inicialmente.

h. Indica que comiencen con **vegetales crudos inicialmente** y más tarde incorporar otros grupos de alimentos (carnes, cereales y frutas).

3 - Carla es una recién nacida de **2 días** de vida, se encuentra en internación conjunta con su mamá. La madre le refiere que desde la noche anterior está **"lenta para comer"** y **le notó un pequeño movimiento en las manos y los pies.**

Antecedentes perinatales: cesárea a las 38 semanas, **extracción dificultosa con procidencia del cordón. Apgar 5-8.7-10 Se recuperó rápidamente con oxígeno libre.** Peso 3.420 grs. (Pc50), talla 50.0 cm(Pc 50), Perímetro cefálico: 34.0 cm. (Pc 50). Se **aplicó Vitamina k y vacuna anti-hepatitis B. Serologías maternas negativas.**

Examen físico: **pálida, temperatura axilar 35 grados, hipotonía generalizada, temblores finos espontáneos en miembros. Quejosa por momentos. Fontanela anterior abombada.** Frecuencia cardíaca: 130 por minuto . Ruidos cardíacos presentes en cuatro focos. **Frecuencia respiratoria: 60 por minuto 30-50.** Se auscultan rales diseminados. **Abdomen distendido, impresiona doloroso a la palpación.** Hígado 2 cm. por debajo del reborde costal, bazo palpable 1 cm por debajo del reborde.

Ud. decide su ingreso a Unidad de Cuidados Intensivos neonatal y realiza los siguientes estudios:

Hemograma: **hematocrito: 35 %** 45-64, **hemoglobina: 12 g/dl** 14,5-22,5, **glóbulos blancos 3000/mm³** 8-30.(NS: 64/35-62NC: 20 10-18/L: 25 26-36/E:2/ B:1 0,6/M:4 5-8), plaquetas: 110.000 mm³. **Radiografía: pulmón infiltrado reticular fino bilateral, abdomen irregular distribución de aire, hígado y bazo aumentados. Hemocultivo en proceso. LCR: xantocrómico(amarillento), sin coágulo, glucosa no dosable, proteínas 100 mg/dl, en el directo se observan abundantes diplococos, abundantes leucocitos y hematíes.**

De acuerdo al examen físico y el laboratorio. ¿Cuáles de los siguientes diagnósticos son los más probables? (Puede marcar hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una:

a. Hemorragia intracraneana.

b. Hipoglucemia. sanjusto 275

c. Sepsis no bacteriana. (No, por las características de LCR nos hacen pensar en una Sepsis bacteriana)

d. Meningitis bacteriana. flor_co 148página apunte clinicas 1581

e. Sepsis bacteriana. flor_co 35

f. Enfermedad de membrana hialina. (enfermedad del prematuro, el caso tenemos una paciente RNT)

g. Sepsis neonatal tardía. (presenta sx despues de 3-4semana de vida, Sepsis neonal clinica pagina 2905)

h. Sepsis intrahospitalaria.

4 - Marcelo, **de 8 años**, es traído por sus padres a la consulta **por presentar dolor abdominal intermitente, de localización periumbilical, difuso, de 3 meses de evolución. Interfiere con sus actividades escolares, debiendo ser retirado en varias ocasiones de la escuela.** Ha consultado en **dos oportunidades a la guardia, donde le indican inicialmente dieta, leche con bajo contenido en lactosa y grasas. Como no mejoró le han indicado omeprazol y domperidona, sin resolución de los síntomas.** Marcelo se alimenta bien, las deposiciones son normales y está asintomático entre los episodios de dolor. Examen Físico: Peso: Pc 50-75; Talla: Pc 50-75, TA 90/60 mm/Hg. Abdomen blando, depresible, no doloroso en el momento del examen. No se palpan visceromegalias, ni masas abdominales. El resto del examen físico es normal.

Con los datos disponibles, ¿cuáles son las conductas iniciales más apropiadas? (Puede marcar hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una:

a. Suspender la medicación.

b. Es conveniente que Marcelo no concurra a la escuela hasta establecer el diagnóstico.

c. Citar a una entrevista con ambos padres en ausencia de Marcelo.

d. Solicitar ecografía abdominal.

e. Solicitar interconsulta con salud mental.

f. Solicitar interconsulta con gastroenterología infantil.

g. Es importante sostener la presencia de Marcelo en la escuela.

h. Planificar una endoscopia digestiva.

5 - Lisandro, de **5 años** de edad, es dado de alta, luego de haber estado internado una semana en el hospital con diagnóstico de **glomerulonefritis aguda postestreptocócica**. Los padres de Lisandro quieren conversar con usted acerca del pronóstico y los controles posteriores que deben realizarle a su hijo.

¿Cuáles de los siguientes enunciados **considera que son los más correctos?** (Puede marcar hasta tres opciones) Flor_co página 94/98 clínicas 904/ Sanjusto 3, 459

Seleccione una o más de una:

a. Es conveniente que al menos durante el primer mes, se restrinja la actividad física.

b. Debe continuar con profilaxis antibiótica por al menos 6 semanas. (No, porque no es conducta)

c. Dentro de las 8 semanas, se tomarán muestras de sangre para controlar los niveles de C3. (No, porque C3 vuelve a valores normales)

d. Es probable que en pocos días su presión arterial sea la normal para la edad.

e. Debe recibir diuréticos hasta que desaparezcan por completo los edemas. (No, porque se adm en casos específicos)

f. La pérdida de sangre por la orina es uno de los parámetros que se han considerado para otorgar el alta. (No, porque para otorgar alta necesita de: fx renal normal o urea y creatinina en descenso, HTA hay que estar normal) Sanjusto 3 página 479

g. La recuperación posterior al episodio es habitualmente completa.

h. Dentro de los tres primeros meses luego del alta, requerirá una biopsia renal. (indicaciones flor_co94)

6- Concorre a la consulta Juana de **7 años**, traída por sus padres por presentar **fiebre (38,7°C) de 48 horas** de evolución, **cefalea frontal intermitente que ha empeorado en las últimas 12 horas**, **fotofobia y vómitos**.

Antecedentes: Desarrollo neuromadurativo acorde, escolaridad cursa segundo grado sin dificultad. **Presentó varios episodios broncoobstructivos** todos de manejo ambulatorio, utiliza desde los **5 años** **medicación controladora**. Carnet de vacunas: Hepatitis B x **ok**, BCG x **ok**, **Pentavalente xx**, **Salk xx**, **Antineumocócica conjugada xx**, Antirotavirus xx **ok**, **Antimeningocócica xx**.

Examen físico: Peso 27.0 kg, **T 37°C**. Regular estado general, normohidratada, en suficiencia cardiorrespiratoria. Frecuencia cardíaca 105 latidos/minuto **80-110**, frecuencia respiratoria 20 respiraciones/minuto **15-20**. Auscultación respiratoria buena entrada de aire bilateral. Glasgow 15/15, **cefalea y fotofobia**. **Signos de Kernig y Brudzinski positivos**. **Marcha inestable**. Diuresis y catarsis conservada. Durante el examen físico, **presenta episodio emético**.

De acuerdo a la sospecha diagnóstica, cuáles son las conductas diagnósticas más adecuadas? (Puede marcar hasta 3 opciones) **Dx Meningitis** flor_co 148

Seleccione una o más de una:

a. Resonancia de cerebro.

b. Antibióticos parenterales empíricos.

c. EAB, ionograma, urea, creatinina, amilasa, lipasa, hepatograma.

d. Internación.

e. Prueba de tolerancia oral y observación en guardia.

f. Antibióticos luego de recibir el resultado de los cultivos.

g. Hemograma, glucemia, PCR, 2 hemocultivos, punción lumbar.

h. Seguimiento ambulatorio en 24hs con analgésicos y antieméticos.

7- María José de **3 años** que consulta acompañada por su madre alarmada por la **presencia recurrente de prurito vulvar y flujo que mancha la ropa interior, con rascado muy frecuente del área vulvar y anal. Recibió tratamiento local en dos oportunidades.** No presenta antecedentes personales de importancia. La madre fue tratada recientemente con óvulos vaginales. Concorre al jardín de infantes desde este año con buena adaptación y realiza colecho eventual con los padres.

Al examen presenta: **Enrojecimiento de labios mayores, hiperemia de labios menores e introito, himen íntegro y se observa flujo vaginal blanco-amarillento.** Además se **observan lesiones de rascado en el área perianal.**

De acuerdo a su diagnóstico presuntivo, ¿cuáles son las conductas iniciales mas adecuadas? (Puede marcar hasta 3 opciones) **Dx oxiurius, candidiasis flor_co 183**

Seleccione una o más de una:

- a. Tomar de muestra para cultivo de Gonococo y Chlamydia.
- b. Recomendar el uso de ropa interior de algodón y dar pautas de higiene.**
- c. Solicitar evaluación por servicio social.
- d. Solicitar evaluación por psicología.
- e. Indicar el uso de ropa holgada.**
- f. Solicitar test de Graham.**
- g. Realizar vaginoscopia.
- h. Indicar crema local con clotrimazol.

8 - Malena, de **3 años** de edad, concorre con sus padres al centro de Salud próximo a su domicilio. Relata que **hace 15 días**, fue examinada por otro profesional por estar cursando **un episodio de deposiciones malolientes e inapetencia.** Constató un **leve descenso de peso respecto de controles previos, motivo por el cual le solicitó un examen coproparasitológico.** Malena concorre al jardín maternal. En la actual consulta, Ud. verifica el informe, **en el que se revela la presencia de quistes de Giardia lamblia.** Los **convivientes no refieren síntomas gastrointestinales.** ¿Cuáles son las conductas iniciales más adecuadas? (Puede marcar hasta tres opciones):

Seleccione una o más de una: **Flor_co 66**

a. Recomendar que Malena no deambule sin calzado en pisos con tierra. (Uncinarias y Strongyloides)

b. Suspender 7 días la concurrencia de Malena al Jardín Maternal.

c. Evaluar las condiciones medioambientales en las que se desarrolla Malena.

d. Indicar mebendazol a Malena. (mas indicado para Ascaris)

e. Indicar un estimulante del apetito a Malena.

f. Indicar tratamiento empírico antiparasitario a los padres.

g. Si los padres fueran portadores **no es necesario** que reciban antiparasitarios.

h. Indicar metronidazol a Malena. (flor_co 84)

9 - Patricio, **de 3 años**, es llevado a consulta por sus padres. Refieren que notaron que su hijo **despertó por la mañana con la cara hinchada y creen que presenta una reacción alérgica**. Asimismo, relatan que **les costó ponerle los zapatos**. No tiene antecedentes de infecciones previas.

Examen físico: Peso actual 20,100 Kg. Talla 98 cm. Estable, afebril. Se observa **edema de ambos párpados y de miembros en los cuales deja fóvea. No se observan edemas a nivel de los genitales**. Presión arterial 108/70 mm/Hg **80-120/50-80**. La auscultación pulmonar impresiona normal. Abdomen distendido, **globuloso, levemente doloroso a la palpación**. Borde hepático a 2 cm bajo el reborde costal. **Orina normocoloreada, con espuma**. Dx Sme nefrotico **Flor Co 91 sanjusto 3 521**

Con los datos disponibles, ¿cuáles son las conductas iniciales más apropiadas? (Puede marcar hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una:

a. Indicar furosemida hasta la desaparición de los edemas. (se trata con restricción hídrica controlada (balance negativo controlado) - Cuando es masivo y causa disconfort, se trata con ALBÚMINA + Furosemida (en push o por goteo continuo junto con la albúmina))

b. Internar a Patricio e indicar dieta hiposódica y normoproteica.

c. Solicitar biopsia renal lo antes posible.(No, porque no hay indicación) criterio de biopsia **flor_co 92/San justo 3 pg 526**

d. Indicar dieta normosódica e hiperproteica. (No, porque la dieta debe ser normoproteica, hiposodica, hipograsa)

e. Solicitar PPD y Teleradiografía de tórax. (por el tto con corticoides se solicita el PPD)

f. Solicitar orina completa, hisopado de fauces, C3, C4, ASTO, Streptozyme. (No, solo si estoy sospechando de sme nefritico post infecciosa)

g. Citar a Patricio para control ambulatorio.

h. Solicitar orina completa, proteinograma, lipidograma (suele estar acompañado de dislipidemia, hipoalbuminemia)

10 - Silvina, de 10 años de edad, es traída a la consulta por sus padres, quienes comentan que su hija presenta desde hace meses dolor abdominal. Presenta deposiciones desligadas en forma intermitente y en ocasiones acompañadas de mucosidad con estrías sanguinolentas. Efectuó consultas en otras oportunidades, durante las cuales se asoció el dolor con dificultades escolares y otras veces a transgresiones alimentarias. Debido a ello, fue tratada ocasionalmente con cambios en la dieta, además de la sugerencia de tener una entrevista con su maestra de grado. Los padres de Silvina han notado que últimamente se despierta por la noche al presentar dolor abdominal y deseos de evacuar. La madre está preocupada porque la nota inapetente, decaída y bastante más delgada, sin poder precisar cuánto ha bajado de peso.

Examen físico: Niña en regular estado general, afebril, decaída, adelgazada, con facies dolorosas. Peso: 24 Kg. (Pc 3-10) Talla 122 cm (Pc 3). Percentilos previos (Pc 25-50). Conjuntivas pálidas. Mucosas húmedas. Uñas en "vidrio de reloj". Abdomen plano, levemente tenso, dolor difuso e intenso, a predominio en flanco e hipocondrio izquierdo.

Se le efectuaron a Silvina los siguientes exámenes complementarios: Polimorfonucleares en materia fecal (+), parasitológico: Entamoeba coli, huevos de oxiurus vermicularis. Hemograma: Hematíes: 4.250.000/dl 3800millones-5300; hemoglobinemía: 10,3 gr/dl 11-13,5, hematocrito: 32% 35-44, leucocitos: 7.500/mm³ 7-13, neutrófilos 60% 35-60, linfocitos 35% 25-50, monocitos 4% 1-6, eosinófilos 1% 1-5, basófilos 0%. Plaquetas: 580.000/dl 150-400. Eritrosedimentación: 40 mm/1ª hora 0-10. Proteínas totales: 5,5 gr/dl 5,9-8. Albúmina: 2,5 gr/dl 3,2-5,4, α₁: 0,20 gr/dl α₂: 0,80 gr/dl, β: 0,60 gr/dl, γ: 1,40 gr/dl.

Con los datos mencionados, ¿Cuáles son las conductas más apropiadas a seguir? (Puede marcar hasta tres opciones): Dx Entamoeba coli, huevos de oxiurus vermicularis. San justo 2 723

Seleccione una o más de una:

a. Considerar que Silvina deberá efectuarse una endoscopia.

b. Internar a Silvina.

c. Realizar tratamiento antiparasitario **antes de continuar con otras medidas de seguimiento.**

d. Comenzar administración de hierro por vía oral.

e. Indicar dieta hiperproteica, en particular con alto contenido en albúmina.

f. Solicitar coprocultivo.

g. Indicar dieta astringente y reevaluar luego de valorar su eficacia.

h. Solicitar una interconsulta con psicología.

11- Carlos, de 10 años, es traído a la guardia por sus padres, porque presenta enrojecimiento y tumefacción en ambos párpados del ojo derecho, a predominio del superior, de 48 horas de evolución.

Antecedentes personales: Rinosinusitis alérgica tratada con mometasona en spray nasal hace dos años.

Vacunación completa.

Al examen físico: Frecuencia cardíaca: 100 latidos por minuto **70-100** . Presión arterial 105/68 mm Hg **90-140/60-95**. **Frecuencia respiratoria: 16 por minuto 13-15** . **Temperatura axilar 38,8 °C**. Luce en buen estado general, colaborador durante la entrevista. **Presencia de edema y enrojecimiento palpebral con disminución mayor al 50 % de la hendidura palpebral derecha, afectación conjuntival con hiperemia, edema y secreción, dolor intenso en los movimientos horizontales del ojo derecho.** No es posible evaluar la agudeza visual del ojo derecho, la del izquierdo es normal. No se observan otras lesiones en piel.

DX celulitis orbitaria Flor_co 118

¿Cuáles son las conductas iniciales en función de su hipótesis diagnóstica? (Puede marcar hasta tres opciones).

Seleccione una o más de una:

a. Solicitar tomografía de órbita y senos paranasales.

b. Indicar amoxicilina-clavulánico **por vía oral** durante 7-10 días.

c. Indicar prednisona 1 mg/kg/día por vía **oral** durante 5 días.

d. **Indicar ceftriaxona y clindamicina por vía parenteral.**

e. **Internar a Carlos y obtener dos hemocultivos.**

f. Indicar **tratamiento ambulatorio** por oftalmología en 48 horas.

g. Indicar colirio oftálmico con tobramicina.cha.

12 - Acompañado por su madre y tía materna concurre a la guardia Ariel, de **10 años**, por decaimiento durante la última semana, sumando **tos y agitación al caminar desde hace 48 horas**. El niño comenta que la orina ha adquirido **un color oscuro desde hace varios días**. Un **compañero de su grado está cursando una hepatitis hace un mes**. Vacunación completa.

Al examen físico: **frecuencia cardíaca 146 latidos por minuto 70-100**. **Presión arterial 140/100 mm 90-140/60-95** HG. **Frecuencia respiratoria 36** por minuto **13-15**. Temperatura axilar 36,7 °C. Aspecto **agudamente enfermo, pálido, edema bipalpebral, bilateral**. Sin aleteo nasal ni estridor inspiratorio, **ligero tiraje subcostal**, buena entrada de aire bilateral, **sibilancias aisladas, estertores crepitantes en ambas bases pulmonares**. Segundo ruido cardíaco ligeramente aumentado de intensidad, silencios libres. Pulsos periféricos presentes. **Abdomen levemente doloroso en hipocondrio derecho**, sin esplenomegalia. Puño percusión negativa. **En miembros inferiores numerosas máculas hiperpigmentadas cicatrizales y algunas lesiones con costras melicéricas.** (antecedente de infección de piel puerta de entrada para un posible SME Nefritico)

¿Cuáles son las **conductas diagnósticas** iniciales más adecuadas? (Puede marcar hasta 3 opciones)

Síndrome Nefritis Flor_co 94 san justo 3, 444

Seleccione una o más de una:

a. Solicitar urocultivo al acecho y comenzar tratamiento antibiótico vía oral.

b. Solicitar hepatograma y anticuerpos IgM para hepatitis A.

c. Solicitar ecografía de hígado y vías biliares.(Hígado congestivo por eso hígado doloroso)

d. **Solicitar teleradiografía de tórax frente.**

e. **Solicitar uremia, creatininemia y examen de orina completo.**

f. Solicitar C3 y C4, anticuerpos anti estreptocócicos.

g. Solicitar ecocardiograma urgente. (La sospecha es de EAP no de derrame)

h. Indicar prueba de respuesta a broncodilatadores. (no hay sospecha de asma mismo que haya sibilante)

13- Mariana concurre con sus hijos Margarita de 5 años y su hermano Félix de 16 meses al control de salud con su pediatra de cabecera.

Margarita presenta asma, recibe tratamiento controlador con budesonide desde hace 3 años. Su último episodio bronco obstructivo fue hace 1 mes, recibió tratamiento ambulatorio con salbutamol y corticoides orales por 5 días. Hace 4 meses permaneció internada por presentar enfermedad de Kawasaki y recibió infusión de gammaglobulina endovenosa. Actualmente se encuentra cursando un cuadro de gastroenteritis aguda leve en resolución.

¿Qué vacunas son necesarias indicar en estos casos según el calendario oficial de vacunación? (Puede marcar hasta tres opciones)

Seleccione una o más de una:

a. Margarita debe recibir IPV y triple viral.

b. Félix debe recibir las vacunas una vez resuelto el cuadro gastrointestinal. (No es CI)

c. Félix debe recibir IPV y quíntuple.

d. Félix debe recibir quíntuple.

e. Margarita debe recibir OPV, triple bacteriana y triple viral.

f. Margarita tiene contraindicada la vacuna triple viral. ((hay que esperar por lo menos 11M por su tto de Kawasaki _flor_c59)

g. Margarita debe recibir IPV y triple bacteriana.

h. Margarita debe recibir IPV, triple bacteriana y triple viral.

14 - Esteban de 9 años es traído a su consultorio por primera vez, pues hoy por la mañana mientras jugaba al fútbol tuvo sensación de falta de aire y opresión en el pecho por lo que debió abandonar el juego. La madre

refiere que tiene tos desde hace 48 hs, **sin fiebre pero comenzó con rinitis serosa, cuadros habituales en él, que suelen estar acompañados de prurito nasal y estornudos durante los meses de frío.** Niega antecedentes broncoobstructivos, pero reconoce que en **otras oportunidades tuvo dolor en el pecho durante el ejercicio por lo que realizó evaluación cardiológica que refiere que fue normal.**

Hijo único de **padre de 40 años, sano, fumador de 20 cigarrillos por día y madre de 36 años, con rinitis alérgica y fumadora social.**

Al examen físico: buen estado general, conversa sin dificultad, afebril, frecuencia cardíaca 100 latidos/min **80-110**, **frecuencia respiratoria 24 respiraciones/min 15-20**, **tiraje intercostal, leve disminución de entrada de aire bilateral con espiración prolongada y sibilancias espiratorias.** La medición de SpO2 es 97% AA y durante la evaluación presenta tos seca, persistente. **DX Asma Intermitente flor_co130**

¿Cuáles considera las **conductas iniciales** más adecuadas? (Puede marcar hasta tres opciones)

Seleccione una o más de una:

- a. Indicar salbutamol en aerosol hasta la próxima evaluación.**
- b. Suspender la actividad física por los próximos 30 días.(No, se suspende el ejercicio)
- c. Solicitar ECG y Ecocardiograma.(en la pregunta trae que el examen cardiologico normal)
- d. Solicitar Rx de Tórax.**
- e. Derivar al Neumonologo infantil.
- f. Solicitar espirometría basal y postejercicio.**
- g. Indicar nebulizaciones con budesonide 3 veces por día hasta la próxima evaluación.
- h. Solicitar Rx de senos paranasales.

15 - En la madrugada en la guardia usted recibe a Claudia, de **30 meses, por dificultad respiratoria.** La niña se despertó **con accesos de tos muy seca y dolor de garganta.** La madre le nota agitada. Había jugado durante toda la tarde, cenado muy bien y se había acostado temprano, momento en el cual la madre notó que Claudia **estaba disfónica.** Vacunación completa para la edad.

Al examen físico: Frecuencia cardíaca: 120 por minuto **90-120**. Frecuencia respiratoria 24 por minuto **15-25**. Temperatura axilar 37,5°C. Luce en buen estado general, **algo pálida y llanto ronco. Estridor inspiratorio y leve**

disminución del murmullo vesicular en ambos campos pulmonares, sin otros ruidos agregados.

Ante esta situación decide **inicialmente**: (Puede marcar hasta 3 opciones).

DX LARINGITIS SUBGLÓTICA=crup=LARINGOTRAQUEITIS flor_C0 125

Seleccione una o más de una:

a. Indicar nebulización con solución fisiológica fría.

b. Indicar nebulización con salbutamol en solución fisiológica.(No, no es asma)

c. Trasladar a la niña al cuarto de shock.(No, es leve)

d. Solicitar dos hemocultivos y comenzar con antibiótico parenteral.(No, porque es viral)

e. Indicar corticoides vía oral o nebulizado.

f. Permitir que Claudia adopte la posición de su preferencia.

g. Intubar al paciente con apoyo de anestesista o terapeuta.(No, no es grave)

h. Solicitar hemograma y medio interno.(No, son inmediata)

16- Concorre a la consulta Marcela de 25 años con su hijo Juan de **18 meses**. Viven en una localidad del Gran Buenos Aires junto a Pablo, el papá de Juan, y **su hermano de 4 años**. Marcela es peluquera y Pablo trabaja en un supermercado. Ambos terminaron el colegio primario. **Marcela fue alérgica al polen durante su niñez y Pablo fuma un atado de cigarrillos por día**. Al ingresar a su consultorio **Juan entró de la mano de su madre y traía un auto en su otra mano. Durante el examen físico, colabora levantando las manos cuando la mamá lo desviste pero cuando ella se aleja comienza a llorar.**

Presenta examen físico normal, pesa 9,950 kg (PC 25) y mide 80,5 cm (PC 25-50). Mientras dialoga con Marcela, Juan se mete abajo del escritorio para jugar con el auto y unos bloques. **Marcela le pide que salga pero el niño no quiere y se larga a llorar. Ella le entrega el celular y logra calmarlo.** Refiere que se comporta de esta manera en casa y que siempre la sigue, ayudando con las tareas del hogar. Marcela le pregunta si Juan tiene un desarrollo esperable para su edad y si está creciendo bien.

Teniendo en cuenta el motivo de consulta, ¿cuáles son las respuestas más adecuadas? (Puede marcar hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una:

- a. Solicitar interconsulta a psicología infantil por aparición temprana de berrinches.
- b. **Recomendar que le compre lápices** porque ya debería dibujar líneas.
- c. **Explicar a la madre que es normal que comience con berrinches.**
- d. **Desaconsejar el uso de pantallas.**
- e. **Comunicar a la madre que Pedro cumple con las pautas de un niño de 18 meses.**
- f. Citar para control de pautas madurativas dentro de 2 meses.
- g. Indicar alimentación hipercalórica porque Pedro está con bajo peso.
- h. Indicar interconsulta con neurología porque no cumple pautas madurativas para su edad.

17 - Concorre al control en salud, Ignacio, de **1 mes** de edad. La mamá le pregunta a Ud. sobre la presencia de **una hernia en el ombligo y el aumento de tamaño de la bolsa escrotal.**

Al examinar a Ignacio Ud constata:

-Hernia umbilical con anillo amplio de 2,5 cm de diámetro aproximadamente.

-Bolsa escrotal con mayor tamaño del lado derecho que no se modifica con el cambio de decúbito, el izquierdo impresiona normal.

No se observa tumefacción compatible con hernia inguinal. **La transiluminación bajo la bolsa escrotal derecha es positiva.**

Ante estos hallazgos Ud. ¿Cuáles de las siguientes opciones son las más adecuadas para comunicar a la madre?
(Puede marcar hasta tres opciones) Seleccione una o más de una:

Flor_c075

- a. **Probablemente el hidrocele se reduzca progresivamente dentro del primer año de vida.**
- b. Solicita que controle si existen cambios del tamaño del escroto durante el día.

c. Es útil ocluir precozmente la hernia umbilical con una moneda y tela adhesiva.

d. El hidrocele podría ser un factor condicionante de torsión testicular.

e. Es conveniente efectuar la corrección quirúrgica del hidrocele antes de los 2 años de edad. CONDUCTA

QUIRURGICA: LUEGO DE 18 – 24 MESES sanjusto 3, 170

f. Es necesario realizar una consulta urgente con el cirujano infantil.(

g. Se debe corregir quirúrgicamente la hernia umbilical antes de los 18 meses. (SE REALIZA CONDUCTA EXPECTANTE HASTA APROXIMADAMENTE LOS 2 AÑOS DE EDAD)

h. La hernia umbilical no requiere en general corrección quirúrgica.

18 - Simón de **7 años** concurre con su madre a la salita cercana a su domicilio por presentar **dolor puntual en la tibia distal derecha**. Consultó **hace 1 semana por el mismo problema, le solicitaron radiografía de miembros inferiores que no evidenciaron lesiones óseas**. Le indicaron **reposo y analgesia, sin mejoría**. Durante la anamnesis refiere haber **recibido un golpe durante un partido de fútbol hace una semana**, que no le impidió continuar jugando.

En el examen físico se observa reinguer de **su miembro inferior derecho, ligera tumefacción y aumento de la temperatura comparado con el lado contralateral**.

Solicita estudios y recibe los siguientes resultados: glóbulos blancos **15.700/mm³** 7-13, VSG **80 mm/h** 0-10, PCR **80 mg%** 3. Ecografía de tobillo derecho: **con colección subperióstica metafisaria distal de tibia**.

En función a su sospecha diagnóstica, cuáles son las **conductas iniciales** más correctas? (Puede marcar hasta 3 opciones) **Dx Artritis septica versus Osteomielitis** flor_copagina 114

Seleccione una o más de una:

a. Solicitar tomografía de miembros inferiores.

b. Indicar tratamiento antibiótico parenteral previa toma de muestra para cultivos.

c. Derivar a centro de mayor complejidad que cuente con especialista en oncología infantil.(No, todavía no hay sospecha de cancer aun)

d. Indicar tratamiento antibiótico **vía oral** y control ambulatorio.

e. Solicitar centellograma óseo **corporal total**.

f. Solicitar hemograma, coagulograma y ECG.

g. Indicar analgesia reglada, frio local y evitar deportes de impacto.

h. Derivar a centro de mayor complejidad que cuente con especialista en traumatología infantil.

19 - Francisco de **3 años** de edad ingresa a la guardia del hospital, derivado de una Unidad Sanitaria, por presentar dificultad respiratoria. Hace 3 días comienza con fiebre de **38°C grados y tos por lo que consulta y le indican salbutamol en puff y antitérmicos para bajar la fiebre**. No mejora el cuadro, aumentan los episodios de tos, **la curva térmica asciende a 39°C grados y la madre nota que “está agitado”** por lo que consulta nuevamente al centro de salud, donde le realizan tratamiento con salbutamol en forma secuencial durante dos horas, por falta de mejoría se decide su traslado al hospital de referencia.

Como antecedentes patológicos presenta **1 internación por bronquiolitis con hipoxemia a los 8 meses de vida**. La madre padeció TBC hace 5 años y completó el tratamiento. Actualmente asintomática. Tiene 2 hermanos sanos, sin síntomas respiratorios. La madre niega síntomas de Covid 19 en los convivientes. Vacunas completas para la edad.

Examen físico: Activo, vigil, conectado con el medio, normohidratado. **FR: 35 respiraciones/ minuto** 15-25, FC 128 latidos/min 90-120, Temperatura **axilar 38,4°C**, **saturometría de O2 92%** AA. Regular entrada de aire en **ambos campos pulmonares, rales crepitantes en base pulmonar izquierda, espiración prolongada y sibilancias espiratorias diseminadas. Tiraje subcostal e intercostal**. Abdomen blando, depresible, indoloro, hígado a 2 cm de reborde costal. **Radiografía de tórax: diafragmas a nivel del noveno espacio intercostal, se evidencian infiltrados parahiliales bilaterales, con imagen de consolidación paracardiaca basal izquierda, ángulos costofrénicos libres**. Hemograma: hematocrito 36% 35-44, hemoglobina 12mg % 11-13,5, **glóbulos blancos 23.000** 7-13, **neutrófilos 82%** 35-60, **linfocitos 15%** 25-50, Plaquetas 270.000/mm³. **Proteína C Reactiva: 45 mg/dl** 3,5. PCR COVID 19 : pendiente. Hemocultivos x 2: pendientes

De acuerdo a la sospecha diagnóstica, cuáles son las conductas iniciales más apropiadas? (Puede marcar hasta 3 opciones)

Neumonía flor_cp 136

Seleccione una o más de una:

a. Indicar corticoides parenterales.

b. Seguimiento **ambulatorio** con amoxicilina vía oral, sin requerimiento de aislamiento.

c. Indicar salbutamol en puff.

d. **Conducta antibiótica expectante hasta resultado de PCR COVID-19.**

e. **Indicar tratamiento con antibiótico y aislamiento.**

f. **Administrar oxígeno.**

g. Control **ambulatorio** e indicar Claritromicina vía oral.

h. **Solicitar PPD y Rx al grupo familiar.**

20- Consulta Maximiliano de **6 años** de edad por presentar **rinorrea seropurulenta de 1 semana de evolución, con halitosis y obstrucción nasal bilateral**, en los últimos tres días se agrega **tos nocturna, cefalea, malestar general y picos febriles de 39°C** . La madre dice que no consultó antes porque pensó que era una gripe mal curada. Antecedentes patológicos: **otitis media aguda a los 2 años de vida tratada con amoxicilina por 10 días, niega antecedentes de alergia y asma.**

Vacunas completas para la edad. Recibió vacuna antigripal 10 días previos a la consulta.

Examen físico: Peso 22.0 kg (pc 50/75) Talla 115.0 cm (pc 25/50). Frecuencia respiratoria: 20 por minuto **15-20**. Frecuencia cardíaca: 100 por minuto. **Temperatura axilar: 38.5°** . Presión Arterial 100/60 mmHg.85-**130/55-90**
Paciente alerta, consciente, orientado en tiempo y espacio. **Nariz: cúmulo de moco purulento que obliga al niño a respirar por la boca, sin desviación del tabique nasal a la inspección. Fauces congestivas.** Se visualiza **goteo de moco retronasal, discreto edema facial**. Dolor a la **presión en la región de senos maxilares**.
Cuello: no se palpan adenomegalias en las cadenas laterocervicales. Aparato respiratorio: buena entrada de aire bilateral con rales de transmisión de la vía aérea superior, sin tirajes. Resto del examen físico, sin alteraciones

¿Cuál de los siguientes conceptos le parece correcto en relación al caso clínico? (Puede marcar hasta 2 opciones) **+10 días con secreción mucopurulenta sospecho RINOSINUSITIS** flor co119

Seleccione una o más de una:

a. Indicar cefalexina vía oral durante 10 días.

b. Solicitar tomografía de macizo facial **para definir tratamiento.**(Dx clínica, TAC sospecha de complicacion)

c. No es necesario solicitar laboratorio para iniciar tratamiento.

d. Solicitar radiografía de senos y cavum para definir tratamiento.

e. Indicar budesonide y descongestivos nasales.(NO DOY ANTIHISTAMINICOS NI DesconGESTIVOS)

f. Indicar corticoides vía oral durante 4 días.(se dz laringitis)

g. Indicar amoxicilina vía oral durante 10 días.

h. Solicitar consulta con ORL.

21- Jonathan de **3 meses** de edad es traído a la guardia por cuadro de **tos de 24 horas de evolución**. Los padres refieren que **comenzó con mocos claros por nariz y tos seca esporádica, con 37,7 °C** de temperatura axilar **pero les preocupa que está con tendencia al sueño e inapetente**. En el día de hoy presentó dos regurgitaciones. Nació a **las 35 semanas** de edad gestacional, con peso de 2.170 gramos, dado de alta a las 48 hs. Se alimenta con pecho exclusivo con buena progresión de peso. No refiere otros antecedentes de importancia.

Su hermano de **5 años de edad** está resfriado desde hace **4 días pero sin fiebre y sin tos**. El padre sano de 32 años, **empleado fuma 15 cigarrillos por día pero no en el hogar**. Madre sana 30 años no fumadora, ama de casa. Viven en un departamento de dos ambientes, con todas las necesidades básicas.

Al examen físico se **aprecia aletargado, algo pálido, temperatura axilar 37,4 °C, frecuencia respiratoria: 66 por minuto 40-60**, frecuencia cardiaca: 148 por minuto **120-180**, auscultación cardiaca normal. **Presenta tiraje intercostal y supraesternal con aleteo nasal intermitente y se auscultan sibilancias inspiratorias y espiratorias con rales subcrepitantes diseminados bilaterales**. Abdomen algo globuloso pero depresible e indoloro se palpa borde hepático a 3 cm del reborde costal y se percibe polo de bazo. El resto del examen físico sin particularidades

¿Cuáles son las conductas iniciales más adecuadas frente a este cuadro? (Puede marcar hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una: **DX Bronquiolitis con puntaje de Tal 9 criterios de internacion** **flor_co 128**

a. Colocar sonda nasogástrica para alimentación.

b. Desobstruir las narinas y colocar en posición semisentada. (puntaje de Tal 9 criterios de internacion)

c. Continuar con pecho en forma frecuente y fraccionada para que tolere mejor.(NO, esta gravpuntaje de

Tal 9 criterios de internación)

d. Indicar kinesioterapia respiratoria.

e. **Internar en sala y colocar oxígeno por cánula nasal.**

f. Indicar salbutamol en aerosol cada 20 minutos durante una hora y revalorar.(Grave)

g. **Solicitar radiografía de tórax.**

h. Enviar al domicilio con salbutamol aerosol y **betametasona** y citar a las 24 horas.(No se dar GC)

22 - Valeria de **2 años** de edad, es traída por sus padres al servicio de emergencias. La madre relata que, volviendo del jardín maternal, Valeria tropieza y ella para evitar que se caiga, **la toma y levanta fuertemente del brazo izquierdo logrando mantenerla en pie. A partir de allí, la niña se encuentra molesta, llora por momentos y no mueve el brazo.**

Examen físico: Niña en buen estado general. Lloro ante el intento de ser examinada. **Brazo izquierdo en pronación, pegado al cuerpo, sin movilidad. No se observan hematomas ni crepitaciones a la palpación.**

Ante esta situación, las conductas más adecuadas relacionadas con el problema de Valeria son: (Puede marcar hasta tres opciones) **Dx PRONO DOLOROSO** **flor_co 115 san justo 317**

Seleccione una o más de una:

a. **Verificar la movilidad del codo 15 minutos después de haber solucionado el trastorno.**

b. Citar a Valeria para control radiológico en una semana.(No, hace una rx antes para descartar fractura y una después de la reducción)

c. Es conveniente evitar la movilización del brazo en las siguientes **24-48 horas.**

d. Sujetar la cabeza del radio con el pulgar y con el codo a 90 grados, supinar la muñeca y flexionar el codo hasta escuchar un crujido.

e. Colocar férula que inmovilice la articulación del codo.

f. Colocar compresas de hielo en el codo durante 15 minutos las primeras 24-48 horas.(No, hay que hacer una reducción de prono doloroso)

g. **Informar a los padres que a veces puede repetirse.**

h. Solicitar radiografía del brazo izquierdo.

23 - Concorre a la consulta Octavio, de **2 años** de edad. La madre refiere que su hijo presenta **fiebre desde hace 24 horas, con un registro máximo de 38,2°C**. Desde el **día anterior** recibe amoxicilina oral por consejo de una **amiga**. Entre otros síntomas, informa que **Octavio respira con dificultad, tiene la nariz tapada, abundante secreción mucosa, en ocasiones acuosa y en otras más espesa, y tos seca** desde hace **48 horas**. Presenta regular actitud alimentaria.

Examen físico: buen estado general. Temperatura **37,8 °C**. Se **observa rinorrea mucosa, fauces moderadamente congestivas, moco claro en cavum, otoscopia poco valorable por cerumen**. Auscultación respiratoria. Buena entrada de aire en ambos campos pulmonares. **Frecuencia respiratoria: 30 por minuto** 15-25 . Faringoamidalitis clínica viral flor_co121

Con los datos presentados, ¿cuáles son las conductas más adecuadas? (Puede marcar hasta tres opciones)

Seleccione una o más de una:

a. Efectuar cultivo de fauces.

b. Suspender amoxicilina.

c. Indicar gotas nasales descongestivas.

d. Humidificar secreciones nasales.

e. Efectuar test rápido para estreptococo beta hemolítico grupo A.

f. Indicar amoxicilina durante 10 días.

g. Indicar paracetamol.

h. Indicar jarabe antitusivo.

24- Usted se desempeña como asistente en la Guardia Externa del hospital. A las 2:00 AM concurre Daniela con su hijo, Pedro, de **42 días de vida**. El motivo de la consulta es haberle notado **“la frente caliente”**. **Pedro no estaba sobre abrigado y acababa de alimentarse como lo hace habitualmente**. Pedro es fruto de un embarazo controlado, con serologías del tercer trimestre negativas e hisopado anal materno negativo para estreptococo β

hemolítico grupo B. Es un nacido a término, peso adecuado a la edad gestacional, alta conjunta a las 48 horas, y recibió vacuna anti HBV y BCG. Se alimenta con pecho materno exclusivo. Daniela no nota cambios en el comportamiento de su hijo, en la actitud alimentaria ni en el patrón de sueño. En el día de ayer presentó 5 deposiciones amarillentas que no le llamaron la atención.

En la guardia Ud. **constata temperatura axilar de 38°C**, y **valora a un niño en buen estado general** con sensorio conservado. Al examen físico **no se encuentra ningún foco infeccioso que pueda justificar la fiebre.**

De acuerdo a sus hipótesis ¿Cuales son las conductas iniciales más adecuadas ? (Puede marcar hasta 3 opciones) **Fiebre sin foco** **flor_co_68**

Seleccione una o más de una:

a. **Solicitar examen fresco en materia fecal y coprocultivo.** (No, porque deposiciones estan normales y solo solicitado si hay clinica compatible)

b. **Solicitar radiografía de tórax.** (No, no hay contexto)

c. Indicar paracetamol 10 mg/kg vía oral.

d. **Internación en UTI y tratamiento empírico inicial.** (No, no es conducta)

e. **Solicitar aspirado nasofaríngeo para virus respiratorios.** (No, porque no hay clinica)

f. Observación por guardia para realizar estudios y eventual tratamiento.

g. Solicitar hemograma, reactantes de fase aguda, dos hemocultivos, orina completa y urocultivo.

h. **Solicitar hemograma y eritrosedimentación, y control ambulatorio en 24horas** con el resultado.

25 - Concorre a la guardia donde usted trabaja, Amalia, de **9 meses**, por fiebre (**38-38,5 °C**) **que cede transitoriamente con medios físicos y tos durante las últimas 72 horas que interrumpió su sueño durante la última noche.** Ha mantenido una buena actitud alimentaria.

Antecedentes personales: Vacunas completas. **Tuvo un resfrío, dos otitis medias agudas y una gastroenteritis aguda, todos con buena evolución.** Su padre, 24 años, albañil, su madre, 27 años, ama de casa, ambos sanos. Viven a 12 cuadras del hospital.

Al examen físico **luce en buen estado general, rosada.** **Frecuencia cardíaca 136/minuto** **100-130.** Presión arterial 90/56 mm Hg. **Frecuencia respiratoria 44 por minuto** **20-40.** Saturometría con aire ambiental **96 %.**

Temperatura axilar **37,6 °C**. **Fauces levemente congestivas**, ambos tímpanos rosados con triángulo luminoso presente. Sin aleteo nasal, **leve tiraje intercostal**, murmullo vesicular presente, sibilancias al final de la espiración en ambas bases pulmonares. Resto del examen sin particularidades.

¿Cuáles son las conductas iniciales más adecuadas? (Puede marcar hasta 3 opciones)

Bronquiolitis score de Tal 3 _flor_co_129

Control Ambulatorio con salbutamol 4h-6hs

Seleccione una o más de una:

a. Solicitar aspirado nasofaríngeo de secreciones respiratorias. (No, porque no es conducta)

b. Indicar nebulizaciones con **budesonide** cada 8 horas. **killer**

c. Internar al paciente con oxígeno. (No, porque no hay criterio)

d. Indicar paracetamol por vía oral si tuviera fiebre.

e. Continuar con la alimentación por vía oral.

f. Citar a control en 24-48 horas.

g. Indicar ibuprofeno y paracetamol **alternados** si tuviera fiebre.

h. Indicar bromuro de ipratropio por aerocámara cada 12 horas. (No, porque el dx es bronquiolitis)

EFU - 02/09/2021

Usted se encuentra en una guardia de emergencias. Recibe a Rosendo, un niño **de 8 meses de edad**, oriundo de Paraguay, con la familia recién llegada. Está al cuidado de la tía porque los padres están buscando trabajo. La tía sabe que tiene **un soplo en el corazón** y que lo estaban estudiando antes de que llegaran a Argentina. Hace 48 hs comenzó con **rinorrea serosa y febrícula**. Lo trae a la guardia porque comenzó en forma brusca

con **agitación y coloración azulada de mucosas**. Lloro durante el examen y en la guardia usted constata: frecuencia cardíaca: **160 /minuto**; frecuencia respiratoria: **68/minuto**; Saturación de oxígeno: **70% AA**. No ausculta soplo. No se auscultan sibilancias a nivel respiratorio. **OJO Normal p 6M -1A FC: 100-130 FR: 20-40: Saturación de oxígeno: 95-99%**

De acuerdo a su hipótesis diagnóstica(**BRONQUIOLITIS flor_co**), cuáles son las conductas iniciales más adecuadas? (Puede marcar hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una:

- a. Indica lorazepam.
- b. Indica tratamiento con salbutamol(hasta ahí correcta) y **corticoides. Killer según cor y flor**
- c. Coloca oxígeno.**
- d. Coloca al paciente en posición de cuclillas.**
- e. Indica diuréticos(no).
- f. Solicita interconsulta en guardia con neurología infantil.
- g. Ubica al niño en un ambiente tranquilo.**
- h. Tranquiliza a la tía dado que el episodio cederá en pocos minutos.

Manuel, de 16 años, concurre con su papá al consultorio de Pediatría debido a que presenta una **tumoración en la axila** derecha, de **30 días de evolución**, en ocasiones **levemente dolorosa**. **Nunca tuvo fiebre**. Refieren que hace 15 días consultaron a un centro de salud cercano, donde le **indicaron tratamiento oral con cefalexina que cumplió durante 14** días, pero que al no notar cambios luego del mismo, deciden consultar nuevamente. En la anamnesis el padre dice que nota que Manuel **bajó mucho de peso en el último tiempo**. Viven en el conurbano, alquilan una habitación en un hotel familiar, baño y cocina compartidos, **tienen un gato**. **Cloacas: no, agua de pozo**. Antecedentes de vacunación completa con cicatriz de BCG.

Al examen físico Manuel se encuentra en buen estado general, afebril, en suficiencia cardiorrespiratoria; Peso: 50.0 kg (Pc 10), Talla: 166.0 cm (Pc 25-50). Se constata una tumoración axilar derecha, **dura, algo dolorosa a la palpación**, de **4 x 4 cm de diámetro aproximado, adherida a planos profundos**, lo que limita moderadamente la movilidad del miembro superior derecho. No presenta otras adenomegalias, **sí se palpan microadenopatías submaxilares e inguinales**. Resto de examen físico sin otras particularidades.

En relación a lo previamente mencionado, cuáles son sus hipótesis diagnósticas más probables?(**pequisar ADENOPATÍAS**

en clinica completo 3) (Puede marcar hasta 3 opciones):

Seleccione una o más de una:

a. Infección por Citomegalovirus.(adenopatía cervical bilateral)

b. Tuberculosis.

c. Infección por Epstein-Barr.(adenopatía cervical bilateral)

d. Adenitis abscedada.(cervical))

e. Rabdiosarcoma.(masa abdominal pensar cuando tiene otorragia protusión globo ocular)

f. Toxoplasmosis. (generalizada)

g. Linfoma.

h. Enfermedad por arañazo de gato.

Adenopatías axilares dx'd: Secundarias a Enfermedad por arañazo de gato, vacunación reciente con BCG, linfomas no Hodgkin, artritis

Durante su guardia en un hospital de segundo nivel, concurren los padres de Carlos, de **20 días de vida -RN**, por **vómitos, rechazo a la alimentación e ictericia**. No constataron fiebre y las deposiciones son escasas. Embarazo controlado, con serologías maternas negativas, nació por cesárea de 38 semanas de edad gestacional, peso al nacer 3.440 gramos. Apgar 9 / 9 **7-10**. Lactancia materna exclusiva. Grupo y factor materno y de Carlos: O +. Fue dado de alta 72 horas atrás con diagnóstico de sepsis con cultivos negativos y examen de orina completa normal.

Examen físico: Peso: 3.550 gramos. Longitud corporal: 49.0 cm. Perímetro cefálico 36.0 cm. FC: 150 por minuto, FR: 34 por minuto, temperatura axilar 36 °C, oximetría con aire ambiental 95 %. Buen estado general, **ictericia de cara y tronco**, normohidratado y dormido en brazos de su madre. Ausencia bilateral de reflejo rojo. Semiología cardiovascular y respiratoria normales. Abdomen levemente distendido, **hígado de 9 cm de altura total a nivel de línea medio-clavicular**, sin esplenomegalia. Resto sin particularidades.

Laboratorio: **bilirrubinemia total 14 mg/dl**, bilirrubinemia **directa 10 mg/dl**, TGP 48 UI/l, TGO 52 UI/l, fosfatasa alcalina 800 UI/l, gamma glutamil transpeptidasa 250 UI/l, glucemia 75 mg/dl, albuminemia 3,6 g/dl. Tasa de protrombina 85 %, KPTT 38 segundos. Se reciben resultados de pesquisa **metabólica neonatal positiva** para galactosemia y resto normal.(**pesquisar clinicas completo 5 galactosemia**)

https://www.sap.org.ar/docs/congresos/2011/centenario_sh/eiroa_pesquisa.pdf

¿Cuáles son sus conductas iniciales frente a la sospecha diagnóstica? (Puede elegir hasta 3 opciones).

Seleccione una o más de una:

- a. Reforzar lactancia materna.
- b. Solicitar interconsulta con servicio de oftalmología (no es lo primero, se hace otras pruebas)
- c. Indicar fórmula de inicio libre de lactosa. (no es primera opción porque puede tener otros componente)
- d. Indicar exponer al sol a Carlos.(no marcar en choice exponer)
- e. Indicar alimentación complementaria con fórmula de inicio.
- f. Indicar alimentación con fórmula láctea a base de soja.
- g. Suspender la lactancia materna. ok
- h. Solicitar ecografía de abdomen.

Sabrina de 15 años concurre a la consulta acompañada por una amiga de la misma edad, está de novia hace unos meses e inicio relaciones sexuales con su novio de 17 años. Usa preservativo como método anticonceptivo y quiere saber cómo cuidarse mejor. Concorre a la escuela secundaria, practica hockey. Sus padres están separados y vive con su mamá y su hermana menor.

Antecedentes personales: refiere consumo de alcohol sólo los fines de semana en fiestas. Alimentación variada. Ocasionalmente presenta cefaleas tensionales y padece de asma intermitente leve.

Antecedentes ginecológicos: menarca a los 12 años, duración de ciclos: 30 días, duración del periodo menstrual 5 días, acompañado de dismenorrea leve. FUM hace 15 días.

Antecedentes familiares: refiere que su madre es hipotiroidea, su padre tiene colesterol aumentado y la abuela materna fue operada por cáncer de mama.

Examen físico: normal. IMC: 20,86. TA 100/60 mmHg. Examen mamario normal. Examen genital: escaso flujo vaginal blanquecino.

¿Cuáles son las recomendaciones más adecuadas? (Marque hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una:

- a. Recitar a Sabrina acompañada de un adulto responsable para brindarle asesoramiento sobre MAC.(no,

a partir dos 13)

b. Contraindicar ACO por el antecedente de cefaleas.

c. Indicar a Sabrina ACO de etinilestradiol + gestágeno.

d. Reforzar continuar con el uso de preservativo.

e. Solicitar hemograma, hepatograma, lipidograma, coagulograma y ecografía ginecológica.

f. Explicar anticoncepción de emergencia.

g. Indicar a Sabrina ACO de progestágenos solos.

h. Contraindicar el uso de ACO debido al antecedente de cáncer de mama de su abuela.

Vito, de **1 mes** de edad es llevado a la consulta por sus padres porque notan en **su piel un tono amarillento**, no lo había notado claramente los días siguientes al nacimiento pero desde hace varios días parece un poco más intenso. Concorre con algunos estudios que le han efectuado durante el embarazo y también algunos exámenes solicitados a Vito por un colega anteriormente.

Vito es fruto de un primer embarazo, **de término, con control prenatal**. Peso adecuado para la edad gestacional. Se constató eliminación de meconio a las 36 horas y la caída del cordón ocurrió al 7º día de vida. Hasta ahora ha sido un bebé activo, con buena disposición para alimentarse. Recibe exclusivamente leche materna.

Examen físico: **Piel y conjuntivas ictéricas**. Peso 4.0 kg, Talla 54.0 cm. Perímetro cefálico 38.0 cm. Temperatura 37°C. Frecuencia respiratoria 40/minuto. Frecuencia cardíaca 120/minuto. **Hígado firme con borde romo, a 3 cm del reborde costal**.

Resultado de los estudios de Vito: Grupo y factor: 0 Rh (-) **IgG para hepatitis A (+)**. Frotis de sangre periférica: glóbulos rojos normocíticos y normocrómicos. **Bilirrubina Total 13.6 mg%**. Bilirrubina directa: **9.2 mg%** GPT: **150 UI/l, GOT 90 UI/l normal ambas 37**. Test del sudor: **30 mEq/l de cloro**. Serología para HBV de Vito aún pendiente.

Estudios de la mamá de Vito: HBsAg (-) , **IgG anticore (+), antiHBs (+), IgG HAV (+)**.

Con los datos disponibles, Ud. piensa que: (marque hasta tres opciones)

Seleccione una o más de una:

a. La mamá de Vito es portadora crónica del virus hepatitis B. (No, HBsAg (-) para HBV crónica tiene que permanecer HBsAg (+) por más de 6 meses)

b. Vito debe ser evaluado con urgencia por un cirujano pediátrico, debido BD aumentado met hepático ok, pero alteración de transaminasas sumado hepatomegalia de borde romo, pienso que obstrucción.

c. Los anticuerpos IgG HAV en el suero de Vito, indican pasaje transplacentario de anticuerpos maternos.

d. La ictericia que presenta Vito se relaciona con la alimentación con leche materna. (No, porque BD > 2 no es fisiológica)

e. Vito ha adquirido hepatitis A probablemente por transmisión vertical.

f. La serología materna refleja una infección por HBV pasada y curada.

g. Los datos de la serología materna para Hepatitis B indican que la ictericia de Vito se debe probablemente a hepatitis B adquirida por transmisión vertical. (No, embarazo con control prenatal)

h. Los valores del test del sudor son compatibles con fibrosis quística del páncreas. (< 40 descarta FQ, entre 40-60 sugestivo, >60 confirma)

Milena, de 5 años de edad, es llevada a control en salud por sus padres. Es una niña que hasta el momento ha crecido y se ha desarrollado sin presentar problemas en su salud.

Examen físico: Buen estado general. Peso 18.0 kg (Pc 25-50). Talla 107.0 cm (Pc 25-50). Frecuencia respiratoria: 25 respiraciones por minuto. Buena entrada de aire en ambos campos pulmonares. Frecuencia cardíaca 90 latidos por minuto normal 90-120. Se ausculta soplo mesosistólico 2/6, en borde esternal izquierdo, que irradia a punta, pero no a dorso. No se palpa al colocar la mano en el pecho. Se atenúa al pedirle a Milena que se siente. Abdomen blando, depresible, indoloro. Hígado y bazo no se palpan.

Flor_Co pag 171 Soplo inocente

Ud. conversa con los padres acerca de los hallazgos en la evaluación clínica de Milena. En este sentido, les comenta que: (marque hasta tres opciones)

Seleccione una o más de una:

a. El soplo que presenta Milena es frecuente en los niños de su edad.

b. Milena no requiere estudios adicionales y puede desarrollar actividad normal.

c. Es conveniente que Milena no realice actividad física de competición. (No, es soplo inocente Son soplos que no se asocian a anomalía cardíaca (ni fisiológica, ni anatómica)

d. Le solicitará Tele Rx de tórax y electrocardiograma.

e. A medida que Milena crezca, el soplo puede hacerse más intenso.

f. Milena debe efectuarse de modo programado un ecocardiograma con Doppler.

g. **El soplo de Milena es probable que desaparezca al llegar a la pubertad.** (según google)

h. Es aconsejable que Milena se efectúe controles periódicos hasta la adolescencia.

Marcelo, de **8 años**, es traído por sus padres a la consulta por presentar **dolor abdominal intermitente**, localizado **en hemiabdomen derecho**, de **3 meses de evolución**. Interfiere con sus actividades escolares, debiendo ser retirado en varias ocasiones de la escuela. Ha consultado en dos oportunidades a la guardia, donde le **indican inicialmente dieta, fórmula con bajo contenido en lactosa y grasas**. Marcelo se alimenta bien a pesar de que lo **notan más delgado**, **las deposiciones han presentado moco y sangre** en algunas oportunidades.

Examen Físico: Peso: Pc 50 (**pc 75 hace 4 meses**); Talla: Pc 50-75 (**igual que hace 4 meses**), TA 90/60 mm/Hg. Abdomen **blando, depresible, doloroso** en el momento del examen en hemiabdomen derecho. **No se palpan visceromegalias, ni masas abdominales**. El resto del examen físico es normal.

Con los datos disponibles, ¿cuáles son las conductas iniciales más apropiadas? (Marque hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una: **pag 861 clinica completo 1**

a. Planificar una endoscopia digestiva.

b. Solicitar interconsulta con salud mental.

c. Solicitar hemograma, eritrosedimentación y PCR.

d. Solicitar interconsulta con gastroenterología infantil.

e. Solicitar ecografía abdominal.

f. Indicar omeprazol y domperidona.

g. Citar a una entrevista con ambos padres en ausencia de Marcelo.

h. Indicar internación.

8- En la madrugada en la guardia usted recibe a Claudia, **de 30 meses**, por dificultad respiratoria. La niña se **despertó con accesos de tos muy seca y dolor de garganta**. La madre **le nota agitada**. Había jugado durante toda la tarde, cenado muy bien y se había acostado temprano, momento en el cual la madre notó que Claudia **estaba disfónica**. Vacunación completa para la edad.

Examen físico: frecuencia cardiaca: 120 por minuto. Frecuencia respiratoria 24 por minuto. Temperatura axilar 37,5°C. Luce en buen estado general, **algo pálida y llanto ronco**. **Estridor inspiratorio y leve disminución del murmullo vesicular en ambos campos pulmonares**, sin otros ruidos agregados.

Se le indica en guardia nebulizaciones con **solución fisiológica fría y corticoides por vía oral sin obtener respuesta favorable**. **Aumenta el esfuerzo respiratorio y el estridor**. **Sospecha LARINGITIS SUBGLÓTICA=crup=LARINGOTRAQUEITIS** paginas flor co pag 125

Ante esta situación, ¿cuáles son las conductas adecuadas? (Marque hasta 3 opciones).

Seleccione una o más de una:

a. Indicar nebulización con salbutamol en solución fisiológica.

b. Indicar puff con budesonide.

c. Permitir que Claudia adopte la posición de su preferencia.

d. Indicar nebulizaciones con adrenalina.

e. Solicitar hemograma y medio interno.

f. Intubar al paciente con apoyo de anestesista o terapeuta.

g. Solicitar dos hemocultivos y comenzar con antibiótico parenteral.

h. Trasladar a la niña al cuarto de shock.

9- Julian de **18 meses** consulta con su madre que refiere que desde hace aproximadamente **3 meses** presenta episodios **de diarrea, con 4 a 6 deposiciones grumosas, malolientes**, que **no mejoran con la dieta** que le recomendaron varias veces en la guardia. No presenta antecedentes personales ni familiares de interés. Viven en una **vivienda precaria** en el tercer cordón del conurbano, con su pareja y abuelos maternos, con un dormitorio común, cocina, **agua de pozo y letrina**. Julian tomó el pecho hasta los **6 meses y luego leche de vaca y papillas, recibió hierro y vitaminas durante 2 meses**. Actualmente come con sus padres preferentemente **guisos y sopas**. Vacunas completas con carnet.

Al examen físico **impresiona pálido, con mirada vivaz, hidratado, abdomen globuloso y timpánico a la percusión**. Miembros inferiores algo adelgazados. Peso 9.100 Kg (Pc 3-10), talla 82.0 cm (Pc 25). **Dermatitis del pañal**.

En relación a lo previamente mencionado, cuáles de las siguientes conductas diagnósticas iniciales son las más adecuadas? (Puede marcar hasta 3 opciones) **Sospecha diarrea crónica esteatorreca más frecuente paratuberculosis (giardia y strongyloides)** **Flor cor página 88**

Seleccione una o más de una:

a. Clearance de alfa 1 antitripsina.

b. Test de Van de Kamer.

c. Búsqueda de Adenovirus y Rotavirus en materia fecal.

d. Radiografía de abdomen de pie.

e. Ecografía abdominal.

f. Hemograma con fórmula y proteinograma.

g. Coprocultivo con antibiograma.

h. Parasitológico en fresco y seriado.

10- Concurren a su consultorio Juan y Marcela con su hija Camila de **3 años** de edad por **fiebre y vómitos de 48 hs de evolución**. Refieren con preocupación que la niña presentó en el corriente año, **dos episodios afebriles**

de “ardor al orinar”, acompañados de micciones frecuentes y en forma esporádica incontinencia urinaria. Recibió **tratamiento con distintos antibióticos con remisión de los síntomas mencionados**. El tratamiento siempre fue precedido por toma de urocultivo y en forma recurrente **cultivó mayor de 10^5 UFC/ml de Escherichia Coli**.

Actualmente Camila presenta **fiebre de 38,5-39°C**. Examen físico: regular estado general, **febril, reactiva, mucosas semihúmedas, pulsos periféricos presentes y simétricos, relleno capilar menor a 2 segundos**. Frecuencia cardíaca: 135 latidos/min **90-120**, Presión arterial: 90/60 mm/Hg. **Abdomen blando, doloroso a la palpación, RHA presentes, no se palpan visceromegalias**.

¿Cuáles de las siguientes conductas iniciales considera más adecuadas? (Puede marcar hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una:

a. Indicar antibióticos por vía oral.(No, porque la nina presenta vomitos)

b. Solicitar hemograma, PCR, orina completa, urocultivo, 2 hemocultivos.

c. Dar pautas de hidratación, antitérmicos y control ambulatorio con los resultados de los estudios solicitados.(No, porque la paciente tiene ATC patológico eso es riesgo IBG)

d. Radiografía de abdomen de pie.

e. Interconsulta con cirugía infantil.

f. Indicar antibiótico por vía endovenosa.

g. Solicitar cistouretrografía con placa miccional y postmiccional.

h. Colocar plan de hidratación parenteral e internación

11- Lautaro, de **2 años de** edad, es llevado a la consulta por sus padres. Ellos refieren que su hijo presenta desde **hace aproximadamente 2 meses, deposiciones blandas, a veces semilíquidas**, muy frecuentes, y que en ocasiones sobrepasan el pañal. La primera deposición de la mañana es muy abundante y las subsiguientes un poco menos. Siempre **son diurnas y a veces tienen restos de alimentos sin digerir**. Hasta ahora no ha visto sangre o moco en la materia fecal y **no parece que Lautaro se queje de dolor abdominal**. Es un niño sano que sólo ha presentado dos episodios catarrales resueltos favorablemente. Tiene **buena predisposición para alimentarse**. **Cuando tiene sed, le ofrecen agua y jugo de naranja o manzana**, que suele tomar en cantidad.

Examen físico: Niño en buen estado general, afebril. Lautaro está asustado y llora durante la entrevista. Peso

12.0 kg (Pc 25-50). Talla 86.0 cm (Pc 25-50), **manteniendo sus percentilos habituales**. Normohidratado. Mucosas rosadas y húmedas. Frecuencia respiratoria 25 por minuto. Frecuencia cardíaca: 90 por minuto. Buena entrada de aire en ambos campos pulmonares, sin ruidos agregados. Auscultación cardíaca: se escuchan **dos ruidos en los cuatro focos. Silencios libres**. Abdomen blando, depresible, **levemente globuloso, indoloro a la palpación. Se palpa hígado a 1.5 cm bajo el reborde costal derecho.** (**Sospecha intolerancia a la lactosa**)

De acuerdo a su hipótesis diagnóstica, cuáles son las conductas más adecuadas? (marque hasta tres opciones)

Seleccione una o más de una:

a. Informar a los padres que se trata de un proceso benigno y autolimitado. (No, porque es más de dos meses)

b. Efectuar interconsulta con gastroenterología infantil. (No, tiene ningún estudio previo)

c. Investigar funcionalidad de hígado y vesícula biliar. **levemente globuloso, indoloro a la palpación. Se palpa hígado a 1.5 cm bajo el reborde costal derecho)**

d. Indicar dieta de prueba sin gluten. (No, hasta dx certeza)

e. Efectuar tratamiento empírico para *Giardia lamblia*. (No porque las heces claras, grasosas, fetidas, abundantes)

f. Suspender las bebidas con carbohidratos.

g. Suprimir los alimentos que se observan sin digerir en las deposiciones. (No, porque es normal que se elimine alimento sin digerir)

h. Indicar dieta variada con aumento del contenido graso.

12- Consultan a la guardia los padres de un niño de **5 años**, Juan, por **lesiones cutáneas de reciente aparición, pruriginosas y que desaparecen después de unos minutos y aparecen nuevamente en otros lugares del cuerpo**. Es la primera vez que le ocurre. En la cena **comió fideos con crema y manzana de postre**. Antes había concurrido a la escuela donde **jugó con plastilinas** y realizó clase de educación física.

Al examen físico usted observa **lesiones eritematosas, maculopapulares en tronco extremidades y cara**. Se **auscultan sibilancias bilaterales sin otros ruidos agregados**. La TA es de 95/60 mm/Hg y la frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto (**signos vitales normales**). Temperatura axilar 36,7 grados.

Ante este cuadro, ¿cuáles de las siguientes conductas son las más apropiadas en este primer momento (primeros 5 minutos)? (Marque hasta 3 opciones) (Anafilaxia apunte clínica todo 1, página 1492)

Seleccione una o más de una:

a. Indicar corticoides endovenosos.

b. Indicar corticoides por vía oral.

c. Indicar adrenalina intramuscular.

d. Indicar serie de salbutamol inhalatorio.

e. Realizar control ambulatorio en 24 horas.

f. Dejar en observación al paciente para control clínico.

g. Colocar oxígeno y venoclisis.

h. Indicar antihistamínicos por vía oral.

13- Ciro de 3 años de edad, sin antecedentes patológicos de importancia, con vacunas completas para la edad, residente en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, vivienda familiar precaria de un solo ambiente con agua de pozo y baño con descarga. Es el 6to hijo de 7 hermanos, el padre, cartonero recoge desechos de los barrios lindantes y a veces Ciro lo acompaña. En el último mes Ciro comienza con un cuadro clínico de distensión y dolor abdominal asociado a geofagia con vómitos alimentarios esporádicos y tos.

Al momento de su ingreso, el paciente presentaba los siguientes signos vitales: presión arterial 96/71 mm Hg; frecuencia cardíaca 110 latidos/minuto; frecuencia respiratoria 25 respiraciones/ minuto; temperatura 36,2°C; SpO2 95% AA. Peso 13 kg, talla 95 cm. Palidez mucocutánea, buena entrada de aire bilateral, se auscultan rales subcrepitantes bibasales, abdomen globuloso, doloroso a la palpación profunda, a predominio de la región peri umbilical, sin reacción peritoneal, ruidos hidroaéreos normales.

¿Cuáles de las siguientes conductas diagnósticas iniciales son las más adecuadas? (Marque hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una:

a. Solicitar coproparasitológico seriado, em fresco y test de graham.

b. Realizar endoscopía digestiva con toma de biopsias.

c. Solicitar sangre oculta en materia fecal.

d. Solicitar ecografía de abdomen.

e. Solicitar radiografía de abdomen de pie y tórax. (se usa en abdomen agudo oclusivo, nuestro paciente tiene RA normales, en sospecha de enteritis)

f. Solicita anticuerpos Ig A transglutaminasa y determinación de IgA sérica.(sospecha de enfermedad celíaca que no es caso en el paciente de caso)

g. Solicitar hemograma completo.(busqueda de anemia ferropénica y eosinofilia)

h. Indicar colon por enema. (se utiliza para invaginación intestinal)

14- Usted se encuentra en **un centro de atención primaria** y recibe a Bautista, **de tres meses** de edad. La mamá, Mariana, lo trae a la consulta porque lo **nota agitado y presenta sudoración al alimentarse**. Según cuenta Mariana ella nota que **Bautista se cansa cuando lleva unos minutos succionando el pecho**. Mariana **no controló el embarazo** porque tenía miedo de concurrir a la salita por la pandemia de COVID-19. No hay antecedentes patológicos familiares. Bautista nació a las 38 semanas, por parto vaginal, con un peso de nacimiento de 2.950 gramos. Tiene pesquisa endocrino-metabólica normal y OEA normales. Recibió las vacunas de acuerdo al calendario nacional. Se alimenta con pecho exclusivo.

Usted constata en el examen físico: **Palidez cutáneo-mucosa leve**. Peso actual: 4100 gr. FC: 140 latidos/minuto, **FR: 54 respiraciones/minuto** **Normal 30-50**, Sat 98% AA. Afebril. **Leve tiraje subcostal**. Auscultación cardíaca: **soplo pansistólico, intensidad 3/6, audible en múltiples focos, con mayor intensidad en 3er y 4to espacio intercostal izquierdo**. Pulsos periféricos simétricos. Abdomen: blando, depresible, **se palpa borde hepático 3 cm debajo del reborde costal**.

Según su hipótesis diagnóstica, **cuáles son las conductas iniciales mas adecuadas?** (Puede marcar hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una:

a. Solicita ecografía abdominal.

b. Solicita evaluación en un centro de mayor complejidad. (se encuentra en un centro de atención primaria)

c. Indica corticoides por vía oral. (No, se da en Bronquiolitis)

d. Solicita ECG y ecocardiograma.

e. Indica serie de salbutamol inhalado y observa respuesta clínica.(se sospecha de bronquilitis si, pero el paciente del caso tiene dificultad respiratoria por una posible cardiopatía, él tiene soplo pansistólico que es patológico)

f. Indica corticoides inhalados.(No, se da en Bronquiolitis)

g. Solicita urgente hemograma con frotis y hepatograma. (No, porque no se aportan datos revelantes si sospecha de bronquiolitis)

h. Indica ofrecer el pecho de forma fraccionada

15- Concorre a la guardia del hospital, Pedro, de 5 años de edad, acompañado por sus padres que se muestran preocupados porque su hijo presentó emisión de orinas oscuras en dos oportunidades. Hasta la mañana de ese día el niño había concurrido al jardín sin haber presentado ninguna sintomatología previa.

Exámen físico: Peso: 16.200kg. Talla: 106.0 cm. Tensión arterial: 120/80 mmHg. T° axilar: 36.4°C.Frecuencia respiratoria: 20 respiraciones/minuto. Frecuencia cardíaca: 100 latidos/minuto. Rinitis serosa moderada. Rales subcrepitantes bibasales. Discreta palidez de piel y mucosas. Lesión costrosa residual de 2 cm de diámetro en su rodilla izquierda de 15 días de evolución. Ganglio palpable en región inguinal derecha de 1 cm de diámetro y otro de 1.5 cm de diámetro ligeramente doloroso en región inguinal izquierda. Hígado a 1 cm del reborde costal, indoloro. Bazo no palpable. Signo de Godet positivo (+) en miembros inferiores. Resto del examen físico sin particularidades.

Los estudios complementarios son los siguientes: Hemograma: hematocrito: 36%, hemoglobina 11 gr/dl, leucocitos: 9.800/mm³ (neutrófilos 55%, linfocitos 40%, eosinófilos 3%, monocitos 2%). Plaquetas: 220.000/mm³. Uremia: 86 mg/dl Normal 10 -40. Ionograma: 132 mEq/l de sodio y potasio 3,8 mEq/l. Creatininemia: 0,8 mg/dl. Orina completa: densidad: 1015 - , pH 6, proteínas +, leucocitos 10-15/campo, hematíes 10-15 por campo. Se observan cilindros hialinos y granulosos. Teleradiografía de tórax: índice cardiotorácico 0,55, leve infiltrado bibasal.

¿Cuál de las siguientes son las conductas iniciales más adecuadas? (Marque hasta 3 opciones) Sospecha Sme Nefritico

Seleccione una o más de una:

a. Hidratación parenteral a necesidades basales más diuresis.

b. Control ambulatorio en 24 horas.(Se los padres tiene como garantizar el control en 24h y si el pcte no tiebe IRA)

c. Internar al paciente. (Si, porque el paciente presenta en el laboratorio Ureea aumentada, creatinina normal, cilindros granulosos, eso son hallazgos que caracterizam IRA que es criterio de internacion)

d. Indicar furosemida. (si, porque el paciente presenta Godet +)

e. Restricción hídrica.

f. Indicar metilprednisona. (Sme nefrotico)

g. Indicar inotrópicos. (ICC)

h. Indicar ceftriaxona.

16- La mamá de Leandro de 7 años de edad, le consulta acerca de los efectos de la administración de las vacunas que su hijo ha recibido o que recibirá más adelante.

Con relación a las preguntas que ella le formula, Ud. le informa lo siguiente: (marque hasta tres opciones).

Seleccione una o más de una:

a. Puede demostrarse la efectividad de la vacuna anti hepatitis B si se le extrae a Leandro una muestra de sangre y se detecta el antígeno de superficie HBsAg. (No, tiene que detectar AC contra el antígeno de superficie HBsAg)

b. Al haber recibido la vacuna anti hepatitis A a los 12 meses, puede determinarse en suero el anticuerpo denominado **IgM** HAV. (no, el anticuerpo denominado IgM HAV marca infeccion aguda)

c. Habiendo recibido la vacuna contra la varicela, si la contrajera nuevamente, la infección transcurrirá más leve y con pocas lesiones.

d. Respecto a la inmunización para tétanos, pertussis y difteria, a partir de ahora sólo podrá recibir vacunas acelulares.

e. La aplicación de la vacuna BCG que Leandro recibió al momento del nacimiento, impide la posibilidad de que adquiera tuberculosis a edades posteriores (No, evita formas complicadas)

f. Al ingreso escolar era necesario que recibiera un refuerzo de vacuna antineumocócica conjugada.(no, refuerzo 1 año)

g. Si bien la parotiditis es una enfermedad relativamente benigna, al haber recibido la vacuna, se evita en gran medida la meningoencefalitis y la anacusia.

h. Al ingreso escolar debería haber recibido el refuerzo para hepatitis A (No, dosis unica 1 A)

17- Lorenzo de 4 años de edad es traído por la madre a la consulta, por aparición reciente de lesiones eritematosas en cara, tronco y extremidades. No refiere antecedentes de traumatismos, (aunque su madre dice que habitualmente él es muy inquieto), no tiene antecedentes patológicos, ni ingesta reciente de medicamentos. No recibió vacunas recientemente.

Examen físico: se encuentra afebril (temperatura de 36 grados C), con decaimiento general. Se constatan lesiones eritematosas en cara, paladar, tronco y extremidades que no desaparecen a la vitropresión. No se constata visceromegalias.

Se realiza hemograma que informa: hemoglobinemia 12,4 g/dl -normal, Leucocitos 6.700/mm³ normal 7 -13, (con fórmula a predominio linfocitario) y plaquetas 10.000/mm³. Frotis sin blastos. Tiempo de protrombina 80% (70-100 o 11-15 segundo), APTT 35 segundos 35-45. Prueba de Coombs negativa y serologías virales pendientes.

Además de internar al paciente y en función de su diagnóstico elija las opciones que son más adecuadas. (Marque hasta 3 opciones) Sospecha PTI Flor_cor página 104

Seleccione una o más de una:

a. Solicitar consulta con el Servicio Social.

b. Indicar transfusión de plaquetas.

c. Solicita interconsulta con hematología.

d. Explicar que la enfermedad tiene baja chance de responder al tratamiento inicial.

e. Indicar gammaglobulina humana o pulsos de corticoides EV

f. Solicitar interconsulta a cirugía para esplenectomía de urgencia.

g. Solicitar punción de médula ósea.

h. Explicar que la enfermedad tiene alta chance de responder al tratamiento inicial

18- Sofía es una niña de **3 años** que es llevada a consulta por sus padres por presentar desde hace 3 meses, deposiciones **blandas, fétidas, acompañadas de dolor abdominal intermitente**. Los padres refieren que su hija está desde hace un **tiempo quejosa, irritable, y no tiene el apetito acostumbrado**. Destacan, asimismo, que le notan el **abdomen distendido y que está más delgada**.

Examen físico: Niña en regular estado general. Mucosas levemente pálidas, húmedas. **Cabello que se desprende con cierta facilidad, piel seca, uñas con estrías**. Peso: 10.0 kg (percentilo 10). Talla 93.0 cm (percentilo 25). Frecuencia cardíaca: 110 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria: 25 respiraciones por minuto. Abdomen **globuloso, timpánico en hemiabdomen superior y mate en hemiabdomen inferior**. Ruidos hidroaéreos presentes.

Ud. presume que Sofía puede padecer enfermedad celíaca. Ante esta situación, cuáles son las acciones más adecuadas ? (marque hasta tres opciones).

Seleccione una o más de una:

- a. Indicar sin demora régimen libre de gluten. (No)
- b. Indicar biopsia de intestino delgado aún si no se cuenta con el informe de la serología.? no
- c. Determinar niveles plasmáticos de las vitaminas liposolubles antes de iniciar el régimen libre de gluten.
- d. Indicar régimen libre de gluten sólo después de conocer el informe de la biopsia de intestino delgado.**
- e. Solicitar IgA antitransglutaminasa.**
- f. Corregir el deterioro nutricional antes de indicar la biopsia del intestino delgado.
- g. Confirmar diagnóstico si se observa mejoría al haber iniciado precozmente el régimen libre de gluten.
- h. Demorar la biopsia de intestino delgado si no es posible determinar previamente IgA antitransglutaminasa.**

19- Juan, de **6 años y 3 meses** de edad es traído a la consulta por su madre porque está preocupada por su altura, ya que lo nota más bajo que sus compañeros.

Antecedentes: nacido a término con peso adecuado para la edad gestacional. Sin antecedentes patológicos de

importancia. Vive con su madre, su padre ha fallecido en un accidente y no hay antecedentes patológicos familiares de importancia. La libreta sanitaria de Juan muestra una **curva de talla que a partir de los 2 años de vida se ubica a -2.3 DE** hasta la actualidad. **La velocidad de crecimiento está en percentilo 25.**

La talla materna es de 150.0 cm y según lo que refieren el padre medía alrededor de 160 cm.

Trae una **radiografía de edad ósea 5 años.**

Con respecto al cuadro clínico del paciente, ¿Cuáles de las siguientes conductas son las más adecuadas? (marque hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una:

a. Explicar que alcanzará talla en percentilo 50 luego del empuje puberal.(No, el pc 50 corresponde a 170cm)

b. Explicar que la talla final estaría alrededor de 160.0 cm (+/- 8cm).

c. Explicar a la madre que se trata de un madurador lento. (aparece en la adolescencia)

d. Citar a control ambulatorio en 6 meses.(No, se justifica en el caso)

e. Explicar a la madre que se trata de baja talla familiar. (edad osea no es compatible con edad cronologica)

f. Explicar a la mamá que su niño tiene un retardo constitucional del crecimiento. (aparece en la adolescencia)

g. Solicitar interconsulta con endocrinología.

h. Solicitar laboratorio con panel celíaco y hormonas tiroideas.

20- Es traída por sus padres a la guardia donde usted se desempeña Filomena, de **18 meses con comunicación interventricular, por fiebre de 48 horas de evolución**, acompañándose en las últimas horas **de cianosis progresiva.**

Examen físico: Peso 10.0 kg. **FC: 175 latidos por minuto 100-130**, TA: 80 / 45 mm Hg, **FR: 40 por minuto Normal 20-30**, oximetría con aire ambiental **80 %**, temperatura axilar **38 °C**. Al ingreso, la niña se encuentra en mal estado general, **cianosis intensa generalizada, irritable. Dos ruidos en 4 focos, sin tercer ruido, soplo sistólico en mesocardio, pulsos femorales palpables, pulsos pedios disminuidos, manos y pies fríos. Hipoventilación en hemitórax izquierdo sin ruidos agregados.** Se palpa el borde hepático 3 cm por debajo del

reborde costal derecho.m

Luego de **las medidas terapéuticas iniciales y una vez estabilizado el paciente**. ¿Cuáles de los siguientes estudios diagnósticos iniciales son los más apropiados? (Marque hasta 3 opciones).

Seleccione una o más de una:

a. Tomografía de tórax y abdomen.

b. Ecografía pleural.

c. Hemograma completo, PCR, ionograma, EAB, glucemia, uremia y creatininemia.

d. Teleradiografía de tórax.

e. Determinación de metahemoglobinemia, troponina y factor V.

f. Hemocultivos (2), orina completa y urocultivo.

g. Punción lumbar para citoquímico y cultivo de LCR. (**en el neonato si siempre se hace la PL**)

h. Hepatograma completo y ecografía abdominal.

21- Francisco de **3 años** de edad ingresa a la guardia del hospital, derivado de una Unidad Sanitaria, por presentar **dificultad respiratoria**. Hace **3 días comienza con fiebre de 38°C grados y tos** por lo que consulta a la Unidad Sanitaria cercana a su domicilio donde le indican **salbutamol** en puff, dos disparos cada 6 horas y **paracetamol 2 gotas** por kg para bajar la fiebre. No mejora el cuadro, **aumentan los episodios de tos, la curva térmica asciende a 39°C grados y la madre nota que “está agitado”** por lo que consulta nuevamente al centro de salud, donde le **realizan tratamiento con salbutamol en forma secuencial durante dos horas, por falta de mejoría se decide su traslado al hospital de referencia.**

Antecedentes: RNT/PAEG sin otro antecedente perinatólogico de interés. Como antecedentes patológicos presenta **1 internación por bronquiolitis con hipoxemia a los 8 meses de vida. La madre padeció TBC hace 5 años y completó el tratamiento. Actualmente asintomática.** Tiene 2 hermanos sanos, sin síntomas respiratorios. La madre niega síntomas de Covid 19 en los convivientes. Vacunas completas para la edad.

Examen físico: activo, vigil, conectado con el medio, normohidratado. FR: 35 respiraciones por minuto, FC 128 latidos/min, Temperatura axilar 38,4°C, saturometría de O2 95% AA. Regular entrada de aire en ambos campos pulmonares, con hipoventilación en base pulmonar izquierda.**Tiraje subcostal e intercostal. Percusión**

de columna vertebral mate. Abdomen blando, depresible, indoloro, hígado a 2 cm de reborde costal.

Estudios complementarios: **radiografía de tórax:** diafragmas a nivel del noveno espacio intercostal, se evidencian infiltrados parahiliares bilaterales, con imagen de consolidación en base izquierda y ángulo costofrénico homolateral ocupado. Hemograma: hematocrito 36%, hemoglobina 12 mg %, glóbulos blancos 23.000, **neutrófilos 82% 35-60%**, linfocitos 15%, Plaquetas 270.000/mm³. **Proteína C Reactiva: 45 mg/dl negativo.** PCR COVID 19 : pendiente. Hemocultivos x 2: pendientes

De acuerdo a la sospecha diagnóstica, ¿cuáles son las conductas iniciales más apropiadas? (marque hasta 3 opciones). Fonte: **Flor_co pag 136**

Seleccione una o más de una:

a. Indicar tratamiento con antibiótico parenteral y aislamiento. (porque es neumonía complicada)

b. Administrar oxígeno.

c. Seguimiento ambulatorio con amoxicilina vía oral. (No, porque es neumonía complicada)

d. Solicitar interconsulta con cirugía.

e. Solicitar radiografía de tórax perfil. (ya tenemos rx de torax)

f. Solicitar PPD y radiografía de tórax al grupo familiar. (no, porque la madre teve TBC hace 5 años y completó el tto)

g. Conducta antibiótica expectante hasta resultado de PCR COVID-19.

h. Solicitar ecografía pleural. (por el derrame pleural)

22- La mamá de Marcela consulta preocupada porque ve a su hija, de **16 años, muy delgada**. La nota más **nerviosa**, con algunos **cambios de carácter**. Marcela dice que le gustaría subir de peso a pesar de que come como siempre o más, se **siente ansiosa y por momentos siente palpitaciones, calor y sudoración profusa**. Le cuesta dormir. **Menstruaciones regulares hasta hace 3 meses desde entonces no ha menstruado.**

Al examen físico se **constata descenso de 4 kg con respecto al peso del año anterior**. IMC 17. Frecuencia cardíaca: 120 por minuto, **presión arterial 135/65 mmHg**. Pulso regular. Piel caliente, temperatura axilar 37,1 grados. Examen neurológico normal, se **detecta temblor fino en ambas manos**. Resto del examen físico sin particularidades.

¿Cuáles de las siguientes son las conductas iniciales más apropiadas? (Marque hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una:

a. Solicitar laboratorio con TSH, T3 y T4 libre y anticuerpos antitiroideos.

b. Solicitar interconsulta con nutrición. (NO, porque no parece trastorno alimentario hay que descartar patología orgánica primero)

c. Solicitar consulta **urgente** con salud mental. (No, no parece trastorno alimentario, hay que descartar patología orgánica primero)

d. Solicitar interconsulta **urgente** con endocrinología.

e. Solicitar internación. (NO, es conducta para este caso)

f. Indagar sobre consumo de sustancias psicoactivas.

g. Indicar dieta hipercalórica. (NO, porque no parece trastorno alimentario hay que descartar patología orgánica primero)

h. Solicitar ecg y ecocardiograma.

23- Mónica de **6 años y 3 meses** de edad, sin antecedentes de relevancia, concurre para control de salud. Su mamá está preocupada por “su desarrollo”.

Al examen físico **presenta botón mamario unilateral derecho, vello pubiano Tanner 1**, peso y talla acordes a edad (Pc 10). El resto del examen físico sin particularidades. **DX pubertad precoz (puede ser uni/bi botón mamario unilateral)**

¿Cuáles de las siguientes son las conductas más apropiadas? (Marque hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una:

a. Solicitar ecografía mamaria.

b. Solicitar radiografía de mano con foco en tercer metacarpiano

c. Citar a control en 4 a 6 meses para evaluar el crecimiento y progresión de la pubertad (No, inicio pubertad Normal en niñas 8,3-13,3)

d. Tranquilizar a la mamá y le explica la normalidad de los hallazgos para la edad. (No, inicio pubertad

Normal en niñas 8,3-13,3)

e. Interconsultar con endocrinología.

f. Anticipar a Juana y su madre los próximos cambios puberales esperables.

g. Solicitar RMN de silla turca.

h. Investigar el consumo y/o uso de sustancias con disruptores endócrinos.

24- Llega a la consulta Vanesa de 35 años con su bebé, Ema de **27 días de vida**. Es la primera hija de Vanesa, producto de un **embarazo controlado** y deseado, nacida por cesárea con peso adecuado para la edad gestacional.

Vanesa refiere que la bebé llora de forma muy intensa, no duerme más de 2 hs. seguidas durante la noche. Se alimenta solo de pecho materno, **lo cual es dificultoso por el dolor que le causa amamantar** y el cansancio por no dormir bien. Le comenta que está pensando **en dejar de amamantarla**. Usted nota a Vanesa **angustiada, irritable, cansada y triste**. Durante la consulta **Ema se pone a llorar en el cochecito, su mamá no la mira ni intenta cargarla**.

Al examen físico, la bebé se encuentra **irritable, con dificultades para succionar y evidencia un progreso de peso de 10 gr/ día**.

De acuerdo a lo previamente mencionado, cuáles serían las conductas iniciales más apropiadas? (Puede marcar hasta 3 opciones)

Seleccione una o más de una:

a. Solicitar ecografía abdominal.

b. Solicitar ecografía cerebral.

c. Solicitar radiografía de huesos largos.

d. Citar a control a la brevedad conjuntamente con el papá y algún miembro de la familia ampliada.

e. Indicar simeticona reglada.

f. Solicitar fondo de ojo.

g. Dar pautas de hidratación, alimentación y sueño materno. Complementar con leche de fórmula.

h. Evaluar posible depresión puerperal conjuntamente con salud mental.

25- Benicio, **de 9 meses** de edad es llevado a consulta al servicio de emergencias por sus padres. Refieren que su **hijo presenta deposiciones líquidas abundantes y frecuentes desde hace 6 horas**. No han notado signos compatibles con cólicos ni dolor abdominal.

Examen físico: niño en buen estado general. Temperatura: **37,2°C**. Peso: 8.900 gramos. **Conjuntivas pálidas. Mucosas semihúmedas. Fontanela normotensa. Llanto sin lágrimas.** Frecuencia cardíaca: 100 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria: 40 respiraciones por minuto. **Relleno capilar: menos de 2 segundos. Abdomen blando, con borborignos.**

Respecto al problema de Benicio, las conductas más adecuadas a seguir son: (marque hasta tres opciones):

Seleccione una o más de una: **Diarrea AGuda Normohidratado -PLAN A**

a. Indicar SRO 20 ml/kg cada 20-30 minutos. (No, <1 año: 50 ml de sales después de c/deposición)

b. No indicar antibióticos. (No, porque la mayoría es auto limitada de causa virica, son indicaciones **pag 84 flor_co**)

c. Indicar hidratación parenteral.(No, porque las indicaciones son: -DHT grave c/ shock -TTO oral contraindicado -Fracaso del tto oral (vómitos incohercibles, >perdida que ganancia, distension abdominal empeoramiento de sg clínicos, control inadecuado, PERSISTENCIA DE SG DE DHT LUEGO 4-6HS)

d. Acortar el curso de la diarrea administrando **antibióticos** precozmente.

e. Indicar la colocación de sonda nasogástrica.(No, solo si 4 o + volúmenes en 1 hs el niño no toma la solución falta de madre o acompañante Se administran 20 ml-7kg cada 20' de sales con jeringa. Si vomita iniciar gastroclisis a 5 macrogotas/kg/min (15ml/kg/hs) x 30', y cuando tolera 20 macrogotas/kg/min (60 ml/k/hs))

f. Solicitar coprocultivo y administrar **antibióticos** según la sensibilidad informada.(No, porque la mayoría es auto limitada de causa virica)

g. Continuar con su alimentación habitual y ofrecerle SRO luego de cada vómito y/o deposición líquida.

h. Solicitar ionograma sérico y si los valores son normales, enviarlo a su domicilio.

Datos relevantes

Apgar 0-3-->Reanima

Se <7 se deberán obtener valores cada 5 minutos hasta los 20 minutos o hasta que dos puntajes sucesivos sean más de 8.